



中国医科大学
CHINA MEDICAL UNIVERSITY

临床实践技能 训练指南

（临床医学及相关专业使用）

（第一版）

临床实践教学培训专家委员会 编写

中国医科大学

2021 年 2 月

目 录

一、医学人文素养.....	1
（一）医德医风.....	1
（二）沟通能力.....	1
（三）人文关怀.....	1
二、病史采集.....	1
（一）发热.....	1
（二）皮肤黏膜出血.....	2
（三）疼痛.....	3
1.头痛.....	3
2.胸痛.....	4
3.腹痛.....	5
4.颈肩痛.....	6
5.关节痛.....	7
6.腰痛.....	8
（四）咳嗽与咳痰.....	10
（五）咯血.....	11
（六）呼吸困难.....	12
（七）心悸.....	13
（八）水肿.....	14
（九）恶心与呕吐.....	15
（十）呕血与便血.....	17
（十一）腹泻与便秘.....	19
1.腹泻.....	19
2.便秘.....	20
（十二）黄疸.....	21
（十三）消瘦.....	22
（十四）无尿、少尿与多尿.....	22
1.无尿.....	22
2.少尿.....	23
3.多尿.....	24
（十五）尿频、尿急与尿痛.....	25
（十六）血尿.....	26
（十七）痫性发作与惊厥.....	27

（十八）眩晕.....	29
（十九）意识障碍.....	30
三、体格检查.....	31
医学人文素养.....	31
（一）一般检查.....	31
1.全身状况.....	31
2.皮肤.....	40
3.浅表淋巴结.....	42
（二）头颈部.....	43
1.眼.....	43
2.口（咽部、扁桃体）.....	46
3.颈部.....	47
（三）胸部.....	50
1.胸部视诊.....	50
2.胸部触诊.....	51
3.胸部叩诊.....	52
4.胸部听诊.....	55
5.乳房检查（视诊、触诊）.....	56
6.心脏视诊.....	56
7.心脏触诊.....	57
8.心脏叩诊.....	58
9.心脏听诊.....	59
10.外周血管检查.....	60
（四）腹部.....	61
1.腹部视诊.....	61
2.腹部触诊.....	63
3.腹部叩诊.....	69
4.腹部听诊.....	72
（五）脊柱、四肢、肛门.....	73
1.脊柱检查（1）脊柱弯曲度（2）脊柱活动度（3）脊柱压痛与叩击痛.....	73
2.四肢、关节检查.....	74
3.直肠指检.....	79
（六）神经系统.....	80

1.神经反射.....	80
(1) 深反射跟腱反射、肱二头肌反射、膝反射.....	80
(2) 浅反射（腹壁反射）.....	84
2.脑膜刺激征.....	85
3.病理反射（Babinski 征）.....	86
四、基本操作.....	87
(一) 手术区消毒、铺巾.....	87
情景 1.....	87
情景 2.....	88
(二) 手术刷手法.....	90
(三)（四）穿、脱手术衣；戴无菌手套.....	91
(五) 手术基本操作（切开、缝合、结扎、止血）.....	92
情景 1.....	92
情景 2.....	94
(六) 清创术.....	95
(七) 开放性伤口的止血包扎.....	96
(八) 脓肿切开术.....	97
(九) 换药与拆线.....	98
情景 1.....	98
情景 2.....	99
(十) 吸氧术.....	100
(十一) 吸痰术.....	102
1.吸痰术（经口）.....	102
2.吸痰术（经口鼻）.....	103
(十二) 胃管置入术.....	105
(十三) 三腔二囊管止血法.....	107
(十四) 导尿术.....	109
1.男性导尿术.....	109
2.女性导尿术.....	110
(十五) 动、静脉穿刺术.....	112
1.动脉穿刺术.....	112
2.静脉穿刺术.....	113
(十六) 胸腔穿刺术.....	115
(十七) 腹腔穿刺术.....	117

（十八）腰椎穿刺术.....	119
（十九）骨髓穿刺术.....	120
（二十）脊柱损伤的搬运.....	122
（二十一）四肢骨折现场急救外固定术.....	123
（二十二）心肺复苏.....	124
（二十三）简易呼吸器的应用.....	126
（二十四）穿、脱隔离衣.....	127
五、辅助检查.....	128
六、病例分析.....	128
（一）呼吸系统.....	128
1.慢性阻塞性肺疾病.....	128
2.支气管哮喘.....	130
3.支气管扩张.....	132
4.肺炎.....	134
5.肺结核.....	136
6.肺栓塞.....	138
7.肺癌.....	140
8.呼吸衰竭.....	142
9.胸腔积液.....	144
10.血胸和气胸.....	147
11.脓胸.....	151
12.肋骨骨折.....	153
（二）心血管系统.....	155
1.心力衰竭.....	155
2.心律失常.....	157
（1）室上速.....	157
（2）房扑.....	158
3.冠状动脉性心脏病.....	160
4.高血压.....	166
5.心脏瓣膜病.....	168
6.结核性心包炎.....	170
（三）消化系统.....	172
1.胃食管反流病.....	172
2.食管癌.....	174

3.胃炎.....	176
4.消化性溃疡.....	179
5.消化道穿孔.....	183
6.消化道出血.....	185
7.胃癌.....	187
8.肝硬化.....	189
9.非酒精性脂肪性肝病.....	191
10.肝癌.....	193
11.胆石病、胆道感染.....	194
12.急性胰腺炎.....	196
13.溃疡性结肠炎.....	197
14.克罗恩病.....	199
15.肠梗阻.....	201
16.结、直肠癌.....	202
17.肠结核.....	202
18.结核性腹膜炎.....	203
19.急性阑尾炎.....	205
20.肛管、直肠良性病变.....	206
21.腹外疝.....	209
22.腹部闭合性损伤.....	211
(四) 泌尿系统 (含男性生殖系统)	216
1.急性肾小球肾炎.....	216
2.慢性肾小球肾炎.....	218
3.尿路感染.....	220
4.尿路结石.....	222
5.良性前列腺增生症.....	224
6.慢性肾脏病 (慢性肾衰竭)	226
(五) 女性生殖系统.....	228
1.异位妊娠.....	228
2.盆腔炎性疾病.....	228
3.子宫颈癌.....	228
4.子宫肌瘤.....	228
5.卵巢癌.....	228
6.卵巢囊肿蒂扭转或破裂.....	228

7.前置胎盘.....	228
8.胎盘早剥.....	228
9.妊娠期高血压疾病.....	228
10.自然流产.....	228
11.子宫内膜癌.....	228
12.产后出血.....	228
13.子宫内膜异位症.....	228
(六) 血液系统.....	229
2.再生障碍性贫血.....	231
3.急性白血病.....	233
4.淋巴瘤.....	235
5.特发性血小板减少性紫癜.....	237
(七) 代谢、内分泌系统.....	239
1.甲状腺功能亢进症.....	239
2.甲状腺功能减退症.....	241
3.糖尿病.....	242
(八) 神经系统.....	244
1.脑出血.....	244
2.脑梗死.....	246
3.蛛网膜下腔出血.....	248
4.急性硬膜外血肿.....	249
5.颅骨骨折.....	249
(九) 运动系统.....	250
1.四肢长管状骨骨折.....	250
2.大关节脱位.....	256
3.颈椎病.....	259
4.腰椎间盘突出症.....	261
(十) 风湿免疫性疾病.....	262
1.系统性红斑狼疮.....	262
2.类风湿关节炎.....	262
(十一) 儿科疾病.....	262
1.肺炎.....	262
2.腹泻.....	262
3.维生素 D 缺乏性佝偻病.....	262

4.小儿常见发疹性疾病.....	262
麻疹、风疹、幼儿急疹、水痘、手足口病、猩红热.....	262
5.小儿惊厥.....	263
6.新生儿黄疸.....	263
(十二) 传染病.....	263
1.病毒性肝炎.....	263
2.细菌性痢疾.....	263
3.流行性脑脊髓膜炎.....	263
4.肾综合征出血热.....	263
5.艾滋病.....	263
(十三) 其他.....	263
1.软组织急性化脓性感染.....	263
2.急性乳腺炎.....	263
3.乳腺癌.....	263
4.一氧化碳中毒.....	263
5.急性有机磷农药中毒.....	263
6.镇静催眠药中毒.....	263

一、医学人文素养

- (一) 医德医风
- (二) 沟通能力
- (三) 人文关怀

二、病史采集

- (一) 发热

【简要病史】： 男性，22岁。发热伴双侧颈部和腹股沟淋巴结肿大15天门诊就诊		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
(一) 现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 发病诱因：有无感冒、受凉、劳累、外伤等。		1
(2) 发热特点：起病急缓、程度、热型，有无寒战。		2
(3) 淋巴结肿大：肿大淋巴结如何发现，大小和数量，有无疼痛，是否呈进行性肿大。其他部位淋巴结有无肿大。		3
(4) 伴随症状：有无盗汗、乏力，有无皮肤瘙痒、苍白和皮疹。有无呼吸困难。		1
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊，做过哪些检查，结果如何。		1
(2) 治疗情况。有无应用抗生素、激素等，疗效如何。		1
3.一般情况		
近期精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
(二) 其他相关病史	3	
(1) 有无药物过敏史		0.5
(2) 与该病有关的其他病史：有无血液病、结缔组织病和结核病。传染病史，手术外伤史。有无相关疾病家族史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

（二）皮肤黏膜出血

【简要病史】： 女性，35岁。皮肤出血点、瘀斑伴胸骨压痛3天门诊就诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因、病因 有无劳累、服用药物（如华法林）、接触放射线及外伤。		1
（2）皮肤出血点和瘀点瘀斑：如何发现的，出血的部位、分布、持续时间及特点；注意询问皮肤、黏膜出血的部位、大小、分布、持续天数、消退情况和出血的频率，有无搔痒，是否高出皮面。		2
（3）胸骨压痛：如何发现，有无自觉疼痛。		1
（4）伴随症状：有无鼻出血、牙龈出血、咯血、便血、尿血、近期月经量增多（1分）；有无头晕、乏力、面色苍白，眼花、耳鸣（1分），有无发热、血尿、黄疸、腹痛、关节痛及其他部位骨骼疼痛（1分）。		3
2.诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查。血常规、尿常规、粪常规及隐血、胸部X线或CT、骨髓细胞学检查。		1
（2）治疗情况：是否用过止血药物治疗，疗效如何。特别注意应用抗生素、抗结核药物、激素等情况。		1
3.一般情况		
患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该病有关的其他病史：是否接触过有毒有害物质如苯，甲醛等。有无肝病、肾病、风湿性疾病和出血性疾病及肿瘤病史，有无不洁性生活史、月经史，生育史及家族史。		2.5
二、问诊技巧	2	
（一）条理性强，能抓住重点。		1
（二）能够围绕病情询问。		1

（三）疼痛

1.头痛

【简要病史】： 女性，65岁，头痛2天就诊		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）诱因：有无剧烈运动、情绪激动、过度疲劳、用力排便和剧烈咳嗽、脑外伤		2
症状的特点：头痛起病的急缓程度和病程、头痛部位、性质、强度、持续时间、加重或缓解因素（如体位、咳嗽、喷嚏等）		3
（3）伴随症状：是否伴发热；有无恶心、呕吐，呕吐后头痛是否缓解；有无眩晕；有无精神症状、意识障碍、视力障碍、视野缺损、视觉先兆、复视、眼痛、颈痛；有无抽搐；有无失眠、焦虑、抑郁；有无瘫痪、失语		2
2.诊疗经过		
（1）是否曾到过医院就诊，做过哪些检查（如颅脑CT、MRI、血常规）		1
（2）治疗情况：治疗经过和疗效评价		1
3.一般情况		
近期精神、饮食、睡眠、大小便和体重变化		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史：既往有无类似发作性头痛病史，有无脑血管畸形或脑动脉瘤病史，有无高血压病史，有无血液疾病或抗凝药物史，有无头痛家族史，有无毒物接触史		2.5
二、问诊技巧	2	
（一）条理性强，能抓住重点		1
（二）能围绕病情询问		1

2.胸痛

【简要病史】： 男性，46岁。突发胸痛3小时来诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史内容写在答题纸上		
评分标准	总分 15 分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因、病因：有无运动、饱餐、情绪激动及外伤。		1
（2）胸痛的特点：发病时程，发作时间，疼痛的部位、范围、性质和程度，有无放射痛，急缓程度，每次发作持续时间，间断/持续发作，诱发及缓解因素（与劳累、情绪激动、呼吸、排便、体位的关系）。		4
（3）伴随症状：有无咳嗽、咳痰、咯血，有无发热，有无呼吸困难，有无皮肤苍白、大汗，有无头晕、意识丧失，有无反酸、胃灼热、恶心呕吐。		2
2.诊治经过		
（1）是否到过医院，做过什么检查（如心电图、胸部X线片、心肌坏死标记物）。		1
（2）治疗情况及效果评价。		1
3.一般情况：患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关疾病	3	
1.有无药物过敏史。		1
2.与该病有关的其他病史：既往有无类似发作史，有无高血压、高血脂、糖尿病、心脏病、结核病史，有无烟酒嗜好，有无手术史。		2
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2能围绕病情询问。		1

3.腹痛

【简要病史】 ：女性，46岁。转移性右下腹痛8小时来诊。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因、病因：有无劳累、不洁饮食，生活条件与居住状况，有无服用药物（非甾体类药物）。		1
（2）症状的特点：疼痛的部位、性质和程度、发作的时间（餐前、餐后，有无周期性、节律性）、病程（慢性、急性）、发作急缓程度、范围、有无放射痛、持续时间、加重或缓解因素（体力活动、精神紧张），与呼吸、排便、体位的关系。		3
（3）伴随症状：是否伴发热、寒战，有无呕血黑便，是否伴皮肤巩膜黄染，有无头晕、晕厥，是否伴呕吐、反酸、腹泻，是否有尿频尿急或血尿。		3
2.诊疗经过		
是否到过医院，做过什么检查（如血常规、尿常规、粪常规及隐血、粪便培养、腹部X线、腹部B超、肠镜）和治疗，治疗经过及药疗评价。		2
3.一般情况		
患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该病有关的其他病史：既往有无消化系统疾病病史，有无结核病史或结核病患者接触史，有无胃肠道手术史（肠粘连致肠梗阻），有无痔疮、肛裂病史，伴腹泻患者需问有无细菌性痢疾、阿米巴痢疾等病史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能够围绕病情询问。		1

4.颈肩痛

【简要病史】 ：患者杨某，女性，53岁。因反复颈肩部疼痛3年，加重伴左上肢反射痛3周来诊。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10.5	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病原因、诱因：外伤、过度疲劳、工作姿势、睡眠姿势等。		1
（2）症状特点：突然发病/缓慢起病；疼痛持续情况；有无缓解及缓解因素（休息、制动、特殊体位）；颈肩痛的具体范围、最明显部位、疼痛性质（急性锐痛/持续胀痛/烧灼痛等）和程度（可否忍受，VAS评分等）；上肢放射痛的具体范围、最明显部位、疼痛性质（急性锐痛/持续胀痛/烧灼痛等）和程度（可否忍受，VAS评分等）。		3
（3）伴随症状：有无肢体麻木、无力、笨拙、束带感、精细活动障碍；有无发热、晨僵、皮疹；有无精神症状、意识障碍、视力障碍、眼痛或颈痛、癫痫发作等。		3
2.诊疗经过		
（1）是否到医院就诊，什么医院什么科室； （2）做过哪些检查（颈椎X光片、CT、MRI等；血尿常规、生化检查、血沉、风湿免疫项目；神经电生理检查/肌电图检查等）； （3）治疗及用药情况、疗效如何。		3
3.一般情况		
患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		0.5
（二）其他相关病史	2.5	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该疾病有关的其他重要病史：既往有无结核、风湿病/类风湿、肿瘤等遗传病史，颈部外伤或手术史。		2
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，重点突出		1
2.能够围绕病情询问		1

5.关节痛

【简要病史】： 患者杨某，男性，65岁。因膝关节疼痛6个月余，加重2天来诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10.5	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因、病因：外伤、剧烈运动、过度劳累、着凉等。		1
（2）症状特点：疼痛的具体部位、出现时间、起病缓解、病程进展、性质（是否为游走性，有无红肿热痛、关节畸形）、程度、与天气及活动量的关系。		2
（3）伴随症状：是否伴有发热、畏寒、乏力盗汗、消瘦纳差；局部有无红肿热、疼痛是否对称、有无晨僵、关节畸形、心悸、饮酒后疼痛；是否伴有皮肤红斑、光过敏、是否伴有皮肤紫癜、腹痛；有无肌肉疼痛、肌无力、肌萎缩、淋巴结大、肝脾大。		4
2.诊疗经过		
（1）是否到医院就诊，什么医院什么科室。 （2）做过哪些检查（膝关节X线、磁共振、血常规、生化检查、血沉、风湿免疫项目等）。 （3）治疗及用药情况、疗效如何，特别关注抗生素、抗结核药物、激素的应用情况。		3
3.一般情况		
患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		0.5
（二）其他相关病史	2.5	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该疾病有关的其他重要病史：既往有无类似发作史，既往有无结核、风湿病史、传染病、肿瘤病史及手术史。		2
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，重点突出。		1
2.能够围绕病情询问。		1

6.腰痛

【简要病史】 ：患者王某，男性，33岁。因腰部疼痛伴行走受限1天来诊。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病原因、诱因：外伤、搬持重物、剧烈运动或腰部扭转、过度疲劳、工作睡眠姿势、着凉等。		1
（2）症状特点：突然发病/缓慢起病；疼痛持续情况；有无缓解及缓解因素（休息、制动、特殊体位）；腰痛的具体范围、最明显部位、疼痛性质（急性锐痛/持续胀痛/烧灼痛等）和程度（可否忍受，VAS评分等）；有无下肢放射痛，如有则：具体范围、最明显部位、疼痛性质（急性锐痛/持续胀痛/烧灼痛等）和程度（可否忍受，VAS评分等）。		3
（3）伴随症状：有无肢体麻木、无力、活动障碍；有无发热、晨僵、乏力、盗汗、体重下降等；有无尿频尿急、排尿困难、尿量及性状异常、反酸嗝气、腹痛腹泻、排便困难。		3
2.诊疗经过		
（1）是否到医院就诊，什么医院什么科室； （2）做过哪些检查（腰椎X光片、CT、MRI等；血尿常规、生化检查、血沉、风湿免疫项目；神经电生理检查/肌电图检查等）； （3）治疗及用药情况、疗效如何。		2
3.一般情况		
患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该疾病有关的其他重要病史：既往有无类似发作，既往有无结核、风湿病/类风湿、强制性脊柱炎、肿瘤等遗传病史，腰部外伤或手术史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，重点突出。		1
2.能够围绕病情询问。		1

【简要病史】： 患者吴某，男性，55岁。因腰痛2周，加重伴血尿2天来诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因：外伤、剧烈运动、过度疲劳、工作睡眠姿势、着凉、感染等		1
（2）症状特点：腰痛的起病情况、具体部位、性质、程度、有无放射痛，持续性的还是阵发性的，加重或缓解因素；血尿的具体性状、全程血尿与否、有无凝血块、间歇性还是持续性、与腰痛的关系。		3
（3）伴随症状：有无肢体放射痛、麻木、无力、活动障碍；有无尿频、尿急、尿痛、排尿困难、泡沫尿、尿量异常；有无发热、有无其他部位出血表现；		3
2.诊疗经过		
（1）是否到医院就诊，什么医院什么科室； （2）做过哪些检查（泌尿系超声、CT、IVP；血尿常规、生化检查、血沉、风湿免疫项目等）； （3）治疗及用药情况、疗效如何。		2
3.一般情况		
患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该疾病有关的其他重要病史：既往有无类似发作史，既往有无结核、尿路结石、出血性疾病、风湿免疫疾病、肿瘤病史及手术史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，重点突出。		1
2.能够围绕病情询问。		1

(四) 咳嗽与咳痰

【简要病史】 ：女性，32岁。发热伴咳嗽咳痰3天门诊就诊		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因：有无感冒、受凉、劳累等。		1
（2）发热特点：起病急缓、程度、热型，有无寒战。		2
（3）咳嗽：性质、音色、程度，发生的时间和规律，加重或缓解因素。		2
（4）咳痰：痰的性状和量		1
（5）伴随症状：有无乏力、盗汗，有无咯血、胸痛、呼吸困难，有无头痛和肌肉酸痛。		1
2.诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查（血常规、胸部X线、痰病原学检查），结果如何。		1
（2）治疗情况。应用过哪些药物（是否应用过抗生素、祛痰、止咳药物），疗效如何。		1
3.一般情况		
近期精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
（1）有无药物过敏史		0.5
有无慢性肺部疾病、心脏病及糖尿病等病史、肝病、肾病史，有无传染病史，手术外伤史。个人史：烟酒嗜好，工作性质及环境。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

(五) 咯血

【简要病史】： 女，45岁，间断痰中带血1年，加重3天。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史内容写在答题纸上		
评分标准：	总分 15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）诱因（包括发病初期及本次加重）：气道异物、着凉、呼吸道感染、劳累		1
（2）症状特点：		
① 关于出血部位（咳出还是呕出）：口腔、鼻腔、消化道		0.5
② 出血量		1
③ 出血颜色/性状		1
（3）伴随症状：		
① 发热、咳嗽、咳痰		1
② 胸痛、呼吸困难/气短		1
③ 心悸、晕厥		0.5
④ 身体其他部位出血，比如皮肤粘膜		0.5
⑤ 杵状指		0.5
2.诊疗过程：		
（1）是否到医疗机构就诊，做过检查，检查项目有哪些（血常规、凝血功能、胸片X线还是CT、气管镜、痰病原学检查）		1
（2）治疗经过及疗效评价（具体治疗药物及措施）		1
3.一般情况		
发病以来精神状态、饮食、睡眠、大小便、体重变化情况		1
（二）其他相关病史	3	
1.药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史		
（1）慢性肺部疾病（幼年时期的肺炎/麻疹/肺结核）、		1
（2）有无传染病接触史（周围同事或共同居住人有无结核病史）		0.5
（3）吸烟史		0.5
（4）有无心血管疾病、糖尿病病史，职业及工作环境情况，疫区居住史，嗜好		0.5
二、问诊技巧	2	

(一) 条理性强, 能抓住重点		1
(二) 能围绕病情询问		1

(六) 呼吸困难

【简要病史】 ：女性，70 岁。呼吸困难 3 周来诊。既往有高血压病史多年。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史内容写在答题纸上		
评分标准	总分 15 分	
一、问诊内容	13 分	
(一) 现病史	10 分	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 起病诱因、病因：有无劳累、感染、情绪激动。		1分
(2) 呼吸困难的特点：发病时程，发作时间，呼吸困难程度，是阵发性还是持续性，有无夜间发作，有无静息时发作，加重或缓解因素（与体位及活动的关系）。		3分
(3) 伴随症状：有无胸痛，有无心悸、晕厥，有无双下肢浮肿，有无发热、咳嗽、咳痰、咯血。		2 分
2.诊治经过		
(1) 是否到过医院，做过什么检查（如心电图、心彩超、心肌坏死标志物、心衰标记物、肺CT、肺功能）。		1 分
(2) 治疗情况及效果评价。		1 分
3.一般情况：患病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1 分
4.高血压的血压水平、诊治、服药及控制情况		1 分
(二) 其他相关疾病	3	
1.有无药物过敏史。		0.5 分
2.与该病有关的其他病史：既往有无慢性肺部疾病、结核病史，有无心脏病，有无贫血、肾病，有无糖尿病，有无烟酒嗜好，有无胸部手术外伤史。		2.5分
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1 分
2能围绕病情询问。		1 分

(七) 心悸

【简要病史】： 男性，27岁，突发心悸1小时来诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1. 根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病的病因，诱因：有无劳累、精神紧张、上呼吸道感染、剧烈运动等。		2
（2）心悸：是否突发突止，发作频率，持续时间，发作时脉率与心率，诱发缓解因素。		2.5
（3）伴随症状：是否伴有胸痛、发热、呼吸困难、头晕乏力，是否伴有黑蒙晕厥或者抽搐，有无消瘦、手抖、出汗。		2.5
2. 诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查：心电图，动态心电图，采血化验：血常规，甲功等。		1
（2）治疗情况：是否使用过抗心律失常药物，效果如何。		1
3. 一般情况		
近期饮食、睡眠、大小便和体重变化情况。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史：有无高血压，冠心病，慢性呼吸系统疾病，甲亢，贫血及神经官能症等。有无烟酒嗜好。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能够围绕病情询问。		1

（八）水肿

【简要病史】： 男性，67岁，双下肢水肿半年，气短2天来诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1. 根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病的病因，诱因：有无劳累、精神紧张、上呼吸道感染、剧烈运动或容量负荷增加等。		1
（2）水肿的特点：发生的缓急与程度，是否为凹陷性及对称性，其他部位有无水肿，加重与缓解因素		2
（3）气短：发病时程，发作时间，气短程度，是阵发性还是持续性，有无夜间发作，有无静息时发作，加重或缓解因素		2
（4）伴随症状：是否伴有发热、咳嗽咳痰，有无胸痛、心悸，有无头晕乏力，有无腹胀及尿少，有无消瘦多汗		2
2. 诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查：心电图，心脏彩超，下肢静脉彩超，采血化验：血常规，甲功等。		1
（2）治疗情况：是否使用过利尿剂等药物，效果如何。		1
3. 一般情况		
近期精神、饮食、睡眠、大小便和体重变化情况。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史：有无高血压，冠心病，甲状腺功能亢进症，糖尿病、慢性肾病、肝病病史。有无慢性肺部疾病、营养不良、贫血等。有无烟酒嗜好。有无心脏病家族史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能够围绕病情询问。		1

(九) 恶心与呕吐

【简要病史】： 女性，38岁，恶心呕吐2天来诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
(一) 现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 有无明确的原因或诱因：有无进食不适或进食不洁饮食、饮酒、口服药物或静脉用药，咽部刺激、体位改变、劳累及精神刺激。		1
(2) 症状的特点：呕吐的起病情况（突然发病或缓慢起病），呕吐的时间（晨起、晚上、夜间），呕吐与进食的关系（餐后即刻呕吐、餐后数小时呕吐，餐后很久呕吐或数餐后呕吐），持续性呕吐或间歇性呕吐，呕吐程度、频率，呕吐前有无恶心，呕吐的特点（是否喷射样呕吐），呕吐物的性质和量（隔宿食、粪臭味、是否含胆汁、大量酸性胃内容物），加重和缓解的因素。		5
(3) 伴随症状：是否伴有腹痛、腹泻、发热、黄疸（皮肤瘙痒）、头痛、眩晕，有无口干、口渴、多饮、多尿、消瘦，已婚妇女是否伴有停经。		1
2.诊疗经过		
(1) 是否到过医院，做过什么检查，如血常规、尿常规、便常规、肝功能、肾功能、血糖等化验，是否行X线钡餐、胃镜、腹部B超等检查。		1
(2) 治疗情况：是否用过药物（具体药物名称和剂量及用药时间）和治疗后症状是否缓解。		1
3.一般情况		
发病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
(二) 其他相关病史	3	
1.有无药物及食物过敏史		0.5
2.有无与该病有关的其他病史：如胃肠道（胃炎、消化性溃疡、肝胆胰疾病、糖尿病等）及中枢神经系统基础疾病，有无腹部手术史、颅脑外伤史。		2.5
3.（女性注意询问）月经史及婚育史。		
二、问诊技巧	2	

1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

【简要病史】： 男性，48岁，上腹痛伴呕吐5天来诊。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）诱因：有无进食不适或进食不洁饮食、饮酒、服用药物及精神刺激等。		1
（2）腹痛：起病缓急，性质、程度、具体部位，有无规律，有无放射或转移，与进食的关系，加重及缓解因素，腹痛与呕吐的关系。		2.5
（3）呕吐：起病情况（突然发病或缓慢起病），发生的时间、程度、频率，有无恶心，呕吐与进食的关系，呕吐的特点，呕吐物的性质和量，与腹痛的关系，加重和缓解的因素。		2.5
（4）伴随症状：是否伴有反酸、烧心、腹泻，有无发热、头晕头痛、心悸，有无黄疸（皮肤瘙痒）		1
2.诊疗经过		
（1）是否到过医院，做过什么检查，如血常规、尿常规、便常规、肝功能、肾功能、血糖等化验，是否行X线钡餐、胃镜、腹部B超等检查。		1.5
（2）治疗情况：是否用过药物（具体药物名称和剂量及用药时间，如止吐药物或胃粘膜保护剂）和治疗后症状是否缓解。		1
3.一般情况		
发病以来精神、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		0.5
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物及食物过敏史		1
2.有无与该病有关的其他病史：有无胃炎、消化性溃疡、肝胆胰疾病、糖尿病等基础疾病，有无手术史。		2
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

(十) 呕血与便血

【简要病史】 ：男性，47岁，上腹部不适、呕血1天。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）诱因或病因：有无饮酒，饮食不当（进食粗糙和、或刺激性食物）、服用药物、剧烈呕吐、劳累、精神因素、外伤等。		1
（2）呕血的特点：起病时间，初发或复发，呕血的次数，呕血的量及颜色（鲜红、咖啡样、暗红色、有无血块，）是否混有食物。		2.5
（3）大便情况：是否有黑便，和/或血便。		1
（4）伴随症状：有无腹痛、反酸、烧心、腹胀、乏力、皮肤巩膜黄染（皮肤瘙痒）、皮肤和齿龈（和/或）鼻出血、有无周围循环衰竭的表现（口渴、尿少、头晕、心悸、意识障碍）。		3
2.诊疗经过		
（1）是否到过医院，做过什么检查（血、尿、便常规，肝功能等化验，是否行X线钡餐、胃镜、腹部B超等检查。）		1
（2）治疗情况：是否用过药物（具体药物名称和剂量及用药时间）和治疗后症状是否缓解。		1
3.一般情况		
发病以来精神、饮食、睡眠、小便及体重变化。		0.5
（二）其他相关病史	3	
1.是否有药物过敏史。		0.5
2.与该病有关的其他病史，有无胃炎、消化性溃疡、肝病、全身出血性疾病病史，有无手术史，有无输血史，有无饮酒嗜好，有无肿瘤家族史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

【简要病史】： 男性，27岁，间断上腹隐痛2年，呕血伴黑便1天。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容		
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）诱因：有无饮酒，饮食不当（进食粗糙、坚硬或刺激性食物）、服用药物、剧烈呕吐、劳累、精神因素、季节因素等。		1
（2）腹痛的特点：部位、性质、程度、规律、发作频率及持续时间、有无放射，与进食的关系，加重及缓解因素。		2
（3）呕血的特点：起病时间，初发或复发，呕血的次数，呕血的量及颜色（鲜红、咖啡样、暗红色、有无血块，）是否混有食物。		2
（4）伴随症状：有无黑便、便血、反酸、烧心、腹胀、乏力、皮肤巩膜黄染、皮肤黏膜和其他部位出血、有无周围循环衰竭的表现（口渴、尿少、头晕、心悸、意识障碍）。 黑便情况：次数，性状和量。 便血：量，间歇性或持续性，有无黏液、脓液，血与粪便是否相混。		2
2.诊疗经过		
（1）是否到过医院，做过什么检查（血、尿、便常规，肝功能等化验，是否行X线钡餐、胃镜、腹部B超等检查。）		1
（2）治疗情况：是否用过药物（具体药物名称和剂量及用药时间）和治疗后症状是否缓解。		1
3.一般情况		
发病以来精神、饮食、睡眠、小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.是否有药物过敏史。		0.5
2.与该疾病有关的其他病史，有无消化性溃疡史、近期服非甾体类抗炎药史、大面积烧伤史、颅脑手术史、肝脏病史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

（十一）腹泻与便秘

1.腹泻

【简要病史】： 男性，28岁，腹泻2天		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因、病因：有无不洁饮食、旅行、聚餐、药物、精神紧张		1
（2）症状的特点：起病的急缓、病程、腹泻性质（持续性、间歇性、复发性），腹泻次数、粪便性质、与腹痛的关系（便后腹痛是否缓解），其他加重或缓解因素		3
（3）伴随症状：是否伴有发热、里急后重、消瘦、皮疹或皮下出血、腹部包块、严重脱水、关节痛或者关节肿胀		3
2.诊疗经过		2
是否到过医院，做过什么检查（如便常规、潜血、血常规、肠镜、钡剂灌肠）和治疗，治疗经过和药效评价		
3.一般情况		1
发病以来精神、饮食、睡眠、尿量、体重变化		
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史：有无慢性细菌性痢疾、阑尾炎、炎症性肠病、肠寄生虫病、肿瘤及精神病史。有无胃肠道手术史，有无地方病及流行区居住史，有无烟酒嗜好，有无遗传病史及肿瘤家族史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点		1
2.能围绕病情询问		1

2.便秘

【简要病史】： 女性，34岁，便秘2个月		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因、病因：饮食及生活环境改变，精神因素（生活大事件、压力大）		1
（2）症状的特点：起病急缓、病程、性质（持续性、间歇性、复发性），大便的次数和量，粪便的性状、颜色、加重或缓解因素		3
（3）伴随症状：是否有腹部包块、肠绞痛、腹泻与便秘交替、生活环境改变、精神紧张等		3
2.诊疗经过		
是否到过医院，做过什么检查（如便常规、潜血、血常规、肠镜、钡剂灌肠）和治疗，治疗经过和药效评价，是否依赖泻药		2
3.一般情况		
发病以来精神、饮食、睡眠、大小便、体重变化		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史：既往有无类似发作史，有无甲减、糖尿病、肠易激综合征、肠结核、肿瘤等遗传病家族史		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点		1
2.能围绕病情询问		1

(十二) 黄疸

【简要病史】 ：男性，46岁，周身皮肤黄染4天，既往有肝炎病史20年		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因、病因：有无感染、外出旅游、不洁饮食、副钥匙、饮酒史		1
（2）症状：黄疸开始的部位、速度、程度、大小便颜色。黄疸时间与波动（区别梗阻性与肝细胞性）		3
（3）伴随症状：有无发热、皮肤瘙痒、恶心呕吐、厌油、腹痛		3
2.诊疗经过		
是否到过医院，做过哪些检查（血常规、尿便常规、肝肾功。腹部B超）和治疗，治疗经过及药效评价。		2
3.一般情况		
患病以来精神、饮食（有无食欲减退）、睡眠、大小便、体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史：既往有无类似病史，有无肝炎及肝炎患者接触史，有无肝胆系统病史及消化系统病史。服药史、大量饮酒史、疫区旅游史或疫水接触史，家族中是否有类似病史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点		1
2.能围绕病情询问		1

(十三) 消瘦

(十四) 无尿、少尿与多尿

1. 无尿

【简要病史】： 简要病史：患者，女性，50岁。输血后腰痛、无尿8小时急诊入院。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1. 根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因：发生无尿的诱因、缓急、持续时间、发作情况		1
（2）输血原因及输血量：有无突然烦躁不安、胸闷、头胀痛，继而腰背部剧痛、呼吸困难、恶心、冷汗、发绀、寒战高热等		3
（3）排尿情况：具体尿量（24小时），尿色变化。		1
（4）发病因素：血型是否相符、采血日期、储存情况等		2
2. 诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查？血常规、血型、肝功、肾功、血电解质、IgE、嗜酸性粒细胞计数、溶血项、尿常规。		1
（2）治疗情况：是否用过利尿剂，是否用过碳酸氢钠碱化尿液，是否使用过糖皮质激素，是否行血液透析，疗效如何。		1
3. 一般情况		
发病以来精神、睡眠、大便、体重变化情况。		1
（二）其他相关病史	3	
（1）有无药物过敏史。		0.5
（2）有无与该病有关的其他病史：有无输血史（注意ABO、Rh血型）、有无肾病史。		2.5
二、问诊技巧 只做评分标准，不应写在答题纸上	2	
1. 条理性强，能抓住重点。		1
2. 能为让病情询问。		1

2.少尿

【简要病史】 ：男性，18岁，颜面及双下肢水肿1周，尿量较前减少3天来诊。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因：有无受凉、劳累、感染（感染与出现症状的潜伏期时长）。		1
（2）水肿：首发部位、发展顺序、速度、累及范围、程度、是否凹陷性、双侧是否对称、加重或缓解因素。		2
（3）排尿情况：具体尿量（24小时），有无血尿、泡沫尿。		2
（4）伴随症状：有无发热、心悸、呼吸困难，有无纳差、呕吐、腹胀、腹痛、腹泻。有无口腔溃疡、光过敏、脱发、皮疹、关节痛。		2
2.诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查？血常规、肝功、肾功、血电解质、血脂、尿常规、24小时尿蛋白定量、尿微量蛋白。		1
（2）治疗情况：是否用过利尿剂、白蛋白、激素、免疫抑制剂，疗效如何。		1
3.一般情况		
发病以来精神、睡眠、大便、体重变化情况。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.有无与该病有关的其他病史：有无心脏病、肝肾疾病、甲状腺疾病、结缔组织病、营养不良、肿瘤、结石、糖尿病、高血压。		2
3.有无其他疾病或长期用药史：非甾体止痛药、化疗药、中药等。有无烟酒嗜好，职业及工作环境情况。		0.5
二、问诊技巧 只做评分标准，不应写在答题纸上	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能让病情询问。		1

3.多尿

【简要病史】： 简要病史：患者，女性，50岁。多尿3个月入院。		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因：有无使用利尿剂、精神紧张，有无劳累、饮食不规律。		1
（2）尿量增加：排尿次数，具体尿量，夜尿路和日尿量的差别。		2
（3）伴随症状：有无血尿、尿频、尿急、尿痛。有无口渴、喜冷饮、喜流食。有无体重下降、心悸、怕热、多汗、手颤、颈部增粗。有无复视、视野缺损、视物模糊。有无听力障碍，有无头晕、头痛。		4
2.诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查？尿常规、尿渗透压、尿糖、血糖、肾功、血电解质，泌尿系超声、头CT、头MRI。		1
（2）治疗情况：是否用过药物治疗，疗效如何。		1
3.一般情况		
发病以来精神、睡眠、大便、体重变化情况。		1
（二）其他相关病史	3	
（1）有无药物过敏史。		0.5
（2）有无与该病有关的其他病史：有无结核病、肾脏疾病、尿路感染、泌尿系肿瘤、中枢神经系统疾病、精神疾病病史，有无糖尿病病史，有无遗传性疾病病史。		2.5
二、问诊技巧 只做评分标准，不应写在答题纸上	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能让病情询问。		1

(十五) 尿频、尿急与尿痛

【简要病史】 ：女性，48岁。尿频、尿急、尿痛1周门诊就诊		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因：有无劳累、着凉或憋尿，是否为月经期，有无接受导尿、尿道器械检查等。		2
（2）尿频：排尿频率，每次排尿量，夜尿次数。		1
（3）尿急：程度，有无尿失禁。		1
（4）尿痛：疼痛部位，疼痛性质，程度，出现时间。		1
（5）伴随症状：有无尿色改变，有无排尿困难，有无畏寒、发热、盗汗，有无腰腹痛。		2
2.诊疗经过		
（1）是否曾就诊，做过哪些化验检查（如尿常规、尿培养、肝肾功能、泌尿系超声等）。		1
（2）治疗情况：用过哪些药物，用过哪种抗生素，效果如何。		1
3.一般情况		
发病以来精神状态、饮食、睡眠、大便和体重变化情况。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物食物过敏史。		0.5
2.既往有无类似病史，有无肝炎结核肿瘤病史，有无高血压、糖尿病病史，有无泌尿系统结石病史，有无盆腔疾病史，有无外伤、手术史，月经与婚育史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，思路清晰，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问病史。		1

(十六) 血尿

【简要病史】 ：男性，71岁。右侧腰痛伴血尿2周门诊入院		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）发病诱因：有无剧烈运动、腰部外伤，有无导尿或泌尿道器械检查，有无前驱感染，有无服用抗凝药。		1
（2）腰痛：起病缓急，具体疼痛部位、疼痛性质、程度，持续性或者阵发性，有无恶心呕吐，与体位或活动的关系。		2
（3）血尿：尿的颜色（洗肉水样、暗红色、鲜红色），持续性或者阵发性，血尿性质（全程、初始、终末），与腰痛的关系，有无凝血块及凝血块形状。		2
（4）伴随症状：有无尿频、尿急、尿痛、排尿困难、排尿中断、水肿、泡沫尿、畏寒发热，有无皮肤粘膜出血点。		2
2.诊疗经过		
（1）是否曾就诊，做过哪些化验检查（如尿常规、KUB平片、腹部超声等）。		1
（2）治疗情况：用过哪些药物，效果如何。		1
3.一般情况		
发病以来精神状态、饮食、睡眠、大便和体重变化情况。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物食物过敏史。		1
2.既往有无类似病史，有无肝炎结核肿瘤病史，有无高血压、糖尿病病史，有无泌尿系统结石、痛风、甲旁亢病史，有无盆腔疾病史，有无外伤、手术史，月经与婚育史。		2
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，思路清晰，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问病史。		1

(十七) 痫性发作与惊厥

【简要病史】 ：男性，35岁，突发一过性意识不清、抽搐2小时来诊		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
(一) 现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
(1) 诱因：有无感染、外伤、饮酒、服用药物或毒品、精神刺激、过度劳累、睡眠不足、心悸、胸闷胸痛		2
(2) 症状的特点：起病的急缓程度和病程、发作持续时间、发作表现（发作时是否有意识丧失、面部颜色、瞳孔散大、尿便失禁、舌咬伤等）、部位（全身性或局限性）、性质（持续强直性或间歇阵挛性）、加重或缓解因素		3
(3) 伴随症状：是否伴发热；是否伴意识障碍；是否头痛；是否有精神异常		2
2.诊疗经过		
(1) 是否曾到过医院就诊，做过哪些检查（如颅脑CT、MRI、脑电图、心电图、血液化验）		1
(2) 治疗情况：治疗经过和疗效评价		1
3.一般情况		
近期精神、饮食、睡眠、大小便和体重变化		1
(二) 其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史		0.5
2.与该病有关的其他病史：既往有无类似发作，有无家族史，有无心脏疾病、糖尿病、肝脏疾病、肾脏疾病等内科病史，有无精神病史		2.5
二、问诊技巧	2	
(一) 条理性强，能抓住重点		1
(二) 能围绕病情询问		1

【简要病史】： 女孩，3岁，发热3天，惊厥2次来诊		
要求： 请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）诱因：有无受凉、上呼吸道感染、饮食不当		1
（2）发热：程度、热型，有无寒战		2
（3）惊厥：发作持续时间、发作时间、发作表现，惊厥前的体温，发作时有无意识丧失、大小便失禁、发绀，惊厥停止后的精神状态。		3
（4）伴随症状：有无咳嗽、头痛、呕吐，有无皮疹		1
2.诊疗经过		
（1）是否曾到过医院就诊，做过哪些检查（如颅脑CT、MRI、脑电图、心电图、血液化验）		1
（2）治疗情况：治疗经过和疗效评价		1
3.一般情况		
近期精神、饮食、睡眠、大小便和体重变化		1
（二）其他相关病史	3	
1.出生史，喂养史，生长发育情况。		1
2.有无药物过敏史，预防接种史		1
3.与该病有关的其他病史：既往有无类似发作，有无传染病接触史。有无热性惊厥家族史。		1
二、问诊技巧	2	
（一）条理性强，能抓住重点		1
（二）能围绕病情询问		1

(十八) 眩晕

【简要病史】 ：女性，45岁。阵发性眩晕伴恶心呕吐3天，加重2小时来诊。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因：有无发热感染、劳累、精神因素、服用药物及外伤史。		1
（2）眩晕：发作时间、频率、性质、持续时间，眩晕特征（外界物体旋转或自身旋转、漂浮感、晃动感、倾倒），眩晕与体位的关系，加重或缓解因素。		2
（3）恶心呕吐：次数、呕吐物性质和量，是否为喷射性呕吐，加重或缓解因素。		2
（4）伴随症状：有无耳鸣、听力减退、耳痛，视物模糊，视物旋转，视物双影，有无心悸、出汗、发热、意识不清、站立或行走不稳。		2
2.诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查（如血常规、血生化、头颅CT、脑彩超、耳鼻喉科检查等）。		1
（2）治疗情况：是否应用过抗眩晕和止吐药物，效果如何。		1
3.一般情况		
患病以来精神体力、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该病有关的其他病史：有无耳病病史（中耳炎、耳石症，耳毒药物使用史），有无神经系统疾病病史，有无高血压病、糖尿病、颈椎病、眼科疾病病史，有无晕车及眩晕家族史。月经史及婚育史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

(十九) 意识障碍

【简要病史】 ：男性，62岁。突发意识不清1小时来诊。		
要求 ：请围绕以上简要病史，将应该询问的现病史及相关病史的内容写在答题纸上		
评分标准	总分15分	
一、问诊内容	13	
（一）现病史	10	
1.根据主诉及相关鉴别询问		
（1）起病诱因：有无外伤、感染、情绪激动、劳累，有无农药接触、口服镇静药物史，有无饮酒史，有无煤气接触史。		1
（2）意识不清：发病缓急，意识障碍程度（嗜睡、昏睡和昏迷），意识障碍进展过程和缓解情况，持续时间。		3
（3）伴随症状：有无发热、出汗、恶心呕吐、心悸、抽搐，有无呼吸困难，有无皮肤黏膜瘀点瘀斑，有无跌倒和外伤，呼气时有无烂苹果或者大蒜味。		3
2.诊疗经过		
（1）是否曾到医院就诊，做过哪些检查（如血常规、血糖、肝功能、肾功能、离子化验，头颅肺部CT、心电图、脑脊液检查等）。		1
（2）治疗情况：是否应用过促醒药物，效果如何。		1
3.一般情况		
近期精神体力、饮食、睡眠、大小便及体重变化。		1
（二）其他相关病史	3	
1.有无药物过敏史。		0.5
2.与该病有关的其他病史：有无类似病史，有无神经系统及精神系统疾病病史，有无糖尿病、高血压病、心脏病、外伤、癫痫病史，有无肿瘤及甲状腺疾病病史，有无烟酒嗜好。有无遗传性疾病病史，有无精神、神经系统疾病家族史。		2.5
二、问诊技巧	2	
1.条理性强，能抓住重点。		1
2.能围绕病情询问。		1

三、体格检查

医学人文素养（3分）

评分标准	分值(分)
（一）仪表端庄，举止大方（0.25分），着装（工作服）整洁（0.25分）。	0.5分
（二）体格检查前向被检者告知：主动自我介绍（0.25分），说明检查目的及注意事项（0.25分）。	1分
（三）与被检者沟通时：语言文明，态度和蔼（0.5分）	0.5分
（四）体格检查时：动作规范，认真细致，注意保护隐私（0.5分），体检过程中及结束时，有体现关爱被检者的动作（0.5分），	1分

（一）一般检查

1.全身状况

（1）生命征（体温、脉搏、呼吸、血压）

①测体温（4分）

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
检查者戴帽子、口罩（0.2），患者休息30分钟，移走周围的冷热源（0.1），被检查者取坐位或仰卧位，检查者站在被检查者右侧。（0.2分）	0.5
（二）测量方法	
1.取消毒后体温计，观察并确认体温计水银柱是否处于低温位置（0.5分），如高于35℃，则甩到35℃以下（1分）。	1.5
2.考生先用手触摸被检者腋窝（查影响体温的因素：汗液、有无致热或降温物品）（0.5分），将体温计头端置于被检者腋窝深处夹紧（0.5分）。	1
3.夹紧体温计10分钟后读数（应为10分钟）（0.5分）。	0.5
（三）报告测量结果	
考生读数（读数正确得分，不正确不能得分）。 （考官可能事先准备三支不同体温的体温计，执考时选择其中一支体温计让考生当场读数）	0.5

②测脉搏（4分）

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者取坐位或仰卧位，检查者站在被检查者右侧（0.5分）。	1
（二）测量方法	
考生示、中、环指三指并拢，指腹置于被检者腕部桡动脉处，以适当压力触诊桡动脉搏动。（1分） 触诊时间至少15~30秒钟，数其脉率，以每分钟多少次表示，并向考官报告检查结果（0.5分）。双侧桡动脉进行对比检查（0.5分）。	2
（三）报告测量结果	
向考官报告被检者脉搏为*次/分（0.4），脉律整齐（0.4分），脉搏强弱中等，未触及异常脉搏（0.2）	1

③测呼吸频率（4分）

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者取坐位或仰卧位，检查者站在被检查者右侧（0.5分）。	1
（二）测量方法	
告知被检者取舒适体位，充分暴露其胸部及腹部，在自然地柔和灯光下，以便观察（2分）	2
（三）报告测量结果	
至少观察1分钟（0.4），向考官报告被检者男性/女性，以腹式或胸式呼吸为主（0.3），呼吸频率（0.3分）	1

④测血压（4分）

评分标准	分值（分）
（一）测量前准备	
检查者戴帽子、口罩（0.1分），被检查者取坐位或仰卧位，检查者站在被检查者右侧，嘱被检者在安静环境休息5-10分钟（口述）（0.1分），了解被检者半小时内是否饮用咖啡（0.1分）、是否吸烟（0.1分）、排空膀胱（0.1分）。准备血压计、听诊器。	0.5
（二）测量方法	
1.检查血压计水银柱是否在“0”点（0.1分），被检者取坐位或仰卧位（0.1分），保持肘部、血压计“0”点与心脏在同一水平（0.2分）；视线水平与水银柱同高（0.1分）。	0.5
2.气袖均匀紧贴皮肤，缠于上臂（0.2分），其下缘在肘窝以上约2~3cm（0.2分），气袖的中央位于肱动脉表面，其松紧度适宜（0.1分），触诊肘部确定肱动脉搏动位置后（0.2分），将听诊器体件置于肱动脉搏动处（不能将体件塞于气袖下）（0.2分），听诊动脉搏动音（0.1分）；	1
3.向袖带内充气，边充气边听诊至肱动脉搏动音消失后（0.2分），水银柱再升高30mmHg（0.2分），缓慢放气（水银柱下降速度约为2~6mmHg/秒）（0.2分），双眼平视观察水银柱（0.2分），根据听诊动脉搏动音变化和水银柱位置读出收缩压（0.1分）、舒张压数值（0.1分）。	1
（三）报告测量结果	
报告测量结果正确：测量两次，取平均值（考生口述）（0.5分）；报告测得实际血压，读数正确（0.3分）；先报收缩压，后报舒张压（0.2分）。（考官复测，验证考生测定的血压值是否正确）	1

(2) 发育（身高、体重、头围）

①测身高（4分）

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者站立位，检查者站在被检查者右侧（0.5分）。	1
（二）测量方法	
告知被检者脱鞋（0.5分），站立于体重身高测量仪上（背靠站立），头部、臀部、足跟三点紧靠于测量仪立柱（1分），头顶最高点与测量仪立柱垂直直线的交叉点即身高读数（0.5分）。	2
（三）报告测量结果	
报告所测身高，以厘米表示（1分）	1

②测体重（4分）

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
检查者戴帽子、口罩（0.5），被检查者取站立位，检查者站在被检查者右侧（0.5分）。	1
（二）测量方法	
告知被检者脱鞋（0.5分），单衣站立于体重身高测量仪底座上，站立位置正确，身体站直（1分），观察测量仪上指针读数（0.5分）。	2
（三）报告测量结果	
报告测得体重，以公斤表示（1分）	1

③测头围（4分）

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
检查者戴帽子、口罩（0.5分），被检查者取坐位或站立位，检查者站在被检查者右侧（0.3分），准备软尺（0.2分）。	1
（二）测量方法	
用卷尺齐双眉上缘（0.5分），后经枕骨粗隆（0.5分），左右对称环绕一周（1分）。	2
（三）报告测量结果	
报告测得头围，以厘米表示（1分）	1

(3) 体型 (4 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
检查者戴帽子、口罩 (0.5分)，被检查者取站立位，检查者站在被检查者右侧 (0.5分)。	1
(二) 测量方法	
正力型：患者体型匀称,腹上角=90° 无力型：患者体型瘦长,腹上角<90° 超力型：患者体型矮胖,腹上角>90°	2
(三) 报告测量结果	
报告患者体型 (1分)	1

(4) 营养状态 (4 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
检查者戴帽子、口罩 (0.5分)，检查者站在被检查者右侧 (0.5分)。	1
(二) 测量方法	
营养良好：黏膜红润、皮肤光泽、弹性良好,皮下脂肪丰满而有弹性等。 营养中等：介于良好和不良之间。 营养不良：皮肤黏膜干燥、弹性降低,皮下脂肪菲薄,肌肉松弛无力等。	2
(三) 报告测量结果	
报告患者营养状态 (1分)	1

(5) 意识状态 (4 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
检查者戴帽子、口罩 (0.5分), 检查者站在被检查者右侧 (0.5分)。	1
(二) 测量方法	
嗜睡: 患者陷入持续的睡眠状态,可被唤醒,并能正确回答,去除刺激又入睡。 意识模糊: 患者能保持简单的精神活动,但对时间、地点、人物的定向能力发生障碍。 昏睡: 接近不省人事的状态,在强烈刺激下可被唤醒,但很快再入睡。 谵妄: 一种以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性活动失调综合征,临床上表现为意识模糊、定向障碍、感觉错乱、躁动不安、言语杂乱。 昏迷: 意识持续或完全丧失。	2
(三) 报告测量结果	
报告患者意识状态 (1分)	1

(6) 面容 (4 分)

评分标准			分值（分）
（一）测量前准备			
检查者戴帽子、口罩（0.5分），检查者站在被检查者右侧（0.5分）。			1
（二）测量方法			
面容	特点	常见疾病	2
急性病容	面色潮红,兴奋不安,表情痛苦	肺炎球菌肺炎、疟疾。	
慢性病容	面容憔悴,面色晦暗	慢性消耗性疾病,如恶性肿瘤、肝硬化	
贫血面容	面色苍白,唇舌色淡,表情疲惫	各种原因所致贫血	
肝病面容	面色晦暗,额部、鼻背、双颊有褐色色素沉着。	慢性肝病	
肾病面容	面色苍白,眼睑、颜面水肿,舌色淡	慢性肾疾病	
甲状腺功能亢进面容	面色惊愕。眼裂增宽,眼球凸出,烦躁易怒	甲亢	
黏液性水肿面容	面色灰黄,颜面水肿,睑厚面宽,目光呆滞,反应迟钝。	甲减	
二尖瓣面容	面色晦暗,双颊紫红,口唇轻度绀。	二尖瓣狭窄	
肢端肥大症面容	头颅增大,面部变长,面容变丑。	肢端肥大症	
伤寒面容	表情淡漠,反应迟钝,无欲状态。	肠伤寒、脑脊髓膜炎等。	
苦笑面容	牙关紧闭,面肌痉挛,呈苦笑状。	破伤风。	
满月面容	圆如满月,皮肤发红,伴有痤疮。	库欣综合征、长期用激素。	
（三）报告测量结果			
报告患者面容（1分）			1

(7) 体位 (4 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
检查者戴帽子、口罩 (0.5 分) , 检查者站在被检查者右侧 (0.5 分) 。	1
(二) 测量方法	
自主体位: 身体活动自如,不受限制。 被动体位: 患者不能自己调整或变换身体的位置。 强迫体位: 患者为减轻痛苦,被迫采取某种特殊体位。	2
(三) 报告测量结果	
报告患者体位 (1 分)	1

(8) 姿势 (4 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
检查者戴帽子、口罩 (0.5 分) , 检查者站在被检查者右侧 (0.5 分) 。	1
(二) 测量方法	
颈部活动受限: 颈椎病 躯干制动或弯曲: 腹部疼痛 坐位: 充血性心衰。 捧腹而行: 胃十二指肠溃疡	2
(三) 报告测量结果	
报告患者姿势 (1 分)	1

(9) 步态 (4 分)

评分标准			分值(分)
(一) 测量前准备			
检查者戴帽子、口罩（0.5 分），检查者站在被检查者右侧（0.5 分）。			1
(二) 测量方法			
步态	特点	常见疾病	2
蹒跚步态	走路时身体左右摇摆似鸭行	佝偻病、先天性双侧髋关节脱位等	
醉酒步态	行走时躯干重心不稳,步态紊乱、不准确	小脑损伤、酒精中毒等	
共济失调步态	起步时 脚高抬,骤然垂落,且双目向下注视,两脚间距根宽,以防身体倾斜,闭目时则不能保持身体平衡。	脊髓病变患者。	
慌张步态	起步后小步急速趋行,双脚擦地,身体前倾,有难以止步趋势	帕金森病患者	
跨域步态	由于踝部肌腱、肌肉弛缓,患足下垂,行走时必须高抬 下肢才能起步	腓总神经麻痹。	
剪刀步态	由于双下肢肌张力增高,以伸肌和内收肌增高明显,移 步时下肢内收过度,两腿交叉呈剪刀状。	脑性瘫痪、截瘫	
间歇性跛行	步行中,因下肢突发性酸痛乏力,患者被迫停止前行,需要稍休息后能继续进行	高血压、动脉硬化。	
(三) 报告测量结果			
报告患者步态 （1 分）			1

2.皮肤

(1) 皮肤弹性和水肿的检查（6分）

评分标准	分值(分)
(一) 操作前准备	
1.自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（0.5分） 2.患者体位取坐位或仰卧位，检查者：位于患者的右侧。（口述）（0.5分）	1
(二) 检查部位及方法	
1.检查部位： 皮肤弹性检查部位为手背或者上臂内侧皮肤（1分）； 皮肤水肿检查部位为小腿内侧（1分）。	2
2.检查方法： （1）皮肤弹性检查：检测者用拇指和示指将皮肤捏起，松手后正常皮肤褶皱迅速平复，当弹性减退时褶皱平复缓慢（1分）。 （2）水肿检查：检查者用手指按压小腿内侧皮肤后呈凹陷，观察凹陷是否恢复（1分）。	2
(三) 报告检查结果	
报告考官：该患者皮肤弹性正常，无水肿	1

(2) 蜘蛛痣和皮下出血 (6 分)

评分标准	分值(分)
(一) 操作前准备	
1.自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述） 2.患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意（0.5分）；患者体位取坐位或仰卧位，检查者：位于患者的右侧。（口述）（0.5分）	1
(二) 检查部位及方法	
1.检查部位： （1）皮肤小动脉末端分支性扩张所形成的血管痣，形似蜘蛛，称为蜘蛛痣，多出现在上腔静脉分布的区域内，如面、颈、手背、上臂、前胸和肩五部分。 （2）检查者用棉签或火柴棍压迫蜘蛛痣的中心，其辐射状小血管网消退，去除压力后又复出现。	2
2.检查方法： （1）皮下出血：病理状态下可出现皮肤下出血。 （2）根据其直径大小及伴随情况可分为以下几种：<2mm称为瘀点，2~5mm称为紫癜，>5mm称为瘀斑，片状出血并伴有皮肤明显隆起称为血肿。	2
(三) 报告检查结果	
报告考官：该患者未见蜘蛛痣和皮下出血	1

3.浅表淋巴结（7分）

评分标准	分值(分)
（一）操作前准备	
1.自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述） 2.患者准备：告知患者相关检查内容，获得患者同意；患者体位取坐位或仰卧位，检查者位于患者的右侧。（口述）	1
（二）检查步骤	
1.检查部位：双侧颈前区及颈后区。	2
2.检查方法：检查者用三指（示指、中指、环指）并拢，手指紧贴检查者皮肤，由浅到深进行滑行触诊	1
3.检查顺序：耳前→耳后→枕部→颌下→颏下→颈前→颈后→锁骨上淋巴结。	2
（三）报告检查结果	
报告考官：患者头颈部未触及肿大的淋巴结，如果触到肿大的淋巴结，要汇报淋巴结的位置、大小、质地、活动度、有无压痛等。	1

（二）头颈部

1.眼

外眼检查（包括眼睑、巩膜、结膜、眼球运动）、瞳孔的大小与形状、对光反射（直接、间接）、集合反射。

（1）外眼检查（7.5 分）

评分标准	分值(分)
（一）操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位或者站立位	2
（二）检查内容及方法	
1、观察眼睑->上睑->睫毛->眼裂	1.5分
2、检查上睑结膜	
（1）检查者右手检查受检者左眼，左手检查右眼	0.5分
（2）用示指和拇指捏住上睑中外1/3交界处的边缘，嘱被检者向下看，此时轻轻向前下方牵拉，然后示指向下压迫睑板上缘，并与拇指配合将睑缘向上捻转即可将眼睑翻开。	0.5分
（3）同样方法检查另一侧。	0.5分
3、检查巩膜与结膜：嘱被检者眼睛向上看，用拇指轻压下眼睑下缘，充分暴露巩膜与结膜。	0.5分
（三）报告检查结果	
报告老师： 1、眼睑无水肿，上睑无下垂，无倒睫，眼裂无闭合障碍 2、睑结膜无苍白或充血，球结膜无充血或水肿 3、巩膜无黄染	2

(2) 眼球运动 (5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位；检查者站于被检者前方	1
(二) 检查内容及方法	
1、医生手执目标物（棉签或手指尖），置于受检者眼前30-40cm处，嘱受检者固定头位，眼球随目标方向移动。	1
2、目标物按左->左上->左下，右->右上->右下 6个方向的顺序进行，观察被检者眼球运动情况	1
3、每一方向代表双眼的一对配偶肌的功能，若有某一方向运动受限，提示该对配偶肌功能障碍。	1
(三) 报告检查结果	
报告老师：被检者眼球各方向活动自如，未见明显活动受限	1

(3) 瞳孔的正常值 (6 分)

评分标准	分值(分)
(一) 操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位；检查者站于被检者前方	1
(二) 检查内容及方法	
1、瞳孔的正常值为3-4mm	1
2、瞳孔扩大，多见于药物影响（阿托品、可卡因）、临终前被检者、外伤、颈交感神经刺激、青光眼绝对期、视神经萎缩等	1
3、瞳孔缩小，多见于药物反应（氯丙嗪、吗啡、毛果芸香碱）、中毒（有机磷杀虫剂）、虹膜炎等	1
4、两侧瞳孔大小不等：多提示有颅内病变，如脑外伤、脑肿瘤、脑疝、中枢神经梅毒等	1
(三) 报告检查结果	
报告老师： 1、瞳孔的正常直径为3-4mm 2、瞳孔扩大多见于应用阿托品及临终前被检者等 3、瞳孔缩小多见于应用氯丙嗪、吗啡、有机磷杀虫剂等 4、两侧瞳孔大小不等多见于脑外伤、脑肿瘤、脑疝等	1

(4) 对光反射和集合反射 (6 分)

评分标准 (对光反射)	分值(分)
(一) 操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位或站立位；检查者站于被检者前方 3、物品准备：手电筒	1
(二) 检查内容及方法	
1、直接对光反射：用手电筒直接照射瞳孔并观察其动态反应。当眼受到光线刺激后瞳孔立即缩小，移开光源后瞳孔迅速复原 2、用同样的方法照射另一只眼	2
3、间接对光反射：光线照射一只眼时，另一只眼瞳孔立即缩小，移开光线，瞳孔扩大 4、用同样的方法照射另一只眼	2
(三) 报告检查结果	
1、报告老师：瞳孔对光反射灵敏、迟钝或消失。对光反射迟钝或消失见于深昏迷患者	1

评分标准 (集合反射)	分值(分)
(一) 操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位或站立位；检查者站于被检者前方 3、物品准备：手电筒	1
(二) 检查内容及方法	
1、集合反射：嘱受检者注视1m以外的目标（通常是检查者的示指尖），然后将目标逐渐移进眼球（距眼球5-10cm），正常人此时可见双眼内聚，瞳孔缩小。	2
2、近反射：视物由远及近，同时伴有晶状体的调节。因此，以上双眼内聚，瞳孔缩小，晶状体的调节三者又称为近反射	2
(三) 报告检查结果	
1、报告老师：动眼神经功能损害时，睫状肌和双眼内直肌麻痹，集合反射和调节反射均消失	1

2.口（咽部、扁桃体）

扁桃体的检查方法（4分）

评分标准	分值(分)
（一）操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位或站立位；检查者站于被检者前方	1
（二）检查内容及方法	
1、被检者头后仰，口张大并发音“啊”，此时检查者用压舌板在舌的前2/3与后1/3交界处迅速下压，此时软腭上抬，在照明的配合下即可见软腭->腭垂->软腭弓->扁桃体->咽喉壁等	2
（三）报告检查结果	
1、报告老师：该被检者软腭无充血水肿，腭垂居中，扁桃体无肿大无脓性分泌物，咽喉壁无充血水肿	1

3.颈部

甲状腺、气管、血管。

(1) 甲状腺的检查 (7 分)

评分标准	分值(分)
(一) 操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位或仰卧位，使用检查者站于被检者前方 3、物品准备：听诊器	1
(二) 检查内容及方法	
1、视诊：观察甲状腺的大小、对称性	1
2、触诊（前面触诊及后面触诊，任选其一）：	
（1）触诊甲状腺峡部：站在受检者前面用拇指（或站在受检者后面有示值）从胸骨上切迹向上触摸，可感到气管前软组织，判断有无增厚，请受检者吞咽，可感到此软组织在手指下滑动，判断有无肿大及肿块	1
（2）触诊甲状腺侧叶（前面触诊及后面触诊，任选其一）： 触诊甲状腺侧叶（前面触诊）：一手拇指压于一侧甲状软骨，将气管推向对侧，另一手示指、中指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺侧叶，拇指在胸锁乳突肌前缘触诊甲状腺。配合吞咽动作，重复检查，可触及被推挤的甲状腺。用同样的方法检查另一侧甲状腺 触诊甲状腺侧叶（后面触诊）：一手示指、中指压于一侧甲状软骨，将气管推向对侧，另一手拇指在对侧胸锁乳突肌后缘向前推挤甲状腺侧叶，示指中指在其前缘触诊甲状腺。配合吞咽动作，重复检查，可触及被推挤的甲状腺。用同样的方法检查另一侧甲状腺	2
3、听诊 当触及到肿大甲状腺时，用钟型听诊器直接放在肿大的甲状腺上，如听到低调的连续性静脉“嗡鸣音”，对甲状腺功能亢进症诊断很有帮助 另外，在弥漫性甲状腺肿伴功能亢进者可听到收缩期动脉杂音	1
(三) 报告检查结果	
报告老师： 1、视诊：甲状腺无明显肿大，两侧对称 2、触诊：甲状腺峡部及侧叶为触及肿大及结节 3、听诊：甲状腺未闻及杂音，如果存在甲亢时，可闻及血管杂音	1

(2) 气管检查 (2 分)

评分标准	分值(分)
(一) 操作前准备	
1、戴好帽子口罩 2、获得被检者同意，被检者取坐位或仰卧位，使颈部处于自然直立状态。检查者立于被检者的前方或右侧	0.5
(二) 检查内容及方法	
将示指与环指分别置于两侧胸锁关节上，然后将中指置于气管之上，观察中指是否在示指与环指中间，或以中指置于气管与两侧胸锁乳突肌之间的间隙，根据两侧间隙是否等宽来判断气管有无偏倚。	1.5
(三) 报告检查结果	
报告老师：该被检者气管居中，如果中指往哪侧偏移，说明气管往哪侧移位。	1

(3) 颈部血管检查 (6 分)

评分标准	分值(分)
(一) 操作前准备	
1.戴好帽子口罩 2.获得被检者同意，被检者合适体位。检查者站于被检者的前方或后方	1
(二) 检查内容及方法	
1.视诊： （1）视诊颈静脉：被检查者取坐位或半坐位，身体呈45度，观察颈静脉有无充盈或怒张（颈部静脉充盈水平不超过锁骨上缘至下颌角之间的下2/3水平） （2）视诊颈动脉：被检查者去坐位或仰卧位，先视诊有无动脉异常搏动。	2
2、触诊：触诊颈动脉，以拇指置于甲状腺软骨水平胸锁乳突肌内侧，触摸颈动脉搏动，比较两侧颈动脉搏动有无差别	1
3、听诊：患者取坐位，听诊器听诊，如在颈部大血管区听到血管杂音，常提示颈动脉狭窄，椎动脉狭窄等	1
(三) 报告检查结果	
报告老师： 1、被检者颈静脉无明显充盈和怒张，颈静脉怒张的定义是其充盈水平，超过了锁骨上缘至下颌角之间的下2/3水平；颈动脉无异常搏动。 2、触摸颈动脉搏动，两侧颈动脉搏动正常 3、颈部未闻及明显血管杂音，当颈静脉血流增多时，可闻及颈静脉的“营营”音。当颈动脉狭窄时，可闻及动脉杂音。	1

（三）胸部

1.胸部视诊

（1）胸部的体表标志

包括骨骼标志、垂直线标志、自然陷窝、肺和胸膜的界限。

（2）胸壁、胸廓、胸围

（3）呼吸运动、呼吸频率、呼吸节律（10分）

评分标准	分值（分）
（一）检查前准备	
1.医师准备（戴帽子、口罩，洗手）及告知检查目的 2.完全暴露患者检查部位，注意保暖，保护患者隐私 3.考生立于被检查者右侧	1
（二）检查方法	
1.胸廓视诊 （1）观察胸廓形状，两侧是否对称。（0.5分） （2）胸廓有无畸形和局部隆起。（1分） （3）正常胸廓两侧对称，呈椭圆形，前后径与左右径比值约为1:1.5。（0.5分）	2
2.胸壁视诊 （1）胸壁皮肤有无溃疡、窦道、瘢痕、色素沉着、皮疹。（1分） （2）胸壁静脉有无充盈、曲张，有无蜘蛛痣。（1分）	2
3.呼吸运动检查 呼吸运动的类型：胸式呼吸或腹式呼吸（0.5分） 呼吸频率：计数呼吸频率，1分钟（0.5分） 呼吸节律：节律是否均匀而整齐（0.5分） 呼吸幅度：是否异常（0.5分）	2
（三）向考官汇报检查结果	
报告考官： 1.患者胸廓两侧对称，无明显畸形和异常隆起。前后径与左右径之比为1:1.5。（1分） 2.胸壁皮肤正常，无溃疡，无窦道，无瘢痕，无色素沉着，无皮疹。胸壁静脉无充盈、曲张，无蜘蛛痣。（1分） 3.被检查者为腹（胸）式呼吸，呼吸频率*次/分，节律规整，呼吸运动幅度正常。（1分）	3

2.胸部触诊（10分）

胸廓扩张度、语音震颤、胸膜摩擦感

评分标准	分值（分）
（一）检查前准备	
1.医师准备（戴帽子、口罩，洗手）及告知检查目的 2.完全暴露患者检查部位，注意保暖，保护患者隐私 3.考生立于被检查者右侧	1
（二）检查方法	
1.胸廓扩张度 （1）检查者两手置于被检查者胸廓下面的前侧部，左右拇指分别沿两侧肋缘指向剑突，拇指尖在前正中线两侧对称部位，而手掌和伸展的手指置于前侧胸壁。（1分） （2）嘱患者作深呼吸运动，观察比较两手的动度是否一致。（1分）	2
2.语音震颤 检查者将左右手掌的尺侧缘或掌面轻放于两侧胸壁的对称部位，然后嘱被检查者用同等的强度重复发“yi”长音，自上至下、从内到外比较两侧相应部位语音震颤的异同（1分），注意有无增强或减弱、语音震颤检查的部位及顺序。（1分）	2
3. 胸膜摩擦感 （1）考生将手掌平放于被检查者前下侧两部或腋中线第5.6肋间处。（1分） （2）嘱被检查者深慢呼吸，注意吸气相和呼气相时有无如皮革互相摩擦的感觉:嘱被检查者屏住呼吸，重复前述检查。（1分）	2
（三）报告检查结果	
报告考官: 双侧胸廓扩张度对称一致（1分） 双侧语音震颤对称一致（1分） 该患者未触及胸膜摩擦感。（1分）	3

3.胸部叩诊

叩诊方法、肺界叩诊、肺下界移动度。

(1) 平静呼吸时胸（肺）部间接叩诊检查的方法和顺序（9分）

（一）检查前准备		
做好准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的	1	
请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部和背部。取坐位时，检查者站于被检者前面或后面；取卧位时，站于被检者右侧。（口述）		
（二）肺部间接叩诊手法		
1. 将左手中指第2指节紧贴于叩诊部位，其他手指稍微抬起。勿与体表接触。（0.5分）右手手指自然弯曲，用中指指端叩击左手中指末端指间关节处或第2节指骨的远端。（0.5分） 2. 板指要与肋骨平行，平贴于肋间隙，逐个肋间进行叩诊。（0.5分）叩诊后背的肩胛间区时，板指则应与脊柱平行。（0.5分） 3. 叩击方向应与叩击部位的体表垂直，叩击时应以腕关节与掌指关节的活动为主，即击动作要灵活、短促、富有弹性，叩击后叩指应立即抬起，以免影响对叩诊音的判断。（1分） 4. 在同一部位可连续叩击2～3下。（1分）	4	
（三）胸（肺）部叩诊顺序		
1. 自锁骨上窝开始，然后沿锁骨中线、腋前线自第1肋间要做到从上而下，左右对比，内外对比，上下对比。（0.5分） 2. 先检查前胸，其次检查侧胸，最后为背部。（0.5分） 3. 然后叩诊侧胸壁，嘱被检者举起上臂置于头部，自腋窝开始沿腋中线、腋后线向下叩诊至肋缘。（1分） 4. 最后，被检者坐起，进行背部叩诊，嘱被检者向前稍低头，双手交叉抱肘，由上至下进行叩诊。（1分）	3	
（四）汇报结果		
报告结果：正常双肺叩诊为清音，心肺和肝肺重叠处为浊音	1	

(2) 肺上界叩诊检查 (5 分)

(一) 检查前准备		
1.准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的	2.请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部和背部。取坐位时，检查者站于被检者前面或后面；取卧位时，站于被检者右侧。（口述）	1
(二) 具体操作		
叩诊方法：自斜方肌前缘中央部开始叩诊为清音（1分），逐渐向外侧叩诊，当清音变为浊音时，即为肺上界的外侧终点（1分）。自斜方肌前缘中央部开始叩诊，逐渐向内侧叩诊，当清音变为浊音时，即为肺上界的内侧终点（1分）。		3
(三) 汇报结果		
报告结果：肺上界的宽度大约是5cm。		1

(3) 肺下界叩诊检查 (5 分)

(一) 检查前准备		
准备, 戴好帽子、口罩 (口述)。自我介绍, 检查目的	1	
请被检者取坐位或仰 (俯) 卧位, 充分暴露前胸部和背部。取坐位时, 检查者站于被检者前面或后面; 取卧位时, 站于被检者右侧。(口述)		
(二) 具体操作		
1. 被检者双臂垂放或平放, 呼吸均匀。板指平贴肋间隙, 与肋骨平行, 逐个肋间进行叩诊。(1分)	3	
2. 分别沿右锁骨中线、左右腋中线、左右肩胛线叩出肺下界的位置。(0.5分)		
3. 在右锁骨中线当清音变为浊音时为肺下界; 在左右腋中线和左右肩胛线当清音变为浊音为肺下界。(1分)		
4. 正常结果: 平静呼吸时位于右侧锁骨中线第6肋间隙上, 腋中线第8肋间隙上, 肩胛线第10肋间隙上 (0.5分)		
(三) 汇报结果		
报告结果: 肺下界位于右侧锁骨中线第6肋间隙上, 腋中线第8肋间隙上, 肩胛线第10肋间隙上	1	

(4) 右肺下界移动度检查 (5 分)

(一) 检查前准备		
准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的	1	
请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部和背部。取坐位时，检查者站于被检者前面或后面；取卧位时，站于被检者右侧。（口述）		
(二) 具体操作		
1.先于平静呼吸时在肩胛线上叩出肺下界（0.5分） 2.然后嘱被检者深吸气后屏气，同时向下叩诊，在清音变为浊音时做一标记。（1分） 3.恢复平静呼吸，同样于平静呼吸时在肩胛线上叩出肺下界，然后再深呼吸后屏气，自上而下叩诊浊音变清音，做标记。（1分） 4.测量两标记之间的距离即为肺下界移动度。（0.5分）	3	
(三) 汇报结果		
报告结果：被检查者肺下界移动度正常人为6-8cm	1	

4.胸部听诊

听诊方法、正常呼吸音、异常呼吸音、啰音、胸膜摩擦音（8分）

(一) 检查前准备	
1.准备，戴好帽子、口罩（口述）。自我介绍，检查目的 2.请被检者取坐位或仰（俯）卧位，充分暴露前胸部，考生站于被检者右侧。（口述） 3.准备并检查听诊器。	1.5
(二) 具体步骤	
1.一般听诊：听诊顺序一般由肺尖开始，自上而下分别检查前胸部、侧胸部、背部（1分），听诊前胸部应沿着锁骨中线和腋前线；听诊侧胸部应沿着腋中线和腋后线；听诊背部应沿着肩胛线（1分），自上向下逐一肋进行，上下、左右对称的部位进行对比（0.5分）；被检者做均匀呼吸，必要时可做较深的呼吸或咳嗽数声后立即听诊，有利于察觉呼吸音及附加音的改变。 2.语音共振：考生将听诊器放于两侧胸壁的对称部位，嘱受检者用同等的声音强度重复发“Yi”长音（1分）。由上至下、从内到外比较两侧相应部位语音共振的异同，注意有无增强或减弱（1分）。 3.胸膜摩擦音：考生将听诊器的模型体件置于前下侧胸壁或腋中线5-6肋间进行听诊（1分），嘱被检查者屏住呼吸或深呼吸时重复听诊（0.5分），胸膜摩擦音在吸气末与呼气初明显，屏住呼吸时胸膜摩擦音消失，深呼吸时增强。	6
(三) 汇报结果	
报告老师：双肺呼吸音是否清晰，有无增强或减弱，有无异常呼吸音，有无啰音，有无胸膜摩擦音，语音共振有无增强或减弱。	0.5

5.乳房检查（视诊、触诊）（5分）

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
1.自己准备：做好自己的准备，戴上帽子。（口述） 2.患者准备：被检查者取仰卧位或坐位，充分暴露前胸部，考生站在被检查者右侧或前面。（口述）	1.5
（二）测量方法	
1.两侧乳房是否对称 2.皮肤有无发红、溃疡、橘皮样改变等 3.乳头的位置、大小、对称性（0.5分），乳头有无内缩和分泌物	2
（三）报告测量结果	
报告考官：乳房两侧对称；皮肤正常无溃疡、窦道、瘢痕、色素沉着、皮疹等；乳头居中，无内陷、偏斜，乳头表面无异常分泌物。	1.5

6.心脏视诊

心前区隆起与凹陷、心尖搏动、心前区异常搏动。（5分）

评分标准	分值(分)
（一）检查前准备	
1.自我准备，洗手，口罩，帽子	0.5
2.告知被检查者取仰卧，并充分暴露前胸部	0.5
3.考生站在被检查者右侧	0.5
（二）检查方法	
1.视线先与胸部同水平视诊，观察有无隆起或凹陷	1
2.俯视前胸，观察有无异常搏动	0.5
3.观察心尖搏动的位置、强度、范围和有无负性心尖搏动	1
（三）报告检查结果	
1.心前区有无隆起或凹陷，有无异常搏动	0.5
2.心尖搏动的位置、强度、范围和有无负性心尖搏动	0.5

7.心脏触诊（5分）

心尖搏动及心前区异常搏动、震颤、心包摩擦感。

评分标准	分值（分）
（一）检查前准备及站位	
1.自我准备，洗手，口罩，帽子	0.3
2.告知被检查者取仰卧，并充分暴露前胸部	0.3
3.考生站在被检查者右侧	0.3
（二）检查内容和方法	
1.触诊心尖搏动及心前区搏动（两步）：检查者先用右手全手掌触诊心前区粗略触诊搏动位置，然后用示指和中指指腹并拢准确触诊心尖搏动及心前区搏动。	1
2.触诊震颤：用手掌尺侧（小鱼际）在各瓣膜区触诊。	1
3.触诊心包摩擦感：在心前区/胸骨左缘第3、4肋间用小鱼际触诊。嘱被检查者屏气，检查有无心包摩擦感及变化。	1
（三）报告检查结果	
1.汇报心尖搏动的位置，汇报有无增强或减弱；如有心前区异常搏动，汇报位置	0.4
2.汇报各瓣膜区有无震颤。	0.4
3.汇报有无心包摩擦感。	0.3

8.心脏叩诊（5分）

心界叩诊及左锁骨中线距前正中线距离的测量。

评分标准	分值(分)
（一）检查前准备及站位	
1.自我准备，洗手，口罩，帽子，格尺、记号笔	0.3
2.告知被检查者取仰卧，并充分暴露前胸部	0.3
3.考生站在被检查者右侧	0.3
（二）检查内容和方法	
1.检查内容：心脏相对浊音界（说出来）。	0.3
2.浊音界确定方法（间接叩诊法）：检查者板指与肋间平行，叩诊力度要适中和均匀，板指每次移动的距离不超过 0.5cm 。当叩诊音自清音变为浊音时做标记，为心脏的相对浊音。	1
3.叩诊顺序及测量：①先左界，后右界。②左侧自心尖搏动外 2~3cm 处开始（第5肋间），由外向内，逐个肋间向上，直至第2肋间。③右界叩诊先叩出肝上界（第5肋间），然后于其上一肋间由外向内，逐一肋间向上叩诊，直至第2肋间。④对各肋间叩得的浊音界逐一做出标记，并测量其各点与胸骨中线间的垂直距离。	2.5
（三）报告检查结果	
1.汇报各浊音界范围，并判定是否正常。	0.3

9.心脏听诊

心脏瓣膜听诊区、听诊顺序、听诊内容（心率、心律、心音、心音改变、额外心音、心脏杂音、心包摩擦音）。（8分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位	
1.做好自己的准备，戴上帽子。（口述） 2.嘱被检查者取仰卧位或坐位，充分暴露前胸部，考生站在被检查者右侧或前面。（口述）	1
（二）检查内容和方法	
1.具体步骤： 第一步：听诊全心（心律、心率、心音、杂音）。 第二步：听诊各个瓣膜听诊区，逆时针方向依次听诊：心尖区 → 肺动脉瓣区 → 主动脉瓣区第一听诊区 → 主动脉瓣区第二听诊区 → 三尖瓣区。心尖区听诊时间不少于30秒。 第三步：将听诊器置于第3-4肋间，听诊心包摩擦音。	3.5
2.心脏各个瓣膜听诊区等听诊位置： 心脏瓣膜等5个听诊区： 二尖瓣区：位于心尖搏动最强点，又称心尖区。 肺动脉瓣区：位于胸骨左缘第二肋间。 主动脉瓣区：位于胸骨右缘第二肋间。 主动脉瓣第二听诊区：位于胸骨左缘第三肋间，又称Erb区。 三尖瓣区：位于胸骨左缘第四、五肋间	1.5
（三）报告检查结果	
报告考官： 该患者心律整齐，心率80次/分，第一心音及第二心音正常，未闻及额外杂音。 各瓣膜听诊区未闻及杂音。 未闻及心包摩擦音。	2

10.外周血管检查

(1) 脉搏 (4分)

脉率、脉律。

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位，告知被检者体位	
1.做好自己的准备，戴上帽子。(口述) 2.嘱被检查者取仰卧位或坐位，考生站在被检查者右侧。(口述)	1
(二) 检查内容和方法	
考生用示指、中指和环指三指触摸桡动脉，计时1分钟，注意脉搏等频率和节律。	2
(三) 报告检查结果	
被检查者脉律整齐，脉率80次/分，无异常脉搏。	1

(2) 血管杂音

静脉杂音、动脉杂音。

(3) 周围血管征

（四）腹部

1.腹部视诊

（1）腹部的体表标志及分区

腹部体表标志：请在患者身上指出腹部常见解剖标志肋弓下缘、髂前上棘、腹中线、腹股沟韧带、腹直肌外缘和腹部九分法（6分）

评分标准	分值（分）
（一）检查前准备	
自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍。 患者准备：被检查者排尿后仰卧位，考生站在被检查者右侧（口述）	1
（二）操作步骤	
解剖标志： 1.肋弓下缘：是由第8-10肋软骨连接形成的肋缘以及第11、12浮肋构成，为腹部体表投影的上界。 2.髂前上棘：位于髂嵴前方的凸出点，常用于骨髓穿刺以及腹部分区的标志。 3.腹中线：为体表正中的垂直线，是胸骨中线的延续，可作为腹部分区的体表标志。 4.腹股沟韧带：是连接于髂前上棘与耻骨结节之间的肌腱，常作为寻找股动、静脉的体表标志。 5.腹直肌外缘：相当于锁骨中线的延续，常作为手术切口、胆囊触诊的定位标志。	2.5
腹部分法： 九分区法：是由两侧肋弓下缘连线和两侧髂前上棘连线为两条水平线，左、右髂前上棘至腹中线连线的中点为两条垂直线，四线相交将腹部分为井字形九区，即左、右上腹部（季肋部）、左、右侧腹部（腰部）、左、右下腹部（髂窝部）以及上腹部、中腹部（脐部）和下腹部（耻骨上部），共9个区域。	1.5
（三）报告检查结果	
准确指出解剖标志的位置及概念	1

(2) 腹部外形、腹围 (4 分)

评分标准	分值（分）
（一）检查前准备	
1.自己准备：戴帽子、口罩，自我介绍（告知患者操作的目的是和注意事项）。	1
2.患者准备：被检查者排尿后仰卧位，考生站在被检查者右侧（口述）	
（二）操作步骤	
用软尺经脐水平绕腹一周，所测得周长即为腹围，通常以cm为单位。	2
（三）报告检查结果	
报告结果，此患者的腹围为××cm。	1

(3) 呼吸运动

(4) 腹壁静脉

(5) 胃肠型和蠕动波

腹部视诊：(6 分)

评分标准	分值 (分)
(一) 考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双手自然置于身体两侧，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸	0.5
2.考生站在被检查者右侧	0.5
(二) 检查内容和方法	
1.考生先俯视全腹，从上腹部至下腹部视诊全腹：包括腹部外形，呼吸运动、腹壁静脉、胃肠型、蠕动波、及腹壁其他情况（皮疹、色素沉着、腹纹、瘢痕、疝、脐部异常和上腹部搏动等）。	2
2.视线与被检查者腹平面处于同一水平，自侧面沿切线方向观察：异常隆起和凹陷。	2
(三) 报告检查结果	
患者腹部平坦/饱满/膨隆/凹陷，呼吸运动以腹式呼吸/胸式呼吸为主，腹壁有无皮疹、色素沉着、腹纹、瘢痕、疝、脐部异常和上腹部搏动等，有无静脉曲张、有无胃肠型、蠕动波。	1

2.腹部触诊

(1) 腹壁紧张度、腹部压痛及反跳痛检查（7分）

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双手自然置于身体两侧，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸	0.5
2. 考生站在被检查者右侧	0.5
(二) 检查内容和方法	
1.腹壁紧张度	
(1) 考生先以全手掌放于腹壁上，让被检查者适应片刻，同时感受被检查者的腹肌紧张度，然后以轻柔动作开始触诊。	1
(2) 检查完成一个区域后，再以上述手法检查下一个区域。	0.5
(3) 一般先从左下腹开始，逆时针方向进行触诊至右下腹，再至脐部，依次检查腹部各区，如果患者有病痛，最后检查病痛部位。	0.5
2.腹部压痛、反跳痛	
(1) 考生先以全手掌放于腹壁上，让被检查者适应片刻，然后用手指指腹压于腹壁，观察被检查者有无疼痛反应。	1
(2) 当触诊腹部出血压痛时，用并拢的2-3个手指（示指、中指、环指）在原处停留片刻，使压痛感觉趋于稳定，然后迅速将手抬起，观察被检查者疼痛有无骤然加重。	2
(三) 报告检查结果	
报告考官：该患者有/无明显腹肌紧张，腹壁有/无明显压痛，有/无反跳痛。	1

(2) 肝脾触诊及测量方法

①肝脏单手触诊（6分）

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双手自然置于身体两侧，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。	0.5
2. 考生站在被检查者右侧	0.5
(二) 检查内容和方法	
1.考生将右手四指并拢，掌指关节伸直，与肋缘大致平行地放在右上腹部（或脐右侧）估计肝下缘的下方，随患者呼气时，手指压向腹壁深部，吸气时，手指缓慢抬起朝肋缘向上迎触下移的肝缘，如此反复进行，手指逐渐向肋缘移动，直到触到肝缘或肋缘为止。	3分
2.在右锁骨中线及前正中线上，分别触诊肝缘并测量其与肋缘或剑突根部的距离，以cm表示。	1分
(三) 报告检查结果	
报告考官：该患者肝脏肋下未触及，当触及肝脏时，注意肝脏的大小、质地、边缘和表面状态、有无压痛，是否有搏动，有无肝区摩擦感等。	1分

②肝脏双手触诊（6分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双手自然置于身体两侧，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。	0.5
2.考生站在被检查者右侧	0.5
（二）检查内容和方法	
1.考生将左手放在被检者右背部第12肋骨与髂嵴之间脊柱旁肌肉的外侧。右手四指并拢，掌指关节伸直，与肋缘大致平行地放在右上腹部（或脐右侧）估计肝下缘的下方，随患者呼气时，手指压向腹壁深部，吸气时，手指缓慢抬起朝肋缘向上迎触下移的肝缘，如此反复进行，手指逐渐向肋缘移动，直到触到肝缘或肋缘为止。触诊时，左手向上推，使肝下缘紧贴前腹壁，并限制右下胸扩张，以增加膈下移的幅度。	3
2.在右锁骨中线及前正中线上，分别触诊肝缘并测量其与肋缘或剑突根部的距离，以cm表示。	1
（三）报告检查结果	
报告考官：该患者肝脏肋下未触及，当触及肝脏时，注意肝脏的大小、质地、边缘和表面状态、有无压痛，是否有搏动，有无肝区摩擦感等。	1

③脾脏触诊（6分）

评分标准	分值(分)
（一）考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸，被检查者取右侧卧位时，双腿屈曲或右下肢伸直，左下肢屈曲（口述）	0.5
2. 考生站在被检查者右侧	0.5
（二）检查内容和方法	
考生将左手绕过患者腹前方，手掌置于其左胸下部第9-11肋骨处，试将其脾脏从后向前托起，并限制胸廓运动，右手平放于脐部，四指并拢，掌指关节伸直，与左侧肋弓大致呈垂直方向，从脐平面开始配合呼吸，随患者呼气时，手指压向腹壁深部，吸气时，手指缓慢抬起朝肋缘向上迎触下移的脾尖，如此反复进行，手指逐渐向肋缘移动，直到触到脾缘或左侧肋缘为止。	4
（三）报告检查结果	
报告考官：该患者脾肋下未触及。	1

④Murphy 征（6分）

评分标准	分值(分)
（一）考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双手自然置于身体两侧，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。	0.5
2.考生站在被检查者右侧	0.5
（二）检查内容和方法	
1. 考生将左手掌平放于患者右胸下部，以拇指指腹勾压于右肋下胆囊点（右锁骨中线和右肋弓的交点）处，然后嘱咐患者缓慢深吸气。	2
2.在吸气过程中发炎的胆囊下移时碰到用力按压的拇指，即可引起疼痛，此外胆囊触痛，如因剧烈疼痛而使吸气终止，称为Murphy征阳性。	2
（三）报告检查结果	
报告考官：该患者Murphy征阴性。	1

⑤肾脏触诊（6分）

评分标准	分值(分)
（一）考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双手自然置于身体两侧，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸。	0.5
2.考生站在被检查者右侧	0.5
（二）检查内容和方法	
1.仰卧触诊右肾：考生将左手掌平放于被检者右腰部，右手掌平放在右上腹部，手指方向大致平行于右肋缘，进行深部触诊右肾，于患者吸气时双手夹触肾脏。	2分
2.触诊左肾：考生将左手越过被检者腹前方从后面托起左腰部，右手掌平放在被检者左上腹部，手指方向大致平行于左肋缘，进行深部触诊左肾，于患者吸气时双手夹触肾脏。	2分
（三）报告检查结果	
报告考官：该患者双肾大小正常。	1分

（4）腹部包块检查（5分）

评分标准	分值(分)
（一）考生站位，告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位，双手自然置于身体两侧，双腿屈曲，腹部放松，做腹式呼吸	0.5
2.考生站在被检查者右侧	0.5
（二）检查内容和方法	
1.考生先以全手掌放于腹壁上，让被检查者适应片刻，然后右手示指、中指、环指并拢，从左下腹开始触诊，将被检查者腹壁下压至少2cm，以了解包块情况。	1分
2.然后将指端逐渐触向包块。	1分
3.滑动触摸，滑动方向与包块长轴垂直。	1分
（三）报告检查结果	
报告考官：该患者未触及包块，当触及包块时，要描述包块的位置、大小、质地、活动度、有无压痛等。	1分

(5) 液波震颤 (5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位, 告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位, 双腿屈曲, 腹部放松, 做腹式呼吸	0.5
2.考生站在被检查者右侧	0.5
(二) 检查内容和方法	
1.检查者以一手掌面贴于患者一侧腹壁, 另一手四指并拢屈曲, 用指端叩击对侧腹壁(或以指端冲击式触诊), 如有大量液体存在, 则贴于腹壁的手掌有被液体波动冲击的感觉, 即波动感。	2分
2.为防止腹壁本身的震动传到对侧, 可让另一个人将手掌尺侧缘压于脐部腹中线上。	1分
(三) 报告检查结果	
报告考官: 该患者 未触及明显的液波震颤。	1分

(6) 振水音 (5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位, 告知被检者体位	
1.告知被检查者排尿后取仰卧位, 双腿屈曲, 腹部放松	0.5
2.考生站在被检查者右侧	0.5
(二) 检查内容和方法	
1.检查者以一耳凑近上腹部, 同时以右手四指并拢冲击触诊法振动胃部, 即可听到气、液冲撞的声音。	2.5分
2.也可将听诊器模型体件置于上腹部进行听诊。	0.5分
(三) 报告检查结果	
报告考官: 该患者 未触及明显的振水音。	1分

3.腹部叩诊

(1) 腹部叩诊音 (4 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位，告知被检者体位、姿势	
被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，考生站在被检查者右侧	1
(二) 检查方法	
采用间接叩诊法，从左下腹开始，沿逆时针方向进行全腹叩诊，最后以脐正中结束。	2
(三) 报告检查结果	
正常情况下，腹部叩诊大部分区域为鼓音，只有在肝脾所在部位，增大的膀胱和子宫占据的部位以及两侧腹部近腰肌叩诊为浊音。	1

(2) 肝浊音界 (5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位，告知被检者体位、姿势	
被检查者排尿后仰卧位，双腿屈曲，腹部放松，考生站在被检查者右侧	1
(二) 检查方法	
1.肝上界叩诊：自第2肋间开始，由上而下逐肋叩诊，当清音变浊音时，即为肝上界。 2.一般在右锁骨中线及前正中线上，从下往上叩诊，当叩诊音由鼓音变为浊音时即为肝下界。	3
(三) 报告检查结果	
正常时，肝上界位于右锁骨中线与第5肋交点处 正常时，肝下界位于右锁骨中线和腹中线肋弓附近	1

(3) 移动性浊音 (5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位, 告知被检者体位、姿势	
被检查者排尿后仰卧位, 双腿屈曲, 腹部放松, 考生站在被检查者右侧	1
(二) 检查方法	
1.检查时先让患者仰卧, 腹中部由于含气的肠管在液面浮起, 叩诊呈鼓音, 两侧腹部因腹水积聚叩诊呈浊音。 2.自腹中部脐水平开始想患者左侧叩诊, 发现浊音时, 扳指固定不动, 嘱患者翻身右侧卧位, 再次叩诊, 如呈鼓音, 移动性浊音(+). 同样的方法向右侧叩诊, 鼓音变为浊音时嘱患者左侧卧位, 核实浊音是否移动。	3
(三) 报告检查结果	
报告考官: 患者移动性浊音阴性。	1

(4) 水坑征 (4 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位, 告知被检者体位、姿势	
被检查者排尿后取肘膝位, 使肚脐部处于最低部。	1
(二) 检查方法	
1.患者肘膝位, 由侧腹部向肚脐部逐渐叩诊, 当鼓音变为浊音, 提示腹腔积液>120ml 2.若患者站立位, 则下腹部积有液体呈浊音, 液体的上界呈一水平线, 在此水平线上为浮动的肠管, 叩诊呈鼓音	3
(三) 报告检查结果	
报告考官: 患者水坑征(-), 如果阳性提示腹水>120ml	1

(5) 肋脊角叩击痛 (5 分)

评分标准	分值 (分)
(一) 考生站位, 告知被检者体位、姿势	
被检查者排尿后取坐位或侧卧位, 考生站在被检查者后方或右侧	1
(二) 检查方法	
1. 部位: 肋脊角是第12肋与脊柱之间的夹角 2. 考生用左手掌平放在其肋脊角 (肾区), 右手握拳用由轻到中等的力量叩击左手背, 每叩击1-2次, 停一下, 反复2-3次, 同时询问被检查者感觉 3. 两侧进行对比叩击	3
(三) 报告检查结果	
报告考官: 肋脊角无叩击痛	1

(6) 膀胱叩诊 (5 分)

评分标准	分值 (分)
(一) 考生站位, 告知被检者体位、姿势	
被检查者排尿后仰卧位, 双腿屈曲, 腹部放松, 考生站在被检查者右侧	1
(二) 检查方法	
1. 视诊: 耻骨联合上方下腹部有无膨隆 (1分) 2. 触诊: 以右手自脐开始向耻骨方向触摸, 触及肿块后应详查其性质, 鉴别膀胱、子宫、肿物 (1分) 3. 叩诊: 自脐部开始, 沿腹中线向下叩诊, 扳指与腹中线垂直, 逐渐向耻骨联合方向移动 (边叩边移), 纸质叩诊音由鼓音转为浊音, 即可能为充盈膀胱之上界。下腹左右两侧依同法叩诊, 叩出凸面向上的半圆形浊音区 (1分)	3
(三) 报告检查结果	
报告考官: 1. 耻骨联合上方下腹部无膨隆 2. 耻骨联合上方未触及肿大的膀胱 3. 能叩及充盈的膀胱上界	1

4.腹部听诊

(1) 肠鸣音 (3 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者排尿后仰卧位，腹部放松，考生站立于被检者右侧	0.5
(二) 检查方法	
将听诊器置于腹壁上，全面听诊各区，尤其 是在脐周或右下腹听诊，时间不少于1分钟。	1.5
(三) 报告检查结果	
肠鸣音存在，4-5次/分	1

(2) 血管杂音 (3 分)

评分标准	分值(分)
(一) 考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者排尿后仰卧位，腹部放松，考生站立于被检者右侧	0.5
(二) 检查方法	
1.将听诊器置于脐周和脐部两侧上方进行听诊 2.将听诊器置于腹壁静脉，当静脉血流增多时，可闻及血管杂音	1.5
(三) 报告检查结果	
被检查者未闻及主动脉、肾动脉及静脉血管杂音	1

（五）脊柱、四肢、肛门

1.脊柱检查（10 分）

（1）脊柱弯曲度（2）脊柱活动度（3）脊柱压痛与叩击痛

评分标准	分值(分)
（一）测量前准备	
1.自己准备穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备被检查在光线明亮的检查室，根据需要取站位或者坐位，充分暴露躯干，开始检查时考生站在被检查者的后面。 3.物品准备叩诊锤、重锤、量角器。	1
（二）测量方法	
1.视诊 （1）从脊柱后方视诊：检查脊柱是否正直，有无侧弯畸形。（0.5分） （2）从脊柱侧方视诊：观察脊柱生理弯曲（颈曲、胸曲、腰曲、骶曲）是否存在，是否存在病理性前凸或者后凸畸形。（0.5分）	1
2.触诊 （1）嘱被检查者取端坐位，身体稍向前倾 （2）检查者以右手拇指从枕骨粗隆开始自上而下逐个按压脊柱棘突。（0.5分） （3）随即按压椎旁肌。（0.5分）。	1
3.叩诊 （1）直接叩击法：用中指或者叩诊锤垂直叩击各椎体棘突，多用于检查胸椎与腰椎，从C7开始到骶椎结束。（0.5分） （2）间接叩击法：嘱患者取坐位，医师将左手掌置于及头部，右手半握拳以小鱼际肌部分叩击左手背，了解脊柱各个部位有无疼痛。（0.5分）	1
4.动及量诊 （1）颈椎活动度检查：考生双手固定被检查者双肩，嘱被检查者做颈部前屈、后伸、侧弯、旋转等动作，观察被检查者颈椎活动度，测量并记录。（2分） （2）腰椎活动度检查：考生双手固定被检查者骨盆，嘱被检查者做腰部前屈、后伸、侧弯、旋转等动作，观察被检查者颈椎活动度，测量并记录。（2分）	4
（三）报告测量结果	

报告考官 1.视诊：脊柱正直，无侧弯及畸形，四个生理弯曲存在，未见病理性前凸及后凸畸形； 2.触诊：脊柱各棘突及脊柱椎旁肌无压痛； 3.叩诊：脊柱直接及间接叩诊无明确叩击痛； 4.动诊及量诊：颈椎、腰椎活动度未见异常	2
---	---

2.四肢、关节检查

(1) 肌力及肌张力检查（5分）

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
1.自己准备穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备被检查在光线明亮的检查室，取坐位或仰卧位，考生站在被检查者前面或右侧。（口述）	1
(二) 测量方法	
1.肌力检查 （1）检查时令患者做肢体伸缩动作，检查者从相反方向给予阻力，测试患者对阻力的对抗情况，根据0-5级肌力分级方法，分别检查10组关键肌的力量，并做相应记录。 （2）注意两侧对比。 2.肌张力检查 患者在肌肉松弛时，医生的双手握住患者的肢体，用不同速度与幅度反复做背痛的伸屈和旋转动作，感到的轻度阻力就是这一肢体有关肌肉的张力，以同样的方法进行各个肢体及关节的被动运动，并做两侧比较。	3
(三) 报告测量结果	
报告考官，被检查者10组关键肌肌力正常，肌张力正常，无明显增强或减弱。	1

(2) 手部及其关节视诊检查 (3.5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
1.自己准备：穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备：被检查在光线明亮的检查室，取立位、坐位或仰卧位，双手自然放松并充分暴露，考生站在被检查者前面或右侧。（口述）	1
(二) 测量方法	
1.手部皮肤观察被检查者双手有无红肿、皮肤破损、皮下出血、有无肌萎缩等。 2.手部关节观察双手指、掌指关节有无畸形、肿胀、活动受限等。 3.手指末端及指甲 观察手指末端有无发绀、苍白、有无杵状指、反甲（匙状指）等。	1.5
(三) 报告测量结果	
报告考官 1.该被检查者皮肤无红肿、破损、皮下出血，无肌萎缩。 2.双手各关节无畸形、肿胀、活动受限 3.手指末端无发绀、苍白，无杵状指、反甲。	1

(3) 手和腕关节运动检查 (5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
1.自己准备：穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备：被检查在光线明亮的检查室，取立位、坐位或仰卧位，双手自然放松并充分暴露，考生站在被检查者前面或右侧。（口述）	1
(二) 测量方法	
1.先检查腕关节屈伸是否正常，在检查腕关节的桡侧和尺侧运动是否正常，两侧对比。 2.检查手指的屈伸是否正常，再检查手指的外展和内收是否正常，两侧对比。 3.拇指的屈伸是否正常，拇指对掌功能是否正常，两侧对比。	3
(三) 报告测量结果	
报告考官：该被检查者手指和腕关节活动正常。	1

(4) 手肌腱损伤检查 (7 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
1.自己准备：穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备：被检查在光线明亮的检查室，取坐位或仰卧位，双手自然放松并充分暴露，考生站在被检查者前面或右侧。（口述）	1
(二) 测量方法	
1.指深屈肌腱断裂：固定损伤指中节，让病人主动屈曲远侧指间关节，若不能屈曲则为指深屈肌腱断裂。 2.指浅屈肌腱断裂：固定被检查者伤指外的其他三指，让病人主动屈曲近侧指间关节，若不能屈曲为指浅屈肌腱断裂。 3. 指浅、深屈肌腱同时断裂：两指间关节均不能屈曲，提示指浅、深屈肌腱均断裂。 4.拇长屈肌腱断裂：固定拇指近节，让病人主动屈曲拇指指间关节。 5.拇指伸肌腱损伤：固定拇指近节，让病人主动伸直拇指指间关节。	5
(三) 报告测量结果	
报告考官：该被检查者双手的屈肌肌腱和伸肌肌腱正常。	1

(5) 膝关节半月板检查 (7 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
1.自己准备：穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备：被检查在光线明亮的检查室，取仰卧位，双下肢自然放松并充分暴露，考生站在被检查者前面或右侧。（口述）	1
(二) 测量方法	
1.McMurray试验：膝关节完全屈曲，检查者手握足跟外旋外翻膝关节，并逐渐伸膝，出现疼痛提示外侧半月板损撕裂；若内旋内翻膝关节，出现疼痛提示内侧半月板撕裂。 2.Apley试验：病人俯卧，膝关节屈曲90°，检查者将小腿用力下压，作内旋外旋动作，若出现疼痛，提示半月板损伤。	5
(三) 报告测量结果	
报告考官：该患者膝关节内外侧半月板未见明显损伤。	1

(5) 膝关节韧带检查 (7 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
1.自己准备：穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备：被检查在光线明亮的检查室，取仰卧位，双下肢自然放松并充分暴露，考生站在被检查者前面或右侧。（口述）	1
(二) 测量方法	
1.侧方应力试验：膝关节完全伸直位与屈曲 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 位置下做被动膝内翻与膝外翻动作，并与对侧做比较，如有疼痛或内外翻角度超出正常范围并有弹跳感时，提示有侧副韧带损伤或断裂。 2.前抽屉试验：患者仰卧位屈膝 90° ，检查者坐在患者足背上以固定，分别在小腿外旋位、中立位、内旋位等三种位置下向前牵拉胫骨上端，观察胫骨结节向前移位程度， $>5\text{cm}$ 为异常。 3. 后抽屉试验：患者仰卧位屈膝 90° ，双手放在膝关节后方，拇指放在伸侧，重复向后推拉小腿近端，胫骨在股骨上向后移动为阳性，提示后交叉韧带部分或者完全断裂。	5
(三) 报告测量结果	
报告考官：该患者膝关节内外侧副韧带及前、后交叉韧带未见明显损伤。	1

(6) 小腿和膝关节检查及浮髌试验检查 (7.5 分)

评分标准	分值(分)
(一) 测量前准备	
1.自己准备：穿工作服，带帽子口罩，洗手。（口述） 2.患者准备：被检查在光线明亮的检查室，取坐位或仰卧位，双小腿自然放松并充分暴露，考生站在被检查者前面或右侧。（口述）	1
(二) 测量方法	
1.视诊 （1）被检查者双小腿有无皮损或者溃烂、皮下出血、粗细不等、肿胀、表浅静脉曲张等。（1分） （2）双膝关节有无畸形、肿胀、活动受限等。（1分）	2
2.触诊 （1）考生按压胫前皮肤，观察有无肿胀和凹陷；按压膝关节，观察有无压痛、肿胀。（1分） （2）浮髌实验：患者取平卧位，下肢伸直放松，检查者一手虎口卡于患膝髌骨上极，并加压压迫髌上囊，使关节液集中于髌骨底面，另一手示指垂直按压髌骨并迅速抬起，按压时髌骨与关节面有接触感，松手时髌骨浮起，即为浮髌实验阳性，提示有中等量以上的关节积液(>50ml)。（1.5分）	2.5
3.动诊 膝关节活动度检查：屈曲被检查者膝关节，观察小腿后部能否相贴，关节能否伸直，膝关节活动度：0° -135°。（1分）	1
(三) 报告测量结果	
报告考官： 1.视诊：该患者双小腿皮肤正常，无破溃、无窦道、无瘢痕、无色素沉着、无皮疹，小腿静脉无曲张；膝关节无畸形、肿胀、活动受限。 2.触诊：小腿胫前皮肤无肿胀及压痛，浮髌实验阴性 3.动诊：膝关节活动度0°~135°	1

3.直肠指检（6分）

评分标准	分值（分）
（一）操作前准备	
1.医生准备：做好医生的准备，戴上帽子、口罩。（口述）（0.5分） 2.患者准备：向患者说明情况及检查的目的。（口述）（0.5分） 被检查者取左侧卧位、胸膝位或截石位，取左侧卧位或胸膝位时,考生站在被检查者右侧或后面，取截石位时，考生站在被检查者前面。（口述）（1分） 3.物品准备无菌手套一副、石蜡油。（口述）（0.5分）	2
（二）操作步骤	
1.考生右手示指戴指套或手套（0.5分）并涂以润滑剂（0.5分），将示指置于肛门外口轻轻按摩,并嘱患者深呼吸，使肛门括约肌适应放松后，再徐徐插入肛门、直肠内（0.5分）。 2.拔出后，检查指套表面有无黏液、脓液及血迹（0.5分）。"	2
（三）汇报结果	
报告老师： 1.该患者肛门括约肌肌张力正常（0.5分）。 2.肛门和直肠皱襞无压痛、肿块和狭窄（1分）。 3.手套或指套上无分泌物及血迹等（0.5分）。	2

（六）神经系统

1.神经反射

（1）深反射跟腱反射、肱二头肌反射、膝反射。

①跟腱反射检查（6分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者取相应的体位。	1
（二）检查内容及方法	
1.跪位姿势检查： （1）被检者双膝跪位并背对考生，臀部上抬，双侧踝关节自然下垂。 （2）考生右手持叩诊锤叩击跟腱。 （3）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	1.5
2.仰卧位姿势检查： （1）被检者取仰卧位，外展下肢并屈曲髋、膝关节。 （2）考生左手推压被检者足掌，使其踝关节过伸，右手持叩诊锤叩击跟腱。 （3）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。。	1.5
俯卧位姿势检查： （1）被检者取俯卧位，屈髋屈膝90°。 （2）考生左手推压被检者足趾，使踝关节过伸，右手持叩诊锤叩击跟腱。 （3）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	1.5
（三）报告检查结果和阳性表现	
报告检查结果：跟腱反射正常表现为叩击跟腱时引发腓肠肌收缩，足向跖面屈曲。跟腱反射对应的脊髓节段是S1~2。	0.5

②肱二头肌反射检查（4分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者坐位或仰卧位，考生站在被检查者右侧。	1
（二）检查内容及方法	
1.坐位检查： （1）考生左手托起被检者肘部并使被检者屈肘，前臂稍内旋置于考生前臂上，考生左手拇指置于肱二头肌肌腱上，右手持叩诊锤叩击考生拇指。（0.5分） （2）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣0.5分。（0.5分）	1
2.卧位检查： （1）考生左手托起被检者肘部并使被检者屈肘，前臂稍内旋置于被检者腹部，考生左手拇指置于肱二头肌肌腱上，右手持叩诊锤叩击考生拇指。（0.5分） （2）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣0.5分。（0.5分）	1
（三）报告检查结果和阳性表现	
报告检查结果：肱二头肌反射正常表现为叩击肱二头肌肌腱时引发肱二头肌收缩、前臂屈曲动作。肱二头肌反射对应的脊髓节段是C5~6。	1

③肱三头肌反射检查（5分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者坐位或仰卧位。考生站在被检查者右侧。	1
（二）检查内容及方法	
被检者外展上臂，半屈肘关节，考生用左手托起被检者前臂，右手持叩诊锤叩击鹰嘴上方的肱三头肌肌腱，可使肱三头肌收缩，引起前臂伸展。	2
考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	1
（三）报告检查结果和阳性表现	
报告检查结果：肱三头肌正常反射表现为叩击肱三头肌肌腱时引发肱三头肌收缩，前臂伸展。肱三头肌反射对应的脊髓节段是C6~7。	1

④桡骨膜反射检查（5分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者坐位或仰卧位。考生站在被检查者右侧。	1
（二）检查内容及方法	
被检者前臂置于半屈半旋前位，考生以左手托住被检者腕部，并使腕关节自然下垂，随即以叩诊锤叩桡骨茎突，可引起肱桡肌收缩，发生屈肘和前臂旋前动作。	2
考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	1
（三）报告检查结果和阳性表现	
报告检查结果：桡骨膜反射正常表现为发生屈肘和前臂旋前动作。桡骨膜反射对应的脊髓节段是C5～6。	1

⑤膝反射检查（11分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者坐位或仰卧位，考生站在被检查者右侧。	1
（二）检查内容及方法	
1.坐位姿势检查1： （1）被检者取坐位并自然屈曲膝关节成90°左右，考生站在被检者右侧。 （2）考生左手置于被检者腘窝处，轻轻托起被检者膝关节，右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。 （3）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	3
2.坐位姿势检查2： （1）被检者取坐位并自然屈曲膝关节成90°左右，然后将一侧下肢架于另一侧下肢之上，放松（架二郎腿姿势），考生站在被检者右侧。 （2）考生左手示指置于被检者髌骨上方，右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。 （3）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	3
3.卧位检查： （1）被检者取仰卧位，考生站在被检者右侧。 （2）考生以左手托起膝关节使之屈曲约120°，用右手持叩诊锤叩击髌骨下缘和胫骨粗隆之间的股四头肌肌腱。 （3）考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	3
（三）报告检查结果和阳性表现	
报告检查结果：膝反射正常表现为叩击股四头肌肌腱时引发股四头肌收缩，小腿伸展动作。膝反射对应的脊髓节段是L2～4。	1

(2) 浅反射（腹壁反射）（5分）

评分标准	分值（分）
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者排尿后仰卧位，双膝稍屈曲，使腹肌松弛。考生站在被检查者右侧。	1
（二）检查内容及方法	
考生用钝头竹签分别沿肋缘下（胸髓7~8）、平脐（胸髓9~10）和腹股沟上（胸髓11~12），由外向内轻划两侧腹壁皮肤，分别称为上、中、下腹壁反射。	1
正常反应是上、中或下部局部腹肌收缩。	1
考生需检查双侧反射，若只检查一侧扣0.5分	1
（三）报告检查结果和阳性表现	
报告检查结果：腹壁反射正常，无明显减弱或消失。若某一腹壁反射消失，多提示相应的脊髓节段损伤。	1

2.脑膜刺激征

颈强直、Kernig 征、Brudzinski 征

评分标准	分值（6分）
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检者去枕取仰卧位（0.15分），双下肢自然伸直（0.15分），考生站立于被检者右侧（0.2分）。	0.5
（二）检查内容及方法	
1. 颈强直：被检者去枕平卧（0.1分），考生左手置于被检者枕部（0.1分），右手轻按被检者胸前（0.1分），左手托扶被检者枕部并作屈颈动作（0.1分），体会被检者颈部有无抵抗感及其程度（0.1分）。	0.5
2. Kernig 征（须检查双侧，若只查一侧本项不能得满分）：考生左手固定被检者右侧或左侧膝关节（0.15分），右手托持于被检者右侧或左侧足跟部（0.15分），屈曲髋、膝关节使之均呈90°（0.3分），右手抬高被检者小腿并使之伸膝达135°以上（0.15分）。同样方法（0.75分）。	1.5
3. Brudzinski 征：考生右手轻按被检者胸前（0.5分），左手托扶被检者枕部并作屈颈动作（0.5分），观察被检者髋、膝关节有无屈曲动作（0.5分）。	1.5
（三）报告检查结果和阳性表现	
1.报告检查结果正确：脑膜刺激征为阳性或阴性（正常人脑膜刺激征为阴性）。	0.5
2. 口述阳性表现正确：颈强直阳性表现为被动屈颈时抵抗力增强（0.5分），Kernig 征阳性表现为伸膝受阻伴有疼痛或下肢屈肌牵拉痉挛（0.5分），Brudzinski 征阳性表现为双侧膝关节和髋关节屈曲（0.5分）。	1.5

3.病理反射（Babinski 征）

评分标准	分值(5分)
（一）考生站位，告知被检者体位、姿势	
告知被检查者取仰卧位，双上肢自然伸直置于躯干两侧，双下肢自然伸直，考生站在被检查者右侧，嘱被检查者放松。（口述）	1
（二）检查内容及方法	
1. 考生左手扶持被检查者踝关节，右手用竹签沿患者足底外侧缘，由后向前至小趾近跟部并转向内侧，阳性反应为踇趾背伸，其余四趾呈扇形展开。	1
2. 考生须检查双侧反射，若只检查一侧扣1分。	1
（三）报告检查结果	
1. 阳性表现为踇趾背伸，其余四趾向背部呈扇形张开。	1
2. Babinski 征阳性多提示上运动神经元损伤。	1

四、基本操作

（一）手术区消毒、铺巾

情景 1

临床情景：李女士,42岁。转移性右下腹痛1天，加重6小时。腹痛无明显缓解且进行性加重。现麦氏点有固定压痛、反跳痛。拟经麦氏交错切口行阑尾切除手术，术前准备已完成。

要求：请用碘伏为患者进行手术区域消毒并铺手术单。

评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）20（分）

一、操作过程

（一）消毒前准备

1. 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）	0.5
2. 手术野皮肤暴露范围正确：上自剑突，下至大腿中段。	1
3. 手术刷手（可口述）。	0.5

（二）消毒操作过程

1. 考生一手端盛有碘伏棉球的消毒碗，另一手持卵圆钳，站立于患者右侧。	1
2. 首先将碘伏滴入肚脐内，涂擦时绕过肚脐。涂擦完毕，翻过卵圆钳用棉球的另一侧将肚脐内的消毒液沾干（第2遍和第3遍可不再专门沾肚脐，也可以和第1遍相同）。	2
3. 以麦氏切口为中心，自上而下、由内及外消毒皮肤（1分）。每一次涂擦不留空白区（1分）。	2
4. 共消毒3遍,每遍均不超过前一遍范围。	1
5. 消毒过程中，一直保持卵圆钳头端低于握持端。	1
6. 消毒范围上自剑突，下至大腿上、中1/3交界处，两侧至腋中线。	1

（三）铺巾操作过程

1. 用四块无菌巾，内折少许，铺盖在拟定切口四周，反折部靠近切口。铺巾后手术野皮肤暴露不要过于宽大。	2
2. 先铺患者会阴侧无菌巾，最后铺靠近考生侧无菌巾。用四把巾针固定。	2
3. 铺中单（考官协助）：在拟定切口上下方各铺一块中单。	1
4. 铺大单（考官协助）：铺大单时先将洞口对准拟定切口，然后将大单头盖过麻醉架两侧和足端下垂超过手术台边30cm。	1

（四）提问

1. 碘伏消毒的优点是什么？ 答：优点是不需要脱碘，刺激性小，适用于各个部位的消毒。	2
---	---

2若术者已经穿好手术衣，请问铺治疗巾时应该先铺哪一侧？ 答：应先铺术者这一侧，可以避免术者的手术衣受到污染。	
二、医学人文素养	
1.在操作过程中无菌观念强，动作轻柔规范，体现爱护患者的意识。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

情景 2

临床情景： 刘先生,62岁。右下腹痛2天，逐渐加重，体温38.2℃，有下腹压痛，全腹增强CT显示盆腔6m×4m肿块，拟经右下经腹直肌切口手术治疗，现术前准备已完成。	
要求： 请用碘酊和酒精为患者进行手术区域消毒并铺手术单。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	20（分）
一、操作过程	
（一）消毒前准备	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）	0.5
2.手术野皮肤暴露范围正确：上自剑突，下至大腿中段。	1
3.手术刷手（可口述）。	0.5
（二）消毒操作过程	
1.考生一手端盛有2%碘酊或70%酒精棉球的消毒碗，另一手持卵圆钳，站立于患者右侧。	1
2.第一遍用碘酊涂擦，首先将碘酊滴入肚脐内，涂擦完毕，翻过卵圆钳用棉球的另一侧将肚脐内的消毒液沾干，晾干后第二遍和第三遍用70%酒精棉球涂擦脱碘。	2
3.以右下经腹直肌切口为中心，自上而下、由内及外消毒皮肤（1分）。每一次涂擦不留空白区（1分）。	2
4.每遍均不超过前一遍范围。	1
5.消毒过程中，一直保持卵圆钳头端低于握持端。	1
6.消毒范围上自剑突，下至大腿上、中1/3交界处，两侧至腋中线。	1
（三）铺巾操作过程	
1.用四块无菌巾，内折少许，铺盖在拟定切口四周，反折部靠近切口。铺巾后手术野皮肤暴露不要过于宽大。	2
2.先铺患者会阴侧或考生对侧无菌巾，最后铺考生侧无菌巾。用四把巾针固定。	2

3.铺中单（考官协助）：在拟定切口上下方各铺一块中单。	1
4.铺大单（考官协助）：铺大单时先将洞口对准拟定切口，然后将大单头盖过麻醉架两侧和足端下垂超过手术台边30cm。	1
（四）提问	
应用2%碘酊进行皮肤消毒后，为什么要用70%酒精脱碘？ 答：用酒精脱碘可以避免碘在皮肤表面滞留时间过长而损伤表皮	2
二、医学人文素养	
1.在操作过程中无菌观念强，动作轻柔规范，体现爱护患者的意识。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

（二）手术刷手法

临床情景：您正在准备参加一台胃大部切除手术	
要求：请用肥皂水刷手法进行刷手。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	
20（分）	
一、操作过程	
（一）刷手前的准备	
1.换鞋、换刷手衣，戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）。	1
2.将刷手衣衣袖挽至肘上10cm处。	1
（二）刷手及擦干燥过程	
1.刷手：考生用消毒毛刷蘸消毒肥皂水刷手，按指尖、手、腕、前臂至肘上10cm处顺序进行（2分）。两上肢各部位按顺序交替进行刷洗（1分）。	3
2.刷完一次后用清水将肥皂水冲去（1分）。冲洗时保持拱手姿势（1分）。共刷洗3遍，每遍3分钟（可口述）（1分）。	3
3.擦手：折叠无菌小毛巾成三角形，尖端朝下，由手部向上臂（肘上6cm处）顺序擦干（2分）	2
4.先擦于一只手臂，翻转毛巾或更换毛巾再擦另一只手臂（1分）。擦过肘部的毛巾不能再接触手和前臂（1分）。	2
（三）浸泡及晾干过程	
1.将手、前臂到肘上6cm处浸泡在70%酒精内。	2
2.浸泡时间5分钟（可口述）。	1
3.手臂浸泡后保持拱手姿势，待其自然晾干	1
（四）提问	
1.肥皂水刷手时，特别要注意哪些部位的刷洗？（1分） 答：特别要注意甲缘、甲沟、指缝及肘部的刷洗。	2
2.手术刷手时，是否需要应用无菌生理盐水冲洗？为什么？（1分） 答：不需要。刷手过程主要是为了清洁手臂，而不是消毒。	
二、医学人文素养	
1.在操作过程中，无菌观念强，动作轻柔规范。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素。	

(三) (四) 穿、脱手术衣；戴无菌手套

临床情景： 您现在要参加腹腔镜胆囊切除术，已完成手臂消毒。	
要求： 请穿无菌手术衣（前交叉式），戴无菌手套。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	
20 (分)	
一、操作过程	
(一) 穿无菌手术衣、戴无菌手套过程	
1.拿起叠放着的手术衣，双手不能触及下面的手术衣。	1
2.双手分别提起手术衣的衣领两端，抖开手术衣，有腰带的一面向外。	1
3.将手术衣略向上抛起，顺势双手向前上方同时插入袖筒，助手在身后协助穿。	1
4.身体略向前倾，使腰带悬垂离开手术衣（1分）；双手交叉提起左右腰带向后递由助手在身后接住并打结（2分）	3
5.穿手术衣过程中，手及前臂不能高过双肩，不能低于腰部。	1
6.戴无菌手套 (1) 左手自手套袋内捏住手套翻折部，取出手套，右手插入右手手套内（1分）。 (2) 已戴手套的右手（除拇指外）四指插入左手手套翻折部，左手插入手套内，左手手套翻折部翻至手术衣袖口上（1分）。 (3) 用戴好手套的左手四指插入右手手套的折部，将翻折部翻至右手手术衣袖口上（1分）。	3
(二) 脱手术衣、手套的过程	
1.嘱助手在背后解开腰带及领结等。	1
2.嘱助手面对考生，拉住考生手术衣衣领，向前翻转拉下手术衣，使手套套口翻于手腕部。	1
3.考生一手插入另一手手套的翻折部，脱下手套（1分）；已脱掉手套的手捏住另一手手套的内面，脱下第二只手套（1分）	2
4. 双手不能接触手套的外侧面。	2
(三) 提问	
穿包背式手术衣时，应该先系腰带还是先戴无菌手套?为什么? 答：应先戴无菌手套，因为腰带系于腰前，是绝对无菌区域。	2
二、医学人文素养	
1.在操作过程中，无菌观念强，动作轻柔规范。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

（五）手术基本操作（切开、缝合、结扎、止血）

情景 1

临床情景： 黄女士,38岁。发现右上肢皮下肿块5年，近期略增大，无特殊不适。大小约3cmx3cm，体检可触及，与周围组织界限清晰，质软，活动度可，无明显压痛。诊断为脂肪瘤。拟行脂肪瘤切除术。	
要求： 请为患者（医学模拟人或模具）行切开、缝合的操作（切口长3cm，间断缝3针，不做肿瘤切除）	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	
20（分）	
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），手术刷手（口述）。	1
2.以预定切口为中心从内向外行手术区域的常规消毒3遍，范围正确，手术区铺洞巾。	1
3.戴无菌手套。	1
4.选择合适的刀片、三角针、缝线。	1
（二）切开、缝合操作过程	
1.用2%利多卡因行局部浸润麻醉。	1
2.安装刀片正确。	1
3.用拇指和示指在切口两侧固定皮肤（1分）；在模具上作皮肤切开，执刀方法正确（1分）；切开的手法正确（垂直进刀，水平走刀，垂直出刀）（1分）。	3
4.切口长度适中，切口整齐，深度均匀。	1
5.缝后合前先用70%酒精棉球消毒切口旁皮肤，一手持有齿镊，另一手持持针器，握持方法正确，持针钳夹针位置正确（钳夹缝针的中后1/3）。	1
6.缝合伤口：缝合手法正确（垂直进针，沿缝针弧度挽出），不留死腔（2分）打结手法正确，松紧适度，剪线手法正确，线头长短适中（1分）	3
7.针距、边距恰当（1分）；皮肤对合整齐（1分）	2
（三）提问	
1.皮肤切开时，为什么术者常常绷紧皮肤？ 答：为了固定皮肤，这样切口可以更加整齐。 2.腹腔内丝线结扎后，剪线线头应保留多长？ 答：丝线线头应保留2mm。	2
二、医学人文素养	
1.操作前能以和的态度告知患者手术的目的，取得患者的配合。操作时	2

注意无菌观念，动作轻柔，体现爱护患者的意识，操作结束后告知患者有关注意事项。	
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

情景 2

临床情景：王女士，35岁。诊断为皮质囊肿并行手术治疗，现术中已经切除肿物。	
要求：请为患者（医学模拟人或模具）行切口皮肤缝合、打结（要求单纯单手打结方法打结）。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	
20（分）	
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），手术刷手（口述）。	1
2.戴无菌手套。	1
3.选择合适的刀片、三角针、缝线。	1
4. 用70%酒精棉球消毒切口皮肤，手术区域利多卡因麻醉。	1
（二）缝合、打结操作过程	
1. 持有齿镊方法正确，提起缝合皮缘	1
2. 持针器握持方法正确，持针器夹针位置正确（缝针的中后1/3处）	2
3. 缝合伤口：缝合手法正确（垂直进针，沿缝针弧度挽出），不留死腔。	2
4. 打结手法正确：结扎线来回方向交错，第一个结与第二个结方向相反（2分）。结扎牢固可靠，不滑脱。松紧适度（2分）。	4
5. 剪线手法正确，线头长短适中。	1
6.针距、边距恰当（1分）；皮肤对合整齐（1分）	2
（三）提问	
1. 常用的内翻缝合法有哪几种？ 答：垂直褥式内翻缝合法、水平褥式内翻缝合法以及荷包缝合法。（答出任意两项得1分）。	2
2. 在胸、腹腔内行深部打结，主要应用哪一种打结方法?为什么？ 答：主要用双手打结法，因为这种方法结扎更可靠。	
二、医学人文素养	
1.操作前能以和的态度告知患者手术的目的，取得患者的配合。操作时注意无菌观念，动作轻柔，体现爱护患者的意识，操作结束后告知患者有关注意事项。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

(六) 清创术

临床情景：姜女士,41岁。由于交通事故左小腿软组织损伤2小时。伤口长6cm,深达肌层,有渗血。

要求：为患者行清创术,并单纯间断缝合2针。

评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣 2 分,扣完为止)20 (分)

一、操作过程

(一) 操作前准备

1.戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外露),洗手(口述)。	1
2.戴无菌手套	1

(二) 清创、缝合操作过程

1.用无菌纱布盖伤口,用肥皂水刷洗伤口周围皮肤。	1
2.移去伤口纱布,用3%过氧化氢溶液及生理盐水反复冲洗伤口,初步检查伤口。	2
3.脱手套,消毒手臂(口述)。	1
4.伤口周围皮肤消毒2~3遍,方法规范。范围正确,铺洞巾。	1
5.戴无菌手套。	1
6.用2%利多卡因沿切口行局部浸润麻醉。	1
7.修剪创缘皮肤,去除可能存在的异物及失活组织(2分)。用3%过氧化氢溶液和生理盐水再次冲洗伤口(1分)。	3
8.缝合操作:缝合手法正确(垂直进针,沿缝针弧度穿出),不留死腔。	2
9.用70%酒精棉球消毒伤口周围皮肤(1分)。用无菌纱布或棉垫覆盖伤口,胶布固定(1分)。	2

(三) 提问

开放性损伤的伤口具备什么条件可以一期缝合? 答:①通常伤后6~8小时内清创一般都可一期缝合,如果伤口污染较轻且不超过8~12小时,经彻底清创后可考虑一期缝合(1分)。 ②头面部的伤口,一般在伤后24~48小时以内经清创后可行一期缝合(1分)。	2
---	---

二、医学人文素养

1.操作前能以和的态度告知患者手术的目的,取得患者的配合。操作时注意无菌观念,动作轻柔,体现爱护患者的意识,操作结束后告知患者有关注意事项	2
2.着装整洁,仪表端庄,举止大方,语言文明,认真细致,表现出良好的职业素质。	

(七) 开放性伤口的止血包扎

临床情景： 李先生，42岁。因施工导致左前臂损伤。于现场检查可见左前臂有反常活动，伤口有活动性出血。 要求： 请用止血带、夹板等为患者（医学模拟人）行止血、固定处理。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	
20（分）	
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.快速检测患者的主要生命体征（口述）。	1
2.准备止血带、夹板等。	1
（二）止血、固定操作过程	
1.止血带位置选择：右上臂上1/3处	2
2.绕扎止血带：在扎止血带处置衬垫物（1分），绕扎松紧程度以控制出血、右侧桡动脉摸不到搏动为宜（1分）。	2
3.在标志牌上记录使用止血带的开始时间。	2
4.充分暴露右前臂，伤口创面用无菌纱布或棉垫覆盖并固定。	1
5.夹板长度超过肘关节和腕关节，置于前臂四侧。	2
6.固定前用毛巾等软物铺垫在夹板与肢体间。	2
7.用绷带捆扎固定夹板，上端固定至上臂，下端固定至手掌。	1
8.先捆扎骨折的下部，以减轻水肿，松紧度以绷带上下可移动1cm为宜。	2
（三）提问	
1.压迫止血有哪些方法 答：指压止血法、加压包扎止血法、填塞止血法以及止血带止血法。（答出任意两项得1分）。 2.加压包扎止血法有什么禁忌？ 答：伤口内有碎骨片或主要神经干暴露于伤口内禁用此法，以免加重损伤。	2
二、医学人文素养	
1.操作前能以和的态度告知患者手术的目的，取得患者的配合，关注患者的疼痛程度并给予适当的处理，缓解焦虑紧张情绪。操作时注意无菌观念，动作轻柔，体现爱护患者的意识，操作结束后告知患者有关注意事项。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

（八）脓肿切开术

临床情景： 方先生,45岁，糖尿病5年，平日血糖控制不佳，右臀部皮下3cm×3cm大小肛周脓肿,波动感阳性。 要求： 为患者行脓肿切开引流术	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	20（分）
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），完成手术刷手（口述）。	1
2.以预定切口为中心从外向内行手术区域的常规消毒3遍，范围正确（1分）。手术区铺洞巾（1分）。	2
3.戴无菌手套。	1
（二）脓肿切开操作过程	
1.用2%利多卡因局部浸润麻醉。	1
2.正确安装尖头刀片。	1
3.在脓肿中央用反挑式执刀法做皮肤切开（2分），排出脓液，用手指进入脓腔，探查其形状及大小（2分），根据探查结果用刀延长切口至脓肿边界，以引流通畅为原则（2分）。	6
4.3%过氧化氢溶液冲洗脓腔，再用无菌生理盐水冲净过氧化氢溶液。	2
5.脓腔内填塞凡士林纱布，松紧度以不出血为准。	1
6.无菌纱布覆盖伤口，胶布固定。	1
（三）提问	
1.如何判断深部感染时脓肿已经形成？ 答：穿刺抽出脓液（0.5分）或影像学检查发现脓肿形成（0.5分） 2.脓肿切开的原则是什么？ 答：切口要足够大（0.5分），要考虑患者站立及仰卧时的最低引流位（0.5分）	2
二、医学人文素养	
1.操作前能以和的态度告知患者手术的目的，取得患者的配合。操作时注意无菌观念，动作轻柔，体现爱护患者的意识，操作结束后告知患者有关注意事项	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

（九）换药与拆线

情景 1

临床情景： 陈某某，女，28岁。今日为甲状腺肿物行左侧甲状腺腺叶切除术后第2天。	
要求： 为患者切口行换药处理。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	
20（分）	
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）。	1
2.患者取仰卧位，充分暴露手术切口部位，洗手（口述）。	1
3.材料准备：两只换药碗（盘）、两把镊子、适量的70%酒精棉球和敷料等。	2
（二）换药过程	
1.用手移去外层敷料（1分），内层敷料用镊子夹起，将其放置在盛污物的换药碗（盘）内（2分）。	3
2.一把镊子接触伤口，另一把镊子传递换药碗中的清洁物品（3分）；操作过程中镊子头部应低于手持部以避免污染（2分）。	5
3.观察伤口的情况（口述）。用70%酒精棉球消毒伤口周围皮肤2遍。	2
4.无菌敷料覆盖伤口并围定。粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直，长短适宜。	2
（三）提问	
1.换药的目的是什么？ 答：换药的目的是为了观察并处理伤口，促使伤口更好愈合。 2.换药中发现伤口的肉芽过度生长，应如何处理？（1分） 答：可将其剪除，再用生理盐水棉球擦拭，压迫止血（0.5分）。也可用硝酸银溶液烧灼，再用生理盐水擦拭（0.5分）	2
二、医学人文素养	
1.操作前能以和的态度告知患者手术的目的，取得患者的配合。操作时注意无菌观念，动作轻柔，体现爱护患者的意识，操作结束后告知患者有关注意事项	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

情景2

临床情景：杨先生，56岁。今日为胃部肿物切除术术后第7天，切口无红肿及渗液。	
要求：为患者切口拆线。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	
20（分）	
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）。	1
2.患者取仰卧位，充分暴露手术切口部位，洗手（口述）。	1
3.材料准备：两只换药碗（盘）、两把镊子、线剪、适量的70%酒精棉球和敷料等。	2
（二）换药过程	
1.用手移去外层敷料，内层敷料用镊子夹起，将其放置在盛污物的换药碗（盘）内（2分）。	2
2.一把镊子接触伤口，另一把镊子传递换药碗中的清洁物品（2分）；操作过程中镊子头部应低于手持部以避免污染（1分）。	3
3.用70%酒精棉球消毒伤口周围皮肤2遍。	1
4.用镊子轻轻提起线结，使原来在皮下的一小段缝线露出，另一手持线剪，贴着皮肤将新露出的缝线段剪断。	2
5.持镊将缝线抽出，抽线的方向朝向伤口侧。	2
6.拆线后检查伤口愈合情况，用70%酒精棉球重新消毒伤口一次。	1
7.无菌敷料覆盖伤口并围定。粘贴胶布的方向应与躯干长轴垂直，长短适宜。	1
（三）提问	
1.下腹部切口一般术后第几天拆线？ 答：术后第6~7天拆线。	2
2.拆线时为什么要提起线结，剪断重新露出的缝线段？ 答：皮肤表面的缝线可能有细菌污染，这样抽线时可避免细菌污染线道	
二、医学人文素养	
1.操作前能以和的态度告知患者手术的目的，取得患者的配合。操作时注意无菌观念，动作轻柔，体现爱护患者的意识，操作结束后告知患者有关注意事项。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	

(十) 吸氧术

临床情景：张先生，70岁。因发热、咳嗽10天加重伴气短2天入院。诊断为I型呼吸衰竭、重症肺炎。PaO₂:40mmHg, PaCO₂: 25mmHg。

要求：请为患者（医学模拟人或模具）行面罩吸氧。

评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止） **20（分）**

一、操作过程（17分）**（一）操作前准备（5分）**

1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述）。	1
2.准备并检查物品：治疗盘、弯盘、治疗碗内盛冷开水、棉签、中心供氧装置（或氧气筒及压力表）湿化瓶、流量表、（无菌蒸馏水）、吸氧面罩、手电筒、扳手、笔、用氧记录单、手消毒液、生活垃圾桶、医用垃圾桶。	1
3.核对患者、解释操作目的（您好，我是XX医生，为了缓解您呼吸困难症状，改善缺氧情况现在给您面罩吸氧）取得配合,协助患者取得舒适卧位。	1
4.评估患者、检查鼻腔、用湿棉签清洁两侧鼻孔。	1
5.连接吸氧装置： a、如中心供氧：将流量表插入气流出口处，（加入湿化液）→连接湿化瓶→连接氧气管； b、如为氧气筒：打开总开关再关闭→（加入湿化液）→连氧气表→连湿化瓶→关流量表→开总开关、开流量表检查有无漏气→关流量表→连接氧气管	1

（二）面罩吸氧操作过程（12分）

1.打开流量表，检查氧气管是否通畅。	2
2.将氧气管连接于面罩的进气孔上。	2
3.根据病情调节氧流量（6-8L/分）。	2
4.将面罩放置于病人口鼻部，调整位置，松紧带固定，询问患者松紧度是否适宜。	2
5.观察吸氧情况。	1
6.洗手、记录吸氧开始时间、氧流量。	1
7.核对、告知注意事项（请保持吸氧管路通畅，防止脱出、受压，不要随意自行调节氧流量、不可以吸烟及使用明火）。	2
二、医学人文素养（3分）	

1.仪表端庄，着装（工作服）整洁，举止大方。	0.5
2.操作规范，认真细致（0.5分），有体现爱护患者的动作（0.5分），良好沟通（0.5分）。	1.5
3.主动自我介绍（0.5分），语言文明，态度和蔼（0.5分）。	1

（十一）吸痰术

1.吸痰术（经口）

临床情景： 李先生，56岁，发热、因车祸致颅脑损伤入院5天，查体：神志清，咳嗽反应差，喉部可闻及明显痰鸣音。头颅CT示颅底骨折。T：37.8，P：69次/分，Bp：140/92mmHg，血氧饱和度92%，请为患者吸痰。 要求： 请为患者（医学模拟人或模具）吸痰。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣2分，扣完为止）	20分
一、操作过程（17分）	
（一）操作前准备（2分）	
1.操作者准备：戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外漏）、洗手（口述）。	0.5
2.物品准备：电动吸引器或中心负压吸引装置、治疗盘、弯盘、无菌生理盐水缸2个（试吸1、冲洗1）、无菌棉签、手电筒、一次性吸痰管（一次性无菌手套、无菌治疗巾）、无菌纱布、胶布、手消毒液、医用垃圾桶、生活垃圾桶。	0.5
3.患者准备：核对患者，告知患者操作目的（患者有颅底骨折，需经口腔吸痰），取得合作；协助患者取平卧位，患者头偏一侧，面向操作者，头略向后仰。	1
（二）吸痰操作过程（15分）	
1.评估患者病情，检查口鼻腔。	1
2.接通电源，打开吸引器开关，检查吸引器性能，调节负压（成人40～53.3kpa）。	1
3.打开一次性无菌吸痰管包装，取出一次性无菌手套，戴手套，铺一次性无菌治疗纸，取出吸痰管，连接负压吸引管。	1
4.润滑吸痰管前端，确认吸痰管通畅。（口述吸痰管通畅）	1
5.嘱患者张口，一手反折吸痰管末端，另一戴无菌手套的手持吸痰管前端，轻轻将吸痰管插入口咽部，给予负压，先吸口咽部分泌物，在患者吸气时顺势将吸痰管经过咽喉部（约15cm）插入气管达一定深度，左右旋转、缓慢上提式吸尽痰液。吸痰过程中动作轻柔，指导患者深呼吸，避免患者紧张，指导患者进行有效咳嗽。	3
6.吸痰中注意观察患者气道是否通畅、面色、呼吸及痰液的色、质、量。	2
7.吸痰毕，分离并处理吸痰管，反脱手套包住吸痰管，弃去，冲洗吸引器导管。	2
8.关吸引器开关，将吸引器导管末端纱布包裹，妥善放于吸引器上。	1

9.纱布或纸巾擦拭口鼻分泌物，撤下治疗巾。	0.5
10.协助患者取舒适卧位，整理床单位。	0.5
11.核对患者、告知注意事项。（适量饮水稀释痰液，有痰轻轻咳出来、不要剧烈咳嗽）。	1
12.洗手，记录吸痰时间、痰液量、粘稠度、气味、患者反应等（口述）。	1
二、医学人文素养（3分）	
1.仪表端庄，举止大方，着装符合要求（服装、鞋帽整洁，发不过肩，戴筒帽遮发、露耳）。	0.5
2.操作时动作轻柔规范，认真细致（0.5分），注意保护隐私（0.5分），有体现关爱患者的动作（0.5分）。	1.5
3.主动自我介绍（0.5分），语言文明态度和蔼（0.5分）。	1

2.吸痰术（经口鼻）

临床情景： 张先生，78岁，咳嗽咳痰1周入院。患者痰多，不易咳出。体检双肺可闻及痰鸣音，请为患者吸痰。 要求： 请为患者（医学模拟人或模具）吸痰。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣2分，扣完为止）	20分
一、操作过程（17分）	
（一）操作前准备（2分）	
1.操作者准备：戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外漏）、洗手（口述）。	0.5
2.物品准备：电动吸引器或中心负压吸引装置、治疗盘、弯盘、无菌生理盐水缸2个（试吸1、冲洗1）、无菌棉签、手电筒、一次性吸痰管2~3根（一次性无菌手套、无菌治疗巾）、无菌纱布、胶布、手消毒液、医用垃圾桶、生活垃圾桶。	0.5
3.患者准备：核对患者，告知患者操作目的，取得合作；协助患者取平卧位，患者头偏一侧，面向操作者，头略向后仰。	1
（二）操作过程（15分）	
1.评估患者病情，检查口、鼻腔。	1
2.接通电源，打开吸引器开关，检查吸引器性能，调节负压（成人40~53.3kpa）。	1
3.打开一次性无菌吸痰管包装，取出一一次性无菌手套，戴手套，铺一次性无菌治疗纸，取出吸痰管，连接负压吸引管。	1
4.润滑吸痰管前端，确认吸痰管通畅。	0.5

5.嘱患者张口，一手反折吸痰管末端，另一戴无菌手套的手持吸痰管前端，轻轻将吸痰管插入口咽部（0.5分）给予负压，先吸口咽部分泌物（1分），在患者吸气时顺势将吸痰管插入咽喉部（约15cm）（0.5分），缓慢旋转上提式吸尽痰液（1分）。吸痰过程中动作轻柔，指导患者深呼吸，避免患者紧张，指导患者进行有效咳嗽。	3
6.吸痰中注意观察患者气道是否通畅、面色、呼吸及痰液的色、质、量。	0.5
7.吸痰毕，分离并处理吸痰管，反脱手套包住吸痰管，弃去，冲洗吸引器导管。	0.5
8.根据病情需要再次为患者经鼻腔吸痰：清洁鼻腔（0.5分），更换吸痰管（1.5分）	2
9.经鼻腔插入吸痰管，在患者吸气时插入吸痰管至气管达一定深度（1分），给予负压，左右旋转、缓慢上提式吸尽痰液（1分）。	2
10.吸痰后抽吸生理盐水冲洗管路，关吸引器开关，将吸引器导管末端包裹，妥善放于吸引器上。	1
11.纱布或纸巾擦拭口鼻分泌物，撤下治疗巾。	0.5
12.协助患者取舒适卧位，整理床单位。	0.5
13.核对患者、告知注意事项（平时多饮水稀释痰液、有痰尽量咳出）。	1
14.洗手，记录吸痰时间、痰液量、粘稠度、气味、患者反应等（口述）。	0.5
二、医学人文素养（3分）	
1.仪表端庄，举止大方，着装符合要求（服装、鞋帽整洁，发不过肩，戴筒帽遮发、露耳）。	0.5
2.操作时动作轻柔规范，认真细致（0.5分），注意保护隐私（0.5分），有体现关爱患者的动作（0.5分）。	1.5
3.主动自我介绍（0.5分），语言文明态度和蔼（0.5分）。	1

(十二) 胃管置入术

临床情景：李先生，45岁。因上腹部持续性剧烈疼痛伴腹胀3小时急诊入院。腹部CT示：胰腺弥漫性肿大，胰周呈渗出性改变。诊断为：急性胰腺炎。

要求：请为患者（医学模拟人或模具）插胃管，行胃肠减压。

评分标准	20 (分)
一、操作过程	
(一) 操作前准备 (5分)	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述）。	0.5
2.准备并检查物品：治疗盘、弯盘、治疗巾、盛水的治疗碗、手电筒、棉签、胃管、纱布、石蜡油/球、20毫升注射器、无菌手套、听诊器、PH试纸、胶布、负压引流盒（别针）、手消毒液、生活垃圾桶、医用垃圾桶、锐器盒。	1
3.核对患者、解释操作目的（您好，我是XX医生,为了减轻您腹胀情况，现在给您下胃管引流出胃内积存的气体、液体）取得配合。	1
4.协助患者取半卧位，暴露剑突（注意保暖，少暴露患者），铺治疗巾、将弯盘置于口角旁。	1
5.评估患者、检查鼻腔（用手遮挡光线，避免刺眼）、用棉签清洁鼻孔。	1
6.物品备用状态：（注射器、纱布及石蜡油球、胃管），戴无菌手套。	0.5
(二) 插胃管操作过程 (12分)	
1.取出胃管，测量长度（前额发际至胸骨剑突处），用石蜡油棉球或纱布润滑胃管前端。	2
2.沿选定侧鼻孔插入胃管，插入10-15cm（咽喉部）时，嘱患者做吞咽动作，顺势将胃管向前推进，直至预定长度（约45-55cm），插管时动作轻柔。	2
3.嘱病人张口，查看胃管是否盘曲在口中。	1
4.确定胃管是否在胃内（选用以下三种方法之一即可） 回抽胃液法：经胃管末端抽出胃液。 听气过水声：将听诊器置于病人胃部，快速经胃管向胃内注入10ml空气，听到气过水声。 观察有无气泡逸出：将胃管末端置于盛水的治疗碗中，无气泡逸出。	2
5.确定胃管在胃内后，擦拭口鼻处分泌物。脱手套。胶布固定胃管于鼻翼及面颊部。	1
6.将胃管末端连接负压引流盒，用别针将负压引流盒固定于枕旁。	1

7.整理物品、整理病人。	1
8.核对病人、告知注意事项（请保持引流通畅，防止胃管脱出、打折、受压）。	1
9.洗手、记录（口述：置管时间、置管长度、引出胃内容物的颜色、性质、量及气味）	1
二、医学人文素养（3分）	
1.仪表端庄，着装（工作服）整洁，举止大方。	0.5
2.操作规范，认真细致（0.5分），有体现爱护患者的动作（0.5分），注意保护患者隐私（0.5分）。	1.5
3.主动自我介绍（0.5分），语言文明，态度和蔼（0.5分）。	1

（十三）三腔二囊管止血法

临床情景： 患者张XX，男性，44岁。黑便2天，呕血6小时入院。既往乙肝病史20年，诊断：上消化道大出血 食管胃底静脉曲张破裂出血 乙肝后肝硬化 要求： 请用三腔两囊管为患者（医学模拟人）止血	
评分标准	20（分）
一、操作过程（18 分）	
1 操作前准备（4分）	
（1）术前沟通：核对患者信息，评估患者的身体状况，解释三腔管的目的，签署知情同意书。戴帽子、口罩、六步洗手法洗手，戴手套。	1
（2）物品准备：三腔两囊管、血压计、50毫升注射器、血管钳3把、液体石蜡、无菌纱布、盐袋	2
（3）患者取合适体位（平卧或侧卧），检查患者鼻腔是否通畅，用湿面签清洁鼻孔。戴手套。	1
2 插管操作过程（14分）	
（1）检查三腔管的食管囊、胃囊和胃管是否通畅，充气后气囊是否漏气，有无膨胀不均，并标记充气量，及气囊内压力，找到管壁上45、60、65的标记和三腔通道的外口。	2
（2）尽量抽尽双气囊的其他，用血管钳夹紧管口。估计插入的长度（取患者发际至剑突+8-10cm并用胶布做好标记）。	2
（3）用液体石蜡纱布充分涂抹三腔两囊管	1
（4）将前端自患者一侧鼻孔插入，到达咽部时嘱患者配合吞咽，插入50-65cm，经胃管抽出胃液或血液，或经胃管注入空气在剑突下听诊有气过水声，确定胃囊在胃内	2
（5）用注射器向胃囊注入150-200毫升气体，测胃囊压力50-70mmHg，用血管钳将此腔夹闭	2
（6）充气后固定：向外牵拉三腔管至有弹性阻力，表示胃气囊以压于胃底贲门部，即可牵引。 用绷带一端系在管口分叉处，另一端接床尾的滑轮装置，管与鼻尖成45度角，并悬挂0.5kg的沙袋（或盐水瓶）。 再将胃管连接负压引流瓶，以便引流（如果没有引流瓶就口述）。	2
（7）观察止血效果：仍未止血者，再向食道囊注气100-150ml，囊内压35-45mmHg，随即夹闭此管腔。	2
（8）记录气囊充气压迫开始时间	1
二、医学人文素养（2分）	2

- 1.操作前告知患者操作目的和难点，取得患者的配合。操作中无菌观念强，动作规范，体现爱伤意识。操作后告知相关注意事项。
- 2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。

(十四) 导尿术

1. 男性导尿术

临床情景： 王立伟，男性，75岁，排尿困难3年余，12小时未排尿。既往有前列腺增生病史。查体：下腹部膨隆，叩诊膀胱，耻骨联合上3指呈浊音。为缓解患者尿潴留状况，请予以留置导尿。 要求： 请用Foley导尿管为患者（医学模拟人或模具）留置导尿。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣2分，扣完为止）	20分
一、操作过程	
（一）操作前准备（2分）	
1. 操作者准备：戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外漏），洗手（口述）。	0.5
2. 物品准备：治疗盘、弯盘、胶布、垫巾、无菌导尿包：外层：弯盘、碘伏棉球、纱布、手套、止血钳或镊子。内层：小方盘或弯盘、（治疗碗）、球囊导尿管、集尿袋、镊子或血管钳2把、碘伏棉球、纱布、液体石蜡油球、带帽试管、注射器（内含生理盐水10-15ml）、洞巾、无菌手套。手消毒液、医用垃圾桶、生活垃圾桶。	0.5
3. 患者准备：核对患者，告知患者操作目的（我是XX医生，由于您排尿困难有尿潴留的现象，现在需要留置尿管导尿，请您配合），拉上屏风或围帘，臀下铺一次性垫巾，协助患者取屈膝仰卧位，两腿充分外展外旋，暴露会阴区域（减少暴露，注意保暖）。	1
（二）操作过程（15分）	
1. 置弯盘于两腿之间，检查一次导尿包有效期，取首次消毒用品置于两腿之间，左手戴手套。	0.5
2. 初次消毒：依次消毒阴阜→大腿内上1/3→阴茎前侧→阴茎两侧→阴茎腹侧及阴囊，左手持纱布提起阴茎，将包皮向后推，暴露尿道口，依次消毒尿道口→龟头→冠状沟。消毒顺序为从外向内、从上向下、由远到近（先对侧后己侧），每个棉球只使用一次。（每个消毒部位0.2分）	2
3. 脱手套，移去第一次消毒物品，弃于医疗垃圾桶内，再次消毒双手。	1
4. 导尿包放于患者两腿之间，无菌打开导尿包内层。	0.5
5. 带无菌手套。	0.5
6. 铺无菌孔巾。	0.5
7. 用注射器测试导尿管水囊完整性，检测导尿管通畅性，抽出水囊液体。	1.5
8. 用无菌润滑油润滑导尿管前端，连接尿管与尿袋。	1
9. 再次消毒：左手持纱布包住阴茎并后推包皮，暴露尿道口，右手持镊子依次消毒尿道口、龟头、冠状沟、尿道口，每个棉球只使用一次（每个	2

消毒部位0.5分)。	
10.左手(拇、示指)继续固定阴茎并上提,与腹壁成60°,嘱患者张口深呼吸(0.5分),用镊子夹持导尿管,对准尿道口插入20~22cm,见尿液流出夹闭尿袋关闭阀(0.5分),再插入7~10cm(0.5分),给水囊注水,轻拉导尿管至有阻力感(0.5分)。	2
11.妥善固定尿管、尿袋,打开尿液关闭阀。	1
12.撤垫巾,协助患者穿好裤子,安置舒适体位。	0.5
13.整理用物,核对,告知注意事项(尿袋不可高于膀胱,第一次放尿不可超过500ml,注意防止尿管打折、受压、脱出等情况发生)。	1
14.洗手,记录导尿时间、尿量、尿液颜色及性质等情况(口述)。	1
二、医学人文素养(3分)	
1.仪表端庄,举止大方,着装符合要求(服装、鞋帽整洁,发不过肩,戴筒帽遮发、露耳)。	0.5
2.操作时动作轻柔规范,认真细致(0.5分),注意保护隐私(0.5分),有体现关爱患者的动作(0.5分)。	1.5
3.主动自我介绍(0.5分),语言文明态度和蔼(0.5分)。	1

2.女性导尿术

临床情景: 于丽,女性,68岁,神志改变3天来诊,家属诉12小时未排尿。既往有高血压病史。体检:T:38.8℃,浅昏迷,下腹部膨隆,叩诊呈浊音。为缓解患者尿潴留状况,请为患者留置导尿。	
要求: 请用Foley导尿管为患者(医学模拟人或模具)留置导尿。	
评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则,一处扣2分,扣完为止)	20分
一、操作过程(17分)	
(一)操作前准备(2分)	
1.操作者准备:戴帽子、口罩(头发、鼻孔不外漏)、洗手(口述)。	0.5
2.物品准备:治疗盘、弯盘、胶布、垫巾、无菌导尿包:外层:弯盘、碘伏棉球、纱布、手套、止血钳或镊子。内层:小方盘或弯盘、(治疗碗)、球囊导尿管或球囊导尿管、集尿袋、镊子或血管钳2把、碘伏棉球、纱布、液体石蜡油球、带帽试管、注射器(内含生理盐水10~15ml)、洞巾、无菌手套。手消毒液、医用垃圾桶、生活垃圾桶。	0.5
3.患者准备:核对患者,告知患者操作目的(我是XX医生,由于您排尿困难有尿潴留的现象,现在需要留置尿管导尿,请您配合),拉上屏风或围帘,臀下铺一次性尿垫,协助患者取屈膝仰卧位,两腿充分外展外	1

旋，暴露会阴区域（减少暴露，注意保暖）。	
（二）操作过程（15分）	
1.置弯盘于两腿之间，检查一次导尿包有效期，取首次消毒用品至于两腿之间，左手戴手套。	0.5
2.初次消毒：依次消毒阴阜→大腿内侧上1/3→大阴唇→小阴唇（左手分开大阴唇）→尿道口→阴道口→肛周。消毒完毕，脱下手套，污物弃于医用垃圾筒。消毒顺序为从外向内、从上向下、由远到近（先对侧后己侧），每个棉球只使用一次。（每个消毒部位0.2分）。	2
3.脱手套，移去第一次消毒物品，弃于医疗垃圾桶内，再次消毒双手。	1
4.导尿包放于患者两腿之间，无菌打开导尿包内层。	0.5
5.带无菌手套。	0.5
6.铺无菌孔巾，暴露尿道口。	0.5
7.用注射器测试导尿管水囊完整性，检测导尿管通畅性，抽出水囊液体。	1.5
8.用无菌润滑油润滑导尿管前端，连接尿管与尿袋。	1
9.再次消毒：左手持纱布用拇指及食指分开并固定小阴唇，消毒尿道口→小阴唇（先对侧后己侧）→尿道口；每个棉球只使用一次。（每个消毒部位0.5分）。	2
10.左手固定不动（二次消毒固定的手法不动），嘱患者张口深呼吸，放松腹部（0.5分），右手持导尿管对准尿道口轻轻插入4~6cm，见尿液流出后，夹闭尿袋关闭阀（0.5分），再插7~10cm（0.5分），给水囊注水，轻拉导尿管至有阻力感（0.5分）。	2
11.妥善固定尿管、尿袋，打开尿液关闭阀。	1
12.撤尿垫，协助患者穿好裤子，安置舒适体位。	0.5
13.整理用物，告知注意事项（尿袋不可高于膀胱，第一次放尿不可超过500ml，注意防止尿管打折、受压、脱出等情况发生）。	1
14.洗手，记录导尿时间、尿量、尿液颜色及性质等情况（口述）。	1
二、医学人文素养（3分）	
1.仪表端庄，举止大方，着装符合要求（服装、鞋帽整洁，发不过肩，戴筒帽遮发、露耳）。	0.5
2.操作时动作轻柔规范，认真细致（0.5分），注意保护隐私（0.5分），有体现关爱患者的动作（0.5分）。	1.5
3.主动自我介绍（0.5分），语言文明态度和蔼（0.5分）。	1

（十五）动、静脉穿刺术

1.动脉穿刺术

临床情景：王女士，58岁，以“呼吸困难2小时”来院就诊。患者神志清楚，口唇发绀。体检：T：37.8℃，P：122次/分，R：30次/分，请抽血查动脉血气分析。

要求：请用动脉采血器为患者（医学模拟人或模具）采集动脉血。

评分标准	20分
一、操作过程（17分）	
（一）操作前准备（2分）	
1.操作者准备：戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外漏）、洗手（口述）。	0.5
2.物品准备：治疗盘、0.5%碘伏、无菌棉签、弯盘、动脉采血器或5ml注射器、肝素盐水、橡胶塞，治疗巾、小垫枕、无菌手套、采血申请单或条码贴、标本存放装置（冰盒或冰桶）、手消毒液、医用垃圾桶、生活垃圾桶、锐器盒。	0.5
3.患者准备：核对患者，告知患者操作目的，取得合作；协助患者取坐位或平卧位，前臂外展，掌心向上，暴露穿刺部位。	1
（二）操作过程（15分）	
1.进行Allen实验（用双手同时按压尺、桡动脉，嘱患者反复用力握拳、松拳5~7次，直至手掌发白，松开尺侧，观察见10s内手掌变红，Allen试验阴性）可以穿刺。	0.5
2.检查评估穿刺部位，前臂掌侧腕横纹上1~2cm（或桡骨茎突近端约1cm），动脉搏动最明显处，腕下置小垫枕（桡动脉穿刺），垫枕上方铺治疗巾。	1
3.以穿刺点为中心，叠瓦式消毒两次（顺、逆两个方向），直径大于5cm，待干。	1
4.准备动脉采血器：将动脉采血器针栓反复推2次混匀抗凝剂，外拉针栓至预设采血量刻度处，紧密连接针头接口处（如使用5ml注射器用肝素生理盐水冲洗备用）。	1
5.左手戴无菌手套或消毒操作者左手食指、中指2~3次（从指尖至指腹方向）。	1
6.左手食指和中指在穿刺部位相距1cm轻轻按压，以固定穿刺动脉。	1
7.右手持注射器，在两指间垂直于动脉或与动脉走向呈45°逆血流方向穿刺。	2
8.见血液顶入注射器时，固定注射器，采集预设血量或2ml血液标本。	2

9.拔针，用棉签按压穿刺部位5~10分钟直至不出血（口述），锁定针帽。	1
10.观察注射器中有无气泡，若有气泡，将其排出，血气针头弃于锐器盒，迅速拧上安全帽（如使用5毫升肝素化注射器则将针头刺入橡胶塞）。	1
11.轻轻转动注射器5s，使血液与抗凝剂充分混合。	0.5
12.标本贴条码，标记患者信息、吸氧浓度及血红蛋白浓度，低温送检。	0.5
13.整理用物，（脱手套）、整理病人。	0.5
14.核对病人，告知注意事项（不要用穿刺侧手臂提取重物、穿刺局部不要潮湿防止感染）。	1
15.洗手、记录。	1
二、医学人文素养（3分）	
（一）仪表端庄，举止大方，着装符合要求（服装、鞋帽整洁，发不过肩，戴筒帽遮发、露耳）。	0.5
（二）操作时动作轻柔规范，认真细致（0.5分），注意保护隐私（0.5分），有体现关爱患者的动作（0.5分）。	1.5
（三）主动自我介绍（0.5分），语言文明态度和蔼（0.5分）。	1

2.静脉穿刺术

临床情景： 李女士，38岁，因发现左乳肿块来诊，经检查后诊断为左侧乳腺癌。行左侧乳腺癌改良根治术后第3天，需采集静脉血复查血常规、凝血功能、肝肾功能。 要求： 请为患者（医学模拟人或模具）行静脉穿刺采血。	
评分标准	20分
一、操作过程（17分）	
（一）操作前准备（2分）	
1.操作者准备：戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外漏）、洗手（口述）。	0.5
2.物品准备：治疗盘、0.5%碘伏、无菌棉签、医嘱执行单、小垫枕、治疗巾、止血带、真空采血针或直针及持针器或5ml注射器或头皮针、真空采血管、试管架、手消毒液，医疗垃圾桶、生活垃圾桶、锐器盒。	0.5
3.患者准备：核对患者，告知患者操作目的，取得合作；评估患者禁食水时间；协助患者取坐位或平卧位，前臂外展，掌心向上，暴露穿刺位置（可选肘正中静脉、头静脉或贵要静脉穿刺）。	1
（二）操作过程（15分）	
1.核对医嘱，核对真空采血管与检验项目是否相符。	1
2.肘下置小垫枕及治疗巾，在穿刺点上方6~8cm处扎止血带（1分），	2

选择穿刺血管。	
3.以穿刺点为中心，叠瓦式消毒两次（顺逆两个方向），消毒直径大于5cm，待干。	1
4.准备采血针及干棉签（或棉签贴），连接持针器与采血针（或准备采血针），在上臂三分之一处扎止血带。	1
5.穿刺：嘱患者握拳，一手拇指绷紧，一手持采血针，针头斜面向上（1分），沿静脉走行方向，以20°~30°角进针（1分），见回血再进少许（0.5分），固定穿刺针（0.5分）。	3
6.将采血针的另一端插入真空采血管（0.5分），见采血管内有血液流出，松开止血带（1分），采血至需要量后，按顺序更换采血管：凝血功能（蓝）、肝肾功能（黄）、血常规（紫）（1分）。抗凝管应轻柔上下颠倒混匀6~8次（0.5分）。	3
7.采血毕，嘱患者松拳，松止血带，拔针，无菌干棉签按压穿刺部位3~5分钟，直至不出血为止。	1
8.采血针弃于锐器盒，整理物品、整理病人。	1
9.核对病人，告知注意事项（勿揉搓穿刺侧针眼；采血后1h内尽量减少采血肢体的活动，避免用力）。	1
10. 洗手、记录,血标本及时送检。	1
二、医学人文素养（3分）	
1.仪表端庄，举止大方，着装符合要求（服装、鞋帽整洁，发不过肩，戴筒帽遮发、露耳）。	0.5
2.操作时动作轻柔规范，认真细致（0.5分），注意保护隐私（0.5分），有体现关爱患者的动作（0.5分）。	1.5
3.主动自我介绍（0.5分），语言文明态度和蔼（0.5分）。	1

(十六) 胸腔穿刺术

临床情景：李先生，45岁。胸闷半个月，加重2天。检查发现右侧中等量积液，准备抽取胸腔积液进一步检查。

要求：请为患者（模拟人）进行诊断性胸腔穿刺。

评分标准	20分
一、操作过程（17分）	
（一）操作前准备（5分）	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述）	1
2.病人取坐位面向椅背，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂，自然呼吸。	1
3.穿刺点可行超声波定位，或选在胸部叩实音最明显部位进行，一般取肩胛下角线或腋后线第7~8肋间；也可选腋中线6~7肋间或腋前线第5肋间、为穿刺点。包裹性积液最好结合X线或超声定位，以确保穿刺成功。没有现场查体不给分（叩诊、听诊）	2
4.检查抽液装置（设备）的完整性，保质期，密闭性。	1
（二）胸腔穿刺操作过程（12分）	
1.常规消毒皮肤：以穿刺点为中心消毒，直径10-15厘米（顺时针、逆时针各一遍）。	1
2.戴无菌手套	1
3.铺无菌洞巾（注意不能戴手套触碰患者皮肤或者外衣）	1
4.选下一肋骨的上缘进针，用2%利多卡因局部麻醉（先皮下注射出现皮肤橘皮样皮丘改变，然后垂直进针皮下至胸膜进行逐次麻醉）	2
5.用（止血钳或者其他设备）夹闭与穿刺针相连的橡皮管（或其他连接管），末端连接好抽液用注射器。检查抽液装置的通畅性。	2
6.术者以左手指与中指固定穿刺部位的皮肤	1
7.右手将穿刺针在局麻部位垂直进针，缓缓刺入，当针锋抵抗感突然消失时，表明已穿入胸膜腔，松开夹闭设备（止血钳或者其他设备）	1
8.固定穿刺针，以防刺入过深损伤肺组织，用注射器缓慢抽取积液。	1
9.用注射器抽取适量胸腔积液留取标本后，夹闭橡皮管（或者其他连接管），拔出穿刺针，按压穿刺点。	1
10.穿刺点消毒，无菌纱布覆盖，胶布固定，标本送检	1
二、职业素质（3分）	
1.操作前能以和蔼的态度告知患者胸腔穿刺的目的，取得患者配合。	3

告知患者操作过程中不可以说话或咳嗽，如果感到头晕、心慌或胸痛，应及时举手示意操作者。操作结束后应及时告知患者有关注意事项。（1分） 2.操作时注意无菌观念，动作轻柔规范，体现爱护患者的意识。（1分） 3.着装整洁，仪表端庄，主动介绍自己，语言文明，态度和蔼举止大方，表现出良好的职业素质。（1分）	
---	--

（十七）腹腔穿刺术

临床情景：李先生，56岁，既往有手术输血史，3年前诊断肝硬化，目前因腹胀伴呼吸困难来诊，查体可见腹部膨隆，移动性浊音阳性，为缓解症状，准备腹腔穿刺放液。

要求：请为患者（医学模拟人或模具）行腹腔穿刺放液。

评分标准	20 (分)
一、操作过程（17 分）	
（一）操作前准备（2分）	
1.操作者准备： （1）术前沟通：核对患者姓名、床号；自我介绍：告知病情、穿刺目的、注意事项和可能出现的意外，消除顾虑，取得同意和配合，询问有无穿刺禁忌症，有无利多卡因过敏史，签署知情同意书。 （2）准备和检查物品是否齐全完好：腹腔穿刺包、0.5%碘伏（或碘酊和75%酒精）、无菌棉签、无菌手套、胶布，5ml和50ml注射器，2%利多卡因注射剂，软尺，腹带，污物盘、锐器盒，污物桶，手消毒液。 （3）戴帽子、口罩（头发鼻孔不外露）；六步洗手法洗手（边口述边操作），需口述每步不少于15秒。	0.5
2.术前嘱患者排尿、模拟人体位正确（1分）；让模拟人坐在靠背椅上，衰弱者可取其他适当体位如半卧位、平卧位或侧卧位。	1
3.穿刺前测量被检者腹围、脉搏、血压，放置腹带，叩诊移动性浊音。	0.5
（二）腹腔穿刺操作过程（15分）	
1.选择合适的穿刺点，用龙胆紫标记：（任选1个，位置正确可得2分） ①左下腹脐与髂前上棘连线中、外1/3交点，此处不易损伤腹壁动脉；②脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处，此处无重要器官且易愈合；③侧卧位，在脐水平线与腋前线或腋中线之延长线相交处，此处常用于诊断性穿刺。	2
2.消毒：用碘伏消毒皮肤，以穿刺点为中心同心圆向外消毒，不得重复，不得遗漏，消毒范围直径15cm，消毒3遍，范围依次较前缩小。 也可用2%碘酊棉球消毒1次，待干后用75%乙醇由内向外脱碘2次。	1
3.打开穿刺包，戴无菌手套,左手捏住手套反折处，右手对准手套5指插入带好，已带好手套的右手除拇指外，4指插入另一手套反折处，左手顺势带好手套。	1
4.铺无菌洞巾，检查穿刺包内器械，注意穿刺针是否通畅，胶管是否有漏气及破损。	1

5. 核对麻醉药品，抽取2%利多卡因5ml，自皮肤至壁层腹膜逐层局部浸润麻醉，每次注药前要先回抽。	1
6. 穿刺针橡皮管末端用止血钳夹闭，以左手示指与中指固定穿刺部位的皮肤，右手持穿刺针，经麻醉处刺入皮肤，以45-60度斜刺入腹肌，再与腹壁呈垂直角度刺入腹腔，此时针尖抵抗感消失，放开橡皮管末端的止血钳，见腹水流出，提示穿刺成功。	3
7. 助手用消毒血管钳固定针头，并夹持胶管，将橡皮管末端接引流袋或引流瓶，以输液夹子调整放液速度，抽液过程中询问患者有何不适（口述）。	2
8. 放液后，拔出穿刺针，并按住穿刺点3分钟，消毒穿刺部位，无菌纱布覆盖，胶布固定，以防止渗漏，可以加蝶形胶布固定。	2
9. 腹水记量，标本送检。	0.5
10. 大量放液者需加用腹带加压包扎。	1
11. 穿刺结束后再次测量患者血压、脉搏、腹围，观察患者病情变化（口述），为患者整理好衣服，嘱咐患者好好休息，有不适随时通知医生。	0.5
二、医学人文素养（3分）	
1. 仪表端庄，举止大方（0.25分），着装（工作服）整洁（0.25）	0.5
2. 操作时动作规范，认真细致（0.5分），有体现关爱被检查者的动作（0.5分），注意保护隐私（0.5分）	1.5
2. 主动自我介绍（0.25分），语音文明，态度和蔼（0.5分），说明检查目的及注意事项（0.25分）。	1

(十八) 腰椎穿刺术

临床情景： 李女士，24岁，发热、头痛4天，伴喷射状呕吐。考虑急性脑膜炎，拟行腰椎穿刺术明确诊断。 要求： 请为患者行腰椎穿刺术。	
评分标准	20 (分)
一、操作过程 (17 分)	
(一) 操作前准备 (5分)	
1.戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述）。	1
2.患者取侧卧位（多为左侧卧位），背部与床面垂直，头向前胸屈曲，两手抱膝紧贴腹部。	1
3.选择穿刺点并在体表定位（一般以第3~4腰椎棘突间隙为穿刺点），即髂嵴最高点连线与后正中线的交会处，也可上移或下移一个腰椎间隙）。	2
4.常规消毒皮肤：以穿刺点为中心由内及外消毒2遍，范围正确。	1
(二) 腰椎穿刺及测脑脊液压力操作过程 (12分)	
1.戴无菌手套。	1
2.铺洞巾。	1
3.用2%利多卡因在局部做皮内和皮下麻醉，然后将针头刺入椎间韧带后，回抽无血液，边退针，边注入麻醉剂。	1
4.检查穿刺针是否通畅，放入针芯。左手固定穿刺点皮肤，右手持穿刺针以垂直背部或针尖稍斜向头部方向缓慢刺入。	2
5.当感到穿刺阻力突然消失（即针头穿过韧带与硬脊膜），此时将针芯缓慢抽出，流出脑脊液	2
6.测压和放液：嘱咐患者放松，并缓慢将双下肢伸直。接测压管测量脑脊液压力。撤去测压管，用试管收集适量脑脊液送检。	2
7.收集脑脊液后将针芯插入，缓慢拔出穿刺针，按压、消毒穿刺点，覆盖无菌纱布，胶带固定。	2
8.嘱患者去枕平卧4~6小时。	1
二、医学人文素养 (3分)	
(一) 仪表端庄，举止大方，着装整洁	0.5
(二) 操作时动作规范，认真细致，有体现关爱操作对象的动作，注意保护隐私	1.5
(三) 主动自我介绍，语言文明，态度和蔼	1

(十九) 骨髓穿刺术

临床情景：男孩,16岁。反复出现贫血、出血、感染1个月。查体：全身淋巴结肿大，拟诊断为：急性淋巴细胞白血病。现在行骨髓穿刺活检进一步确诊该疾病。
要求：请为患者（医学模拟人）行骨髓穿刺术。

评分标准	20 (分)
一、操作过程 (17 分)	
(一) 操作前准备 (7分)	
1. 检查手消毒液保质期，如过期，请求更换,口述手消毒液消毒双手（六步洗手法洗手）	0.5
2. 戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露）	0.5
3. 核对信息，床号姓名，排空二便。	1
4. 有无穿刺禁忌症	1
5.了解利多卡因过敏史	0.5
6. 是否已签署知情同意书	0.5
7. 准备物品，检查包装完整无破损，在有效期内	0.5
8. 患者取仰卧位或侧卧位。	0.5
9. 选择常用的穿刺点之一，并在体表定位：髂后上棘穿刺点（患者俯卧位，取髂后上体突出的部位）、髂前上棘穿刺点（患者仰卧位，取髂前上棘后方1-2cm，骨平面较宽、平坦处）、胸骨穿刺点（胸骨中线第2肋间水平）。局部皮肤无感染。	1
10. 碘伏常规消毒皮肤：以穿刺点为中心，由内向外环形叠瓦式消毒，直径15cm以上,待干，消毒第二遍，方向相反，范围小于第一次。	1
(二) 骨髓穿刺操作过程 (10分)	
1. 戴无菌手套。	1
2. 铺无菌孔巾（取无菌孔巾，打开无菌孔巾，注意避免孔巾接触操作台或操作者衣物。双手分别抓取孔巾上角，注意保护双手，避免铺孔巾时双手接触患者皮肤。一次将孔巾铺到位，禁止接触患者皮肤后再次移动孔巾位置。注意孔巾的正反，恰当固定孔巾（可用粘膏固定），防止操作中孔巾移位污染）	1
3. 用2%利多卡因双人核对，在有效期内，澄清无浑浊，消磨消瓣。	0.5
4.局麻浸润麻醉（抽取利多卡因3-5ml，排气。在穿刺点皮下打皮丘（直径5-10mm），再沿穿刺点垂直骨面进针，边进针边回抽，无回血推药）	1
5. 将骨髓穿刺针固定器固定在适当的长度上（髂骨穿刺约1.5cm），用左手的拇指和示指固定穿刺部位。	1

6. 左手绷紧皮肤，以右手持针向骨面垂直刺入，当针尖接触骨质时，则将穿刺针围绕针体长轴左右旋转进针，缓缓钻刺骨质，直至穿刺针阻力消失，有落空感停止进针，且穿刺针已固定在骨内，提示穿刺成功。	1
7. 拔出针芯，放于无菌盘内；接上干燥的10ml或20ml注射器，用适当力量抽吸0.1~0.2ml骨髓液。	1
8. 准备玻片，标记姓名，B/M。并准备标本管，标记。	0.5
9. 将抽取的骨髓液滴于载玻片上，嘱助手蘸取少许骨髓液快速推片6-8张。并抽取3ml骨髓液留取免疫分型（微小残留）。	0.5
10. 抽吸完毕，将针芯重新插入；将穿刺针连同针芯一起拔出，局部消毒，按压穿刺点1~2分钟（0.25分），无菌纱布覆盖，用胶布固定（0.25分）。	1
11. 口述采外周血进行涂片2-3张。	0.5
12. 穿刺部位3天内不沾水，保持清洁,人文关怀。	0.5
13. 垃圾分类处理：各类包装袋放入生活垃圾桶，与患者接触的物品放入医疗垃圾桶，锐器放入锐器盒。	0.5
二、医学人文素养（3分）	
（一）仪表端庄，举止大方，着装（工作服）整洁。	0.5
（二）操作时动作规范，认真细致（0.5分），有体现关爱操作对象的动作（0.5分），注意保护隐私（0.5分）。	1.5
（三）主动自我介绍（0.5分），说明操作目的及注意事项（0.25分）。语言文明，态度和蔼（0.5分）	1

(二十) 脊柱损伤的搬运

临床情景： 吴某，男性，电梯工人。在电梯井底部检修电梯时本缓慢降落的轿厢压至背部，极度弓腰，被他人救出时后背胸腰段剧烈疼痛，双下肢失去知觉，无法自主活动。急救人员到场，需转运至医院进一步诊断及治疗。 要求： 作为急救人员，请将患者（医学模拟人）搬运并固定至担架上	
评分标准	20分
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.确认周围环境安全。	1
2.检查患者生命体征平稳。	1
3.准备搬运用具：硬质担架，固定带。（选软担架不得分）	1
（二）搬运、固定操作过程	
1.搬运过程保持脊柱伸直位（不能屈曲或扭转）。	2
2.三人（或者四人）站在患者同一侧。	2
3.搬运时所有人同时同等程度用力。	2
4.施以平托法使患者平稳移到担架上（禁止搂抱或者一人抬头、一人抬足的搬运方法，出现此种情况或类似情况以上四项均不能得分）。	3
5.固定：用固定带将患者固定在担架上（一般用4条带子，胸、上臂水平，腰、前臂水平，大腿水平，小腿水平，每一根固定方法正确得1分）。	4
（三）提问	
1.搬运合并颈椎损伤患者需注意什么？ 答：需有一人专门托扶头颈部，并向上略牵引，有条件应佩戴颈托。 2.为什么要用硬板或硬质担架搬运脊柱损伤患者？ 答：避免脊柱损伤患者在转运过程出现脊柱弯曲、扭转等非同轴情况，避免二次损伤。	2
二、职业素养	
1.搬运前及转运中能与患者良好沟通，告知患者操作目的，消除紧张情绪，取得患者配合。操作过程中规范操作，注意询问患者感受，适时安慰，告知患者注意事项。 2.着装整齐，举止大方，操作沉稳，条理清晰，认真负责。	2

(二十一) 四肢骨折现场急救外固定术

临床情景： 冯某，男性，28岁，建筑工人。在工地被坠物砸伤前臂，现场急救人员初步判断为左尺桡骨开放性骨折，伤口轻度污染，未见活动出血。 要求： 作为急救人员，请为患者（医学模拟人）行现场伤口包扎并用夹板行骨折外固定以便转运至医院。	
评分标准	20分
一、操作过程	
（一）操作前准备	
1.确认周围环境安全。	1
2.检查患者生命体征平稳。	1
3.检查伤口、患肢情况。	1
4.准备包扎固定物品。	1
（二）伤口包扎及夹板外固定操作过程	
1.充分显露伤口，除去伤口周围污物。	2
2.无菌纱布良好覆盖良伤口并包扎，松紧适度。	2
3.选用至少2块夹板，其长度要分别超过肘关节及腕关节，准备置于前臂掌侧及背侧。	2
4.皮肤与夹板间垫毛巾或棉垫，骨突处尤其要加棉垫保护。	2
5.固定：以至少三道折叠的三角巾条或者绷带捆扎，松紧适度，以上下可移动约1cm为度，三角巾将前臂悬吊至胸前，检查末梢给感觉血运。	4
（三）提问	
1.四肢骨折现场急救外固定的目的是什么？ 答：主要是对骨折临时固定，防治骨折端反常活动，刺伤血管、神经等周围组织，造成继发性损伤（0.5分），并减少疼痛，便于抢救和搬运（0.5分）。 2.考虑存在动脉损伤活动性出血时，止血带应用在何处？ 答：应捆扎在动脉损伤处的近心端，并选择避免压迫神经等重要结构的部分，一般上肢选择上肢选择上臂中上部，下肢选择大腿中部。（1分）	2
二、职业素养	
1.操作前操作中能与患者良好沟通，告知患者操作目的，消除紧张情绪，取得患者配合。操作过程中规范操作，注意询问患者感受，适时安慰，告知患者注意事项。 2.着装整齐，举止大方，操作沉稳，条理清晰，认真负责。	2

(二十二) 心肺复苏

临床情景： 王先生，71岁。晨练时突然倒地，呼之不应，口唇发绀，颈动脉搏动消失。	
要求： 请立即为患者（医学模拟人）行心肺复苏抢救（完成5个循环）。	
评分标准	20 (分)
一、操作过程（18分）	
（一）操作前准备	
1.物品准备：硬质垫板、无菌纱布、弯盘、除颤仪、导电糊（或生理盐水纱布）。	0.5
2.迅速到位，评估周围环境，使患者仰卧于平地上，疏散围观人群。	1
3.立即跪于患者身旁，拍打患者双肩，并大声呼唤“喂，怎么了”，观察患者有无反应，触摸颈动脉搏动，脸贴近患者口鼻、眼睛斜视观察胸廓判断呼吸，计数1001→1002→1003→1004→1005→1006→1007。（口述患者无颈动脉搏动，无自主呼吸）。	1
请求帮助，立即拨打120、取AED。	0.5
（二）心肺复苏操作过程	
1.解开患者衣服，暴露前胸。两手掌根部重叠置于胸骨中、下1/3交界处，手指抬起不触及胸壁。	2
2.肘关节伸直，借助身体中立垂直向下按压，按压力度使胸骨下陷至少5cm,下压与放松时间为1：1，放松时手掌不离开按压部位；按压30次，按压时观察患者面色。按压频率100～120次/分钟（17～20次/10秒）。	2
3.清除口、鼻腔分泌物异物等，检查（并取出）义齿。	1
4.开放气道（仰头举颏法）：一手掌侧置于前额，轻压使头后仰，另一手食指、中指尖置于颏骨下方，举起下颏，使患者下颏和耳垂连线与地面垂直，保持呼吸道通畅。	2
5.平静吸气后，将口唇包绕密封患者口周，置于前额的手捏紧患者鼻翼，防止吹气时气体逸出，均匀地向患者口内吹气，应持续1秒钟以上，直至患者胸廓向上抬起。	2
6.见胸廓抬起后松开捏鼻的手指，观察胸廓回落情况，再进行下一次人工呼吸，两次间隔1-3s。	2
7.每胸外按压30次进行2次人工呼吸，动作标准地完成5个循环（口述计数）。	3
8.判断复苏效果：患者颈动脉搏动是否恢复，自主呼吸是否恢复，瞳孔是否回缩，对光反射是否存在，颜面、口唇、甲床等是否转红润，意识	1

是否恢复，操作并口述。（初级心肺复苏成功，进入下一步生命支持）	
二、医学人文素养	
1.操作时动作迅速准确，不慌乱，操作结束后向患者家属告知急救结果以及下一步处理意见。	1
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	1

（二十三）简易呼吸器的应用

临床情景： 李先生，78岁，因高热、咳嗽、呼吸费力急诊入院，诊断重症肺炎。病人既往糖尿病、脑血栓10年，卧床2年。现病人突然出现憋闷、面色苍白、口唇发绀、呼吸急促症状。	
要求： 请用简易呼吸器为患者（医学模拟人）进行辅助呼吸。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	20（分）
一、操作过程（17 分）	
（一）操作前准备	
1.操作者准备：戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外漏）、洗手（需口诉每一步不少于15秒）。	0.5
2.准备并检查物品：中心供氧装置或带压力表的氧气瓶、简易呼吸器（球囊、面罩）湿化瓶、流量表、吸氧管、听诊器、（纱布、弯盘）	0.5
3.连接氧气装置，连接呼吸囊装置。	1
4.将呼吸囊连接吸氧管，氧流量8~10L/min。	1
（二）简易呼吸器操作过程	
1.患者仰卧位，去掉枕头，考生站位于患者头顶侧。	2
2.清除口、鼻腔分泌物异物等，保持呼吸道通畅。	2
3.托起患者下颌，使头后仰，保持呼吸道通畅。	2
4.扣紧面罩，一手以“EC”手法（拇指和示指按压面罩，其余三指提起下颌）固定面罩，另一手有规律地捏放呼吸囊。	3
5.每次挤压呼吸囊以1/3~1/2为宜，每次送气500~600ml,捏放呼吸囊频率为每分钟10~12次（每5~6秒1次）。若患者有自主呼吸，应与之同步，即患者吸气初顺势捏压呼吸囊，达到一定潮气量，便完全松开气囊，让患者自行完成呼气动作。	2
6.随捏放呼吸囊观察胸廓起伏情况，听诊双肺呼吸音。	2
7.操作结束后向患者家属告知抢救结果及注意事项（目前患者呼吸逐步平稳，家属不要紧张）。	1
二、医学人文素养	
1.操作过程规范，动作轻柔，体现爱护患者的意识。	2
2.着装整洁，仪表端庄，举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	1

（二十四）穿、脱隔离衣

临床情景： 您准备从医生办公室进入传染病隔离病房检查患者病情。	
要求： 请完成在半污染区穿隔离衣操作，并脱隔离衣备用。	
评分标准（全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分，扣完为止）	20（分）
一、操作过程（17 分）	
（一）穿隔离衣过程	
1.准备工作：戴帽子、口罩（头发、鼻孔不外露），洗手（口述每步不少于15秒）。	1
2.取衣：查对隔离衣（有无潮湿、破损，长短须能全部遮盖工作服），手持衣领从衣钩上取下隔离衣，清洁面朝向自己将衣服展开，露出肩袖内口。	1
3.穿袖：一手持衣领，另一手伸入衣袖内并向上抖，拉衣领使手露出；换手持衣领，依上法穿好另一袖。	2
4.系领系袖口：两手沿衣领边缘由前向后，在颈后系好领口，注意两肘外展，避免袖口触及脸颊，然后扣好袖口或系上袖带。	2
5.找衣边：从腰下约5cm侧缝处将隔离衣后身部分向前拉并触及衣边，捏住。同法将另一侧衣边捏住。	2
6.系腰带：两手在背后将两侧衣边对齐，向一侧按压折叠，以一手按住，另一手将腰带拉至背后压住折叠处，在背后交叉，回到前面打一活结，系好腰带。穿好隔离衣后，双臂保持在腰部以上。	2
（二）脱隔离衣过程	
1.解腰带：解开腰带，将腰带牵至身前，并打一活结。	1
2.解袖口：解开袖口，将衣袖上拉，在肘部将部分袖管塞入袖内，暴露前臂。	1
3.消毒双手：消毒双手，从前臂至指尖刷洗两分钟，清水冲洗，擦干（口述）。	1
4.解衣领：解开衣领（或领扣），保持衣领清洁。	1
5.脱衣袖：一手伸入另一侧袖口内清洁面，拉下衣袖过手；再用衣袖遮盖着的手在外面拉下另一衣袖；两手在袖内使袖子对齐，双臂逐渐退出。	1
6.处理：若隔离衣还可使用，双手持衣领，将隔离衣清洁面向外两边对齐（半污染区清洁面向外，污染区则污染面向外），挂在钩上。	2
二、医学人文素养	
1.在穿脱隔离衣过程中，动作规范，预防意识强。	1
2.着装整洁，仪表端庄。	1
3.举止大方，语言文明，认真细致，表现出良好的职业素质。	1

五、辅助检查

六、病例分析

(一) 呼吸系统

1. 慢性阻塞性肺疾病

病历摘要

男患，75岁，主诉：慢性咳嗽，咳痰20余年，活动后气短5年，加重伴发热1周。

患者20余年前受凉后出现咳嗽，咳痰，以后每于受凉后均有发作，多于冬春季节出现，5年来发作时伴气短，尤以活动后明显，休息后可缓解。1周前受凉后上述症状再次发作，咳嗽，黄白痰，不易咳出，伴发热，体温最高38.5℃，活动后气喘，自服药物后无缓解而入院。

既往有长年吸烟史，无药物过敏史。

查体：T36.6℃，P102次/分，R22次/分，BP130/75mmHg，端坐位，喘息貌，口唇发绀，颈静脉无怒张，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干鸣音，双下肺少许湿啰音。肝，脾肋下未触及，双下肢无浮肿。

辅助检查：血常规WBC 12.2X10⁹/L，N85%；血气分析：pH 7.28 PaCO₂ 71mmHg，PaO₂ 56mmHg。胸片：双肺纹理增粗。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
慢性阻塞性肺疾病急性加重期		2
Ⅱ型呼吸衰竭		2
二、主要诊断依据	5	
1.慢性阻塞性肺疾病急性加重期		
（1）老年男性，慢性病程，长期大量吸烟史		1
（2）反复咳嗽咳痰多年，活动后气短，发作呈季节性，本次加重伴发热		1
（3）体征：端坐位，喘息貌，桶状胸，双肺叩诊过清音，散在干鸣音		0.5
（4）胸片：双肺纹理增粗		0.5
2.Ⅱ型呼吸衰竭		
（1）血气分析符合Ⅱ型呼吸衰竭。		1
（2）患者慢性阻塞性肺疾病病史，本次急性加重，口唇发绀		1
三、鉴别诊断	4	
1.支气管哮喘		1

2.支气管扩张		1
3.肺癌		1
4.肺结核		1
四、进一步检查	4	
1.血电解质，肝肾功能		1
2.痰培养+药敏试验		1
3.心电图，超声心动图检查		1
4.肺功能检查（病情平稳后）		1
五、治疗原则	5	
1.持续低流量吸氧，止咳、祛痰		1
2.支气管扩张剂，糖皮质激素平喘治疗		1
3.使用抗菌素：根据痰培养结果合理选用抗菌素		1
4.必要时机械通气		1
5.戒烟，健康教育		1

2.支气管哮喘

病历摘要

女性，31岁。反复喘息伴咳嗽2年，再发3天。

患者2年来反复发作喘息，多与气候变化、接触油烟等刺激性气味有关。伴咳嗽，咳少许白痰。无胸闷、胸痛、心悸，无发热、盗汗，在脱离刺激性气味后症状可自行缓解。喘息持续发作时，曾在当地诊所按“上呼吸道感染”治疗，症状可逐渐缓解。缓解期间无不适症状。3天前患者逛宠物市场后喘息再次发作，轻微活动后即感胸闷、气促，夜间症状严重，需高枕卧位。发病以来，精神、食欲、睡眠差，大小便正常。否认过敏史。无烟酒嗜好。月经正常。否认遗传病家族史。

查体：T36.5℃，P95次/分，R26次/分，BP120/76mmHg。坐位喘息状，表情焦虑，精神差。口唇略发绀。皮肤湿润，全身浅表淋巴结未触及肿大。胸廓外形正常，双肺触觉震颤减弱，双肺叩诊过清音，可闻及中量呼气相哮鸣音，未闻及湿性啰音和胸膜摩擦音。心界不大，心率95次/分，心律整齐，未闻及心脏杂音。双下肢无水肿。

实验室检查：动脉血气分析pH7.43, PaO₂ 55mmHg, PaCO₂ 37mmHg, HCO₃⁻ 23.5mmol/L, SaO₂ 87%.

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
支气管哮喘急性发作期		2
I型呼吸衰竭		2
二、主要诊断依据	4	
1.支气管哮喘急性发作期		
（1）青年女性，反复发作哮喘伴咳嗽，3天来再发伴胸闷、气促。		1
（2）症状发作与气候变化、接触刺激性气味等有关，可自行缓解。缓解期无不适症状。		1
（3）查体：坐位喘息状，双肺触觉震颤减弱，叩诊过清音，呼吸相可闻及中量哮鸣音。		0.5
2.I型呼吸衰竭		
（1）血气分析符合I型呼吸衰竭。		1
（2）患者支气管哮喘急性发作，本次急性加重，口唇略发绀		0.5
三、鉴别诊断	4	
1.急性左心衰竭。		2

2.慢性阻塞性肺疾病。		1
3.气道阻塞		1
四、进一步检查	5	
1.血常规（嗜酸性粒细胞计数+百分比）。		1
2.胸部X线片。		1
3.心电图。		1
4.肺功能检查（支气管舒张试验）。		1
5.皮肤变应原检测（病情控制后）。		1
五、治疗原则	5	
1.休息、吸氧，脱离变应原。		1
2.联合使用支气管扩张剂，静脉或口服糖皮质激素缓解症状。		1
3.吸入糖皮质激素+支气管扩张剂预防发作		1
4.必要时机械通气治疗		1
5.哮喘的健康教育与管理。		1

3.支气管扩张

病历摘要

患者男性，52岁，反复咳嗽咳痰40余年，伴间断痰中带血10余年，加重1周。

患者40余年前曾患“支气管肺炎”，具体治疗不详。其后即反复出现咳嗽咳痰，多为黄粘痰，受凉感冒后咳嗽咳痰症状加重，痰量明显增多，予静脉抗炎治疗可好转。40余年来上述症状反复发作，并于近10余年患者间断出现痰中带血，口服止血药物可好转。1周前患者受凉后出现咳嗽咳痰明显加重，痰量增多，黄绿色脓痰，伴痰中带血，为鲜血，与痰液混合，每日约4-5口，伴发热，体温最高39℃，伴轻度活动后气短，无明显喘息，无胸痛，为进一步治疗入院。

既往：6岁时患“支气管肺炎”，当时医治条件欠佳。否认其他慢性病史。吸烟史20余年，6支/日。

查体：T 37℃，BP 120/80mmHg，P 90次/分，R 18次/分。神清，精神可，发育正常，口唇无明显紫绀，胸廓无畸形，双肺呼吸音对称，双肺呼吸音粗，左下肺可闻及湿啰音，未闻及干鸣音。心界不大，心率齐，无杂音。腹软，肝脾未及，双下肢不肿。

辅助检查：血常规：WBC $13 \times 10^9/L$ N 83%，胸片：左下肺纹理粗重，紊乱，局部呈卷发状阴影。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	2	
支气管扩张合并感染		2
二、主要诊断依据	4	
1.中年男性，慢性病程，反复咳嗽咳痰，伴痰中带血。幼时曾患“支气管肺炎”。		1
2.查体：左下肺可闻及湿啰音		1
3.血常规：WBC $13 \times 10^9/L$ N 83%		1
4.胸片：左下肺纹理粗重，紊乱，局部呈卷发状阴影。		1
三、鉴别诊断	5	
1.慢性阻塞性肺疾病		1
2.肺脓肿		1
3.肺结核		1
4.肺癌		1

5.弥漫性泛细支气管炎		1
四、进一步检查	6	
1. 胸部CT，尤其是HRCT		1
2. 痰病原学检查：痰涂片，痰培养，有助于抗生素的选择		1
3.肝肾功能，肿瘤标志物		1
4.动脉血气分析		1
5.肺功能检查（疾病控制后）。		1
6.必要时气管镜检查。		1
五、治疗原则	5	
1.休息、吸氧，营养支持		1
2.应用广谱抗生素抗炎治疗。		1
3.应用支气管扩张药物，祛痰药物，		1
4.体位引流		1
5.病情缓解后行肺炎球菌疫苗、流感疫苗接种		1

4.肺炎

病历摘要

男患，56岁，发热咳嗽2天

患者3天前淋雨受凉，两天前晨起突发高热，T39.1℃-39.7℃，伴寒战，咳嗽，干咳为主，少量白粘痰，不易咯出，右胸痛，咳嗽或深吸气时加剧，自服泰诺林1片后，大汗淋漓，体温下降至36.7℃，4小时后，体温复升至39.7℃，伴全身肌肉酸痛。速来急诊，经对症输液处理后收入院。

即往体健，吸烟史多年，无药物过敏史

查体：T39.5℃，P 100次/分，R 25次/分，BP100/50mmHg，神清，精神弱，呼吸急促，口唇无紫绀，皮肤无黄染及皮疹，颜面苍白，气管居中，右肺呼吸运动减弱，右中上叩诊浊音。心界不大，律齐，右中上可闻及管状呼吸音，偶闻细小水泡音，左肺呼吸音清晰。腹部胀气，无明显压痛，反跳痛。无肌紧张。肝脾肋下未触及，双下肢无浮肿。

辅助检查：血常规WBC $19.2 \times 10^9/L$ ，N93%，L7%，Hb140g/L，PLT $206 \times 10^9/L$ 。K 3.2mmol/L，Na130mmol/L，CL 96mmol/L，BUN 8.1mmol/L，血糖6.1mmol/L。ECG：窦性心动过速。胸片：右上肺大片状阴影。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
大叶性肺炎		2
电解质紊乱，低钠血症，低钾血症		2
二、主要诊断依据	6	
1.大叶性肺炎		
（1）中年男性，急性起病，发热伴寒战，咳嗽		1
（2）查体：右中上可闻及管状呼吸音，偶闻细小水泡音，右肺中上叩诊浊音。		1
（3）血常规：白细胞及中性粒细胞升高。		1
（4）胸片：右上肺大片状阴影		1
2. 电解质紊乱，低钠，低钾血症		
血化验：K 3.2mmol/L，Na130mmol/L		2
三、鉴别诊断	3	
1.干酪性肺炎（肺结核）		1

2.肺脓肿		1
3.肺癌		1
四、进一步检查	4	
1. 病原学检查：痰涂片，痰培养，血培养，有助于抗生素的选择		1
2. 动脉血气分析		1
3. 必要时行胸部CT，气管镜检查		2
五、治疗原则	5	
1.休息、退热，止咳，营养支持。		1
2. 选用广谱抗菌素控制感染。		1
3. 纠正水电平衡紊乱，补钾、补钠		1
4.防治并发症		1
5.必要时呼吸机辅助通气		1

5.肺结核

病历摘要

女性，18岁，学生。低热，咳嗽咳痰1个月，咯血2天。

患者一个月前无明显诱因出现午后低热，伴咳嗽，咳少量白痰。就诊于当地医院胸片示右肺上叶斑点状浸润影，空洞形成。用青霉素抗炎治疗一周，复查胸片右肺病灶无明显吸收。2天前咯血一次，为鲜血，量约10ml左右，为进一步诊治而就诊。发病以来，精神尚可，饮食睡眠可，大小便正常，患者有乏力，无盗汗症状，体重无明显变化。

查体：T36.6℃，P86次/分，R22次/分，BP120/70mmHg。体形消瘦，皮肤巩膜无黄染。浅表淋巴结未触及肿大。双肺呼吸音稍粗，未闻及干湿性啰音及胸膜摩擦音。心率86次/分，心律整齐。腹软，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

实验室检查：血常规 WBC7.5X10⁹/L, N 70%，Hb126g/L。ESR75mm/h。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
右上肺浸润性肺结核		3
二、主要诊断依据	4	
1. 青年女性，体型消瘦，亚急性起病。		1
2. 低热，咳嗽、咳痰1月，咯血2天，抗生素治疗无效		1
3. 血常规正常，ESR显著增快。		1
4. 胸片示右肺上叶斑点状浸润影，空洞形成		1
三、鉴别诊断	4	
1. 肺炎		1
2. 肺脓肿		1
3. 肺癌		1
4. 血管炎		1
四、进一步检查	5	
1. 痰病原学检查（涂片抗酸染色，细菌培养+药敏试验）		1
2. PPD试验、结核抗体，T-spot检查		2
3. 胸部CT，必要时气管镜检查		2
五、治疗原则	6	
1. 休息、加强营养。		1
2. 按“早期、联合、规律、全程、适量”的原则行抗结核治疗。（仅答		4

“抗结核治疗”得2分)		
3. 治疗咯血		1

6.肺栓塞

病历摘要

男性，55岁。突发呼吸困难伴咳嗽1天。

患者今日下班回家途中突感胸痛伴呼吸困难，休息或改变体位症状无缓解。无畏寒发热，无咳嗽咳痰，无胸痛、咯血等。

既往史：既往体健，无结核、肝炎等传染病病史，无高血压、糖尿病病史，无家族遗传病史，无吸烟、酗酒史。

查体：T 36.6℃，R 32次/分，BP 110/65mmHg，心率 110次/分，指脉氧饱和度 91%（未吸氧）。口唇发绀，颈静脉充盈，双肺未闻及干湿性啰音。心率 110次/分，P₂亢进，P₂>A₂。心律齐。右下肢腓骨下缘 10 厘米处较左下肢周径长 1.5 厘米。

实验室检查：血常规：WBC 8.0×10⁹/L，N 0.71，PLT 100×10⁹/L。尿常规、便常规正常，肝、肾功能正常，白蛋白、血脂、心肌酶、电解质、血糖均正常。肌钙蛋白正常。动脉血气：pH 7.38，PaCO₂ 36mmHg，PaO₂ 52mmHg，HCO₃⁻ 22mmol/L。心电图示窦性心动过速。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 份	
一、初步诊断	4	
1. 急性肺动脉栓塞（仅答“肺动脉栓塞”得 1 分）		2
2. I 型呼吸衰竭（仅答“呼吸衰竭”得 1 分）		2
二、诊断依据	5	
1. 急性肺动脉栓塞		
（1）中老年患者，急性发病史		1
（2）突发胸痛伴呼吸困难，P ₂ 亢进，P ₂ >A ₂		2
2. I 型呼吸衰竭：PaO ₂ 52mmHg<60 mmHg。无二氧化碳分压升高。		1
3. 右下肢较左下肢增粗，周径差大于 1 厘米		1
三、鉴别诊断	4	
1. 冠心病		2
2. 气胸		1
3. 主动脉夹层		1
四、进一步检查	4	
1. 肺部影像学检查 CTPA 或者肺动脉造影。		1
2. D-二聚体及凝血功能检查。		1
3. 下肢深静脉超声		1

4. 心脏超声		1
五、治疗原则	5	
1. 绝对卧床，监测生命体征。		1
2. 氧疗		1
3. 抗抗凝治疗		1
4. 必要时溶栓治疗（必要时手术取栓）		1
5. 如果有下肢静脉血栓，进行相应治疗		1

7.肺癌

病历摘要

男性，62岁。反复咳嗽、咳嗽半年，发热伴痰中带血10天。

患者半年前受凉后出现阵发性咳嗽、咳痰，初为白色黏痰，后逐渐变为黄脓色痰，每日咳嗽约10余次。无畏寒、发热，无胸痛、心悸、呼吸困难，无双下肢水肿。自行口服“消炎药”后病情缓解。此后“感冒”较为频繁，咳嗽、咳痰反复发作，口服“头孢”有一定程度缓解。10天前无明显诱因再次咳嗽、咳黄痰，同时出现痰中带血，并伴有发热，体温波动在38℃左右，为进一步诊治收入院。自发病以来饮食睡眠可，二便正常，1个月来体重减轻约2kg。

既往史：既往体健，否认高血压、糖尿病、心脏病病史。吸烟史20余年，20支/日。

查体：T37.8℃，P82次/分，R20次/分，BP136/84mmHg。步入病房，神志清楚，查体合作。体型偏瘦，皮肤粘膜无黄染，口唇无发绀。浅表淋巴结未触及，胸廓外形正常，右下肺听诊呼吸音减低，余肺叩诊呈清音，呼吸音清晰，未闻及干湿啰音及胸膜摩擦感。心界不大，心率82次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，腹平软，肝脾肋下未触及，无杵状指，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb123g/L，RBC4×10¹²/L，WBC10.5×10⁹/L，N86%，PLT280×10⁹/L；胸部CT：右肺门下方团块影，直径约3.5cm，周边可见毛刺，右侧膈肌略抬高。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
1. 支气管肺癌（右侧）（仅答“肺癌”得2分）		4
二、诊断依据	5	
1. 支气管肺癌（右侧）		
（1）长期大量吸烟史		1
（2）反复肺部感染，咳嗽咳痰伴咯血		2
（3）胸部CT及体格检查		2
三、鉴别诊断	4	
1. 肺结核		2
2. 肺脓肿		1
3. 肺部良性肿瘤		1
四、进一步检查	5	

1. 肺部增强 CT		2
2. 支气管镜检查		1
3. 血清肿瘤标志物		1
4. 痰液脱落细胞学检测，痰病原学检查		1
五、治疗原则	4	
1. 休息，止咳，祛痰		1
2. 治疗肺部感染。		1
3. 待明确诊断后，确定下一步是否行手术或化疗。		2

8.呼吸衰竭

病历摘要

男性，65岁。反复咳嗽咳痰15年，加重伴意识障碍2天。

患者于15年前开始每年入冬即出现咳嗽、咳黄痰，偶伴发热、喘憋，在当地诊所使用头孢类抗生素和氨茶碱治疗，有一定效果，至第二年春暖时方可完全缓解。2天前患者受凉后咳嗽加重，伴发热，38℃，咳黄黏痰，同时喘憋加重。自服头孢氨苄不缓解，并逐渐出现意识障碍，嗜睡；今日家属发现呼之不醒遂打“120”送来急诊。发病以来，常出现双下肢水肿，间断服用利尿剂治疗。

既往史：高血压史8年，最高170/90mmHg，未规律服药。吸烟史50余年，30支/日。

查体：T38.1℃，P85次/分，R25次/分，BP150/80mmHg。神志不清，查体欠合作。对声音有反应，无法对话。口唇发绀，球结膜水肿，颈静脉充盈。桶状胸，肋间隙增宽，双肺可及散在干鸣音，双肺散在湿啰音。心界不大，心率85次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音；腹平坦，肝脾未及，肝颈回流征阳性；双下肢胫前凹陷性水肿，病理征未引出。

实验室检查：血常规：WBC $11.2 \times 10^9/L$ ，N78%，Hb 160g/L，PLT $138 \times 10^9/L$ ；尿常规（—）、便常规（—）；动脉血气分析：pH 7.28，PCO₂ 84mmHg，PO₂ 48mmHg。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
1. 慢性阻塞性肺疾病急性发作（或者慢性支气管炎急性发作）		1
2. 慢性肺源性心脏病		1
3. II型呼吸衰竭（仅答“呼吸衰竭”得0.5分）		1
4. 肺性脑病		0.5
5. 高血压2级（仅答“高血压”不得分）		0.5
二、诊断依据	5	
1.病史：季节性咳嗽、咳痰15年，吸烟史，考虑COPD（或者慢性支气管炎）诊断；反复出现双下肢水肿，以及肝颈回流征阳性应考虑肺源性心脏病；加重伴意识障碍考虑肺性脑病；高血压病史明确。		2
2.查体：口唇发绀，肺部干鸣音和湿啰音；颈静脉充盈，双下肢水肿。		2
3.实验室检查感染血象，血气分析提示型呼吸衰竭。		1
三、鉴别诊断	5	

1. 支气管哮喘		1
2. 支气管扩张		1
3. 肺结核		1
4. 肺癌		1
5. 左心功能不全相关疾病		1
四、进一步检查	4	
1.肺部影像学检查胸片或者胸部CT。		1
2.病原学检查尽量在开始抗生素治疗之前吸取痰液行细菌涂片、培养。		1
3.中枢神经系统评价可行头颅CT除外脑血管事件。		0.5
4.COPD严重度评价待患者病情稳定后,应考虑行肺功能评价患者严重度,指导针对原发病的治疗。		1
5.心脏超声检查,心衰指标检查(脑钠肽等)		0.5
五、治疗原则	4	
1.呼吸支持:已具备机械通气指征,给予气管插管呼吸机辅助呼吸,充分氧疗。		1
2.积极治疗肺部感染。		1
3.支气管解痉治疗(改善通气)。		1
4.纠正水、电解质平衡及营养支持治疗。		0.5
5.注意心功能监测,控制血压。		0.5

9.胸腔积液

(1) 恶性胸腔积液

病历摘要

女性，65岁。发现肺部阴影2年，胸闷2周。

患者2年前体检摄胸片发现左下肺直径约1.5cm的结节影，边缘毛糙。未按照医嘱行胸部CT检查及定期复查。2周前自觉左侧胸闷，无发热、咳嗽，咯血、胸痛。于当地医院行胸片检查示左侧中等量胸腔积液，胸腔穿刺抽出约600ml血性液体。发病以来，大小便正常，体重无下降。

既往史：无烟酒嗜好。子女身体健康，无遗传病家族史。

查体：T36.7℃，P85次/分，R21次/分，BP120/70mmHg。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。巩膜无黄染，口唇无发绀。左侧肩胛线第6肋间以下叩诊呈实音，呼吸音明显减弱，未闻及干湿性啰音。心界不大，心率85次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(-)。双手可见杵状指，双下肢无水肿。

实验室检查：胸水常规：比重1.026，细胞总数 $12000 \times 10^6/L$ ，有核细胞数 $1700 \times 10^6/L$ ，多核细胞0.24，单个核细胞0.76。胸水总蛋白35g/L，LDH 351U/L、ADA 14U/L。胸水CEA/血清CEA大于1

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
1. 左肺肺癌		2
2. 左侧恶性胸腔积液		2
二、诊断依据	5	
1. 老年女性，慢性病程。		0.5
2. 发现左下肺结节2年。胸闷2周，无发热。		1
3. 左侧胸腔积液体征（左侧肩胛线第6肋间以下叩诊呈实音，呼吸音明显减弱），杵状指。		1
4. 胸部X线片示左侧胸腔积液。		1
5. 血性胸水，胸水CEA/血清CEA大于1		1.5
三、鉴别诊断	4	
1. 结核性胸膜炎		2
2. 胸膜间皮瘤		1
3. 其他原因所致胸腔积液		1

四、进一步检查	5	
1. 胸部增强 CT。（答肺 CT，给 1 分）		2
2. 胸水脱落细胞学检查。		1
3. 必要时肺部结节穿刺、支气管镜检查。		1
4. 必要时胸膜活检		1
五、治疗原则	4	
1. 休息、支持治疗		1
2. 胸腔穿刺放胸水治疗。		1
3. 依据病理结果化疗。		1.5
4. 必要时胸膜固定术		0.5

（2）结核性胸腔积液

病历摘要

男性，30 岁，低热伴右侧胸痛一周，加重并活动后气促 5 天。

患者一周前无明显诱因出现干咳，伴右侧胸痛，深呼吸时明显，右侧卧位时加重，午后低热，体温 37.5℃，夜间盗汗，无咳痰、咯血，经“头孢”抗感染治疗无明显效果。5 天前出现胸痛减轻，但胸闷加重伴气短，活动后加重，休息后可缓解，无喘息。自发病以来饮食睡眠可，二便正常，自觉体重有所减轻（具体不详）。

既往史：既往体健，否认传染病接触史，否认外伤手术史，吸烟 10 年，无家族遗传病史。

查体：T37.4℃，P 84 次/分，R 20 次/分，Bp 120/80mmHg，一般情况可，无皮疹，全身浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染，口唇无发绀。颈软，气管稍左偏，颈静脉无怒张，右侧胸廓稍膨隆，右下肺语颤减弱，右下肺叩诊浊音，呼吸音消失，心右界叩不清，心率 84 次/分，律齐，无杂音，腹平软，无压痛、反跳痛及肌紧张，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb 128g/L，RBC $4.68 \times 10^{12}/L$ ，WBC $7 \times 10^9/L$ ，N68%，L 28%。PCT $3.48 \times 10^9/L$ 。ESR 75mm/h。肝肾功能未见异常。

胸部 X 线：右侧中等量胸腔积液。

胸水常规：外观黄色微浑浊，Rivalta 实验（+），细胞总数 $9.1 \times 10^{12}/L$ ，有核细胞数 $1200 \times 10^9/L$ ，单个核细胞占 86%，胸水 ADA 50U/L。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或两个以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分
------	---------

一、初步诊断	2	
右侧结核性渗出性胸膜炎（仅答“结核性胸膜炎”或“胸腔积液”得1分）		2
二、诊断依据	5	
1.青年，低热、盗汗，由开始胸痛明显（干性胸膜炎）到有积液后的胸痛减轻，抗感染治疗无效		2
2.查体及胸部X线提示右侧胸腔积液。		1
3.胸水检查提示渗出液，以单个核细胞为主，ADA<45 U/L。		2
三、鉴别诊断	4	
1.肿瘤性胸腔积液		1
2.心力衰竭致胸腔积液		1
3.低蛋白血症致胸腔积液		1
4.其他疾病（如SLE）致胸腔积液		1
四、进一步检查	5	
1.PPD实验和结核菌感染T细胞斑点试验		1
2.胸水细菌学检验，包括胸水涂片革兰染色，抗酸染色，胸水培养		1
3.胸水脱落细胞学检查		1
4.胸水及血清肿瘤标志物检测		1
5.必要时支气管镜检查		1
五、治疗原则	6	
1.休息，加强支持治疗		1
2.积极胸腔穿刺术放胸水治疗		2
3.按“早期、联合、规律、全程、适量”的原则进行治疗（仅答“抗结核治疗”得1分，五原则少答或答错一项扣0.5分）		2
4.定期复查血常规、肝肾功及胸片或肺CT		1

10.血胸和气胸

(1) 气胸

病历摘要

男性，72岁。胸部外伤后疼痛、气促、心悸2小时。

患者2小时前乘坐公交车起身下车时，因车辆急刹车致右前胸剧烈撞在座位硬质靠背上，随即出现胸痛、气促、心悸，急诊抬送入院。

既往体健，无肝炎、结核等传染病病史。无手术、外伤史及药物过敏史。

查体：T 36.7℃，P 130次/分，R 28次/分，BP 68/42mmHg。神志清楚，烦躁，大汗，极度呼吸困难，无三凹征。睑结膜苍白，颈静脉怒张、右侧胸廓饱满，呼吸运动较左侧明显减弱，无反常呼吸，右胸壁腋前线第5、6肋有骨擦音，局部压痛明显，可见大片瘀斑；胸部及上腹部可触及握雪感，右侧上胸部叩诊鼓音，下胸部叩诊实音，与肝脏叩诊区域分界不清。听诊右肺呼吸音消失，左肺呼吸音粗。未闻及干湿性啰音，心界不大，心率130次/分，律齐，未闻及杂音。腹平软，无压痛、反跳痛，肝脾下未触及，肠鸣音正常，双下肢无水肿，四肢活动正常，Babinski征阴性。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.右侧多根（或5、6肋）肋骨骨折（仅答“肋骨骨折”得0.5分）		1
2.右侧张力性气胸。		1
3.右侧血胸（答“右侧胸腔积液”亦得0.5分）		1
4.休克（失血性/创伤性/张力性气胸所致）（仅答“休克”亦得0.5分）		1
二、主要诊断依据	5	
1.右侧多根肋骨骨折 (1) 右侧胸壁多根肋骨骨擦音。 (2) 局部压痛明显。		1
2.右侧张力性气胸 (1) 严重呼吸困难，大汗。 (2) 右侧张力性气胸体征（右侧胸廓饱满，呼吸运动较左侧明显减弱，广泛皮下气肿，右侧上胸部叩诊鼓音，右肺呼吸音消失）。 (3) 颈静脉怒张。		1.5
3.右侧血胸 (1) 有胸部外伤史。 (2) 查体右侧胸腔积液体征（右侧下胸部叩诊实音，右肺呼吸音消失）。		1

4.休克 (1) 有外伤史，烦躁，大汗。 (2) 血压下降低于BP 90/60mmHg，心率增快，睑结膜苍白。		1.5
三、鉴别诊断	4	
1.心脏压塞		1
2.闭合性气胸		1
3.多根多处肋骨骨折伴反常呼吸（连枷胸）		1
4.支气管断裂		1
四、进一步检查	4	
1.诊断性胸腔穿刺。		1
2.病情允许时，行床旁胸片或胸部超声或胸部CT检查。（答出其中任一种均得1分）。		1
3.超声心动图。		1
4.血常规、血生化。		1
五、治疗原则	5	
1.抗休克治疗。		1
2.立即行胸腔穿刺减压或/和胸腔闭式引流（未答“立即”两字得0.5分）		1
3.固定胸廓、镇痛。		1
4.保持呼吸道通畅，鼓励咳嗽排痰，防治并发症。		1
5.使用抗生素防治感染		0.5
6.必要时开胸探查。		0.5

(2) 血胸

病历摘要

男性，72岁。间断咳嗽、咳嗽10年，活动后气短2年，呼吸困难加重1天。

患者10年前始多于春季出现咳嗽、咳痰，痰多为白色黏痰，有时可出现发热、咳黄脓痰。一般经门诊口服“头孢菌素”及止咳化痰中成药后症状可逐步好转。每年持续1月余。3年前开始逐渐出现活动后气短。1个月前，胸部X线片示“双下肺纹理增粗紊乱”，肺功能检查示“中度阻塞性通气功能障碍，FEV1改善率6%（120ml）”。口服“茶碱缓释片”症状可改善。1天前无明显诱因出现呼吸困难加重，伴左侧胸部不适，无咳嗽、咳痰、咯血，无发热。

既往体健，否认高血压、心脏病病史。吸烟30余年，20支/日。子女身体健康，无遗传病家族史。

查体：T36.3℃，P100次/分，R23次/分，BP135/85mmHg。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。口唇发绀，颈静脉无怒张。左肺叩诊呈鼓音，右肺叩诊呈清音，左肺呼吸音低，双肺未闻及干湿性啰音及胸膜摩擦音。心率100次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb135g/L，WBC8.5×10⁹/L，N0.72，PLT205×10⁹/L。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.左侧自发性气胸（仅答“自发性气胸”得1.5分）		2
2.慢性阻塞性肺疾病。		2
二、主要诊断依据	6	
1.左侧自发性气胸 ①突发呼吸困难加重，伴左胸不适。（1分） ②口唇略发绀，左肺叩诊呈鼓音、呼吸音低。（1分）		2
2.慢性阻塞性肺疾病 ①老年男性，长期大量吸烟史。（1分） ②慢性咳嗽、咳痰，冬春季明显，活动后气短。（1分） ③肺功能示阻塞性通气功能障碍，支气管舒张试验阴性。（1.5分） ④1个月前胸部X线片示双下肺纹理增粗紊乱。（0.5分）		4
三、鉴别诊断	4	
1.支气管哮喘。		1

2.支气管扩张。		1
3.肺栓塞。		1
4.肺大疱。		1
四、进一步检查	3	
1.胸部高分辨CT检查（答“胸部X线片”得0.5分）。		1
2.动脉血气分析检查。。		1
3.心电图，超声心动图检查。		1
五、治疗原则	5	
1.休息、鼻导管吸氧。		2
2.胸腔穿刺抽气，必要时闭式引流。		1
3.应用支气管舒张剂。		1
4.戒烟，健康教育。		1

11.脓胸

病历摘要

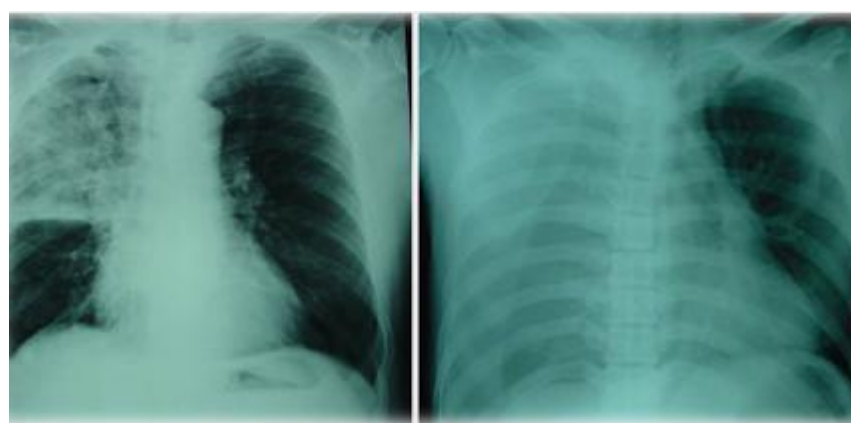
男性，38岁。发热、咳嗽伴右胸痛2周，呼吸急促1周。

患者4周前因“感冒”对症治疗，2周前感全身不适，发热 $T38^{\circ}\text{C}$ - 39°C ，食欲减退，咳嗽、咳痰为黄色浓痰，右胸疼痛。1周前感胸闷，呼吸急促，胸痛有所减轻。既往体健，否认心脏病、高血压、糖尿病病史，发病以来，大小便正常，体重无下降。无烟酒嗜好。子女身体健康，无遗传病家族史。

查体： $T39.4^{\circ}\text{C}$ ，R29次/分，P96次/分，BP120/70mmHg，皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜无黄染，口唇无发绀，右侧肩胛线第8肋间以下叩诊呈实音，呼吸音明显消失，未闻及干湿性啰音，心界不大，心率96次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音，腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），双手未见杵状指，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb110g/L，RBC $4.3 \times 10^{12}/\text{L}$ ，WBC $25.8 \times 10^9/\text{L}$ ，N0.91，PLT $269 \times 10^9/\text{L}$ 。

胸部X线片如图。超声检查：右侧胸腔大量积液，部分回声不均，有絮状物沉积。



两周前

现在

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.右上肺肺炎（仅答“肺炎”得1分）。		2
2.右侧急性脓胸。		2
二、主要诊断依据	6	
1.右上肺肺炎		3
①青年男性，急性起病，咳嗽、咳脓痰，伴发热。（1分）		

②白细胞总数和中性粒细胞比例明显增高。（1分） ③2周前胸片右肺上叶大片状阴影。（1分）		
2.急性脓胸（右侧） ①右侧肺炎，伴胸痛（胸膜性胸痛）。（1分） ②查体：胸腔积液体征（叩诊呈浊音，呼吸音减弱）。（1分） ③影像学：1周前胸片右侧胸腔均匀密度增高影，肋膈角消失，超声检查：右侧胸腔大量积液，部分回声不均，有絮状物沉积。（1分）		3
三、鉴别诊断	3	
1.肺结核。		1
2.肺脓肿。		1
3.其他类型胸腔积液。		1
四、进一步检查	5	
1.病原学检查（痰培养+药敏试验，痰涂片抗酸染色，血培养）。		1
2.动脉血气分析。		1
3.行胸穿常规及生化检查，病原学检查。PPD试验。		1
4.肝、肾功能，血电解质，血糖。		1
5.必要时胸部CT。		1
五、治疗原则	4	
1.休息、退热、止咳、营养支持。		1
2.静脉点滴广谱抗生素，并根据药敏实验调整。		1
3.胸腔穿刺排脓（必要时闭式引流）。		1
4.防治并发症。		1

12.肋骨骨折

病历摘要

男性，42岁。跌倒后右胸疼痛3小时，心慌、乏力、呼吸费力1小时。

3小时前患者洗澡时滑倒，左侧季肋部撞在浴缸边缘，撞伤时感觉局部有“咔嚓”声，剧烈疼痛严重影响呼吸。体息1小时疼痛不缓解逐渐出现心慌、乏力、头晕眼花、呼吸费力，由他人搀扶步入急诊就诊。患者受伤后无意识不清，伤后未进食，未排大小便。身体其他部位没有受既往体健，无高血压、糖尿病、心脏病病史及呼吸系统疾病史，无出凝血障碍。无烟酒嗜好。无遗传病家族史。

查体：T37.1℃，P110次/分，R25次/分，BP110/70mmHg。左侧弯腰前屈被动体位。气管居中左侧季肋部皮肤轻度挫伤，局部可见前线至腋后线第7~8肋骨区域面积3cm3cm皮下淤血。胸廓挤压试验阳性，可闻及骨摩擦音，无皮下气肿，左下胸叩诊呈实音，听诊呼吸音减弱，有湿罗音。其他各区叩诊呈清音，听诊呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音。心界不大，心率110次/分，律齐，心脏各瓣听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝肋下未触及，移动性浊音（-），双下肢无水肿。实验室检查：血常规：Hb120g/L，RBC4.0*10¹²/L，WBC11.6*10⁹/L，分类正常，PLT287X10⁹/L，肝肾功能正常，出凝血功能正常。

胸部正侧位X线片：左侧侧第8肋骨骨折伴错位，左下肺外高内低致密影，左肺多发磨玻璃斑片影。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.左侧肋骨骨折		1
2.左侧血胸		1
3.左肺挫伤		1
4.左侧壁软组织挫伤		1
二、主要诊断依据	5.5	
1.左侧肋骨骨折。 （1）明确左胸外伤史。 （2）局部有骨摩擦音。 （3）胸部X线片明确有肋骨骨折。		1.5
2.左侧血胸。 （1）左胸外伤后出现进行性心慌、乏力、头晕、心率增快等低血容量症状。		1.5

(2) 左下肺叩诊呈实音，呼吸音减低（胸腔积液体征） (3) 胸部X线片提示左侧胸腔积液。		
3.肺挫伤 (1) 胸外伤史，呼吸费力。 (2) 左下胸听诊呼吸音减弱，有湿罗音。 (3) 胸部正侧位X线片提示左肺多发磨玻璃斑片影。		1.5
4.左胸壁软组织挫伤 (1) 胸外伤史。 (2) 局部皮肤挫，皮下淤血。		1
三、鉴别诊断	3	
1.气胸		1.5
2.腹部闭合性损伤		1.5
四、进一步检查	4.5	
1.左侧胸腔积液超声定位及诊断性穿刺		1.5
2.腹部B超		1.5
3.必要时胸部CT。		1.5
五、治疗原则	5	
1.胸部包扎固定		1
2.对症治疗:吸氧，镇痛		1
3.行左侧胸腔穿刺引流或胸腔闭式引流术。		1
4.必要时开胸手术探查。		1
5.应用抗生素预防感染		1

(二) 心血管系统

1.心力衰竭

病例摘要

男性，57岁。突发呼吸困难2天。

患者2天前劳累后出现呼吸困难，无发热、咳嗽、咳痰及咯血，不能平卧，夜间睡眠差，坐位静息下尚可，稍微活动即有发作，未于外院就诊及服药，现来急诊就诊。近日睡眠差，饮食差，尿少。既往有心肌梗死病史10年，未系统治疗。否认高血压、糖尿病病史。有大量吸烟史，无饮酒史，否认心血管病家族史。

查体：T 36.0℃，P 106次/分，R 28次/分，BP 172/96mmHg。神志清楚，呼吸急促，端坐位，口唇发绀，无颈静脉怒张。双肺可闻及大量湿性啰音。心尖搏动位于左侧第5肋间锁骨中线外1厘米处，心率106次/分，心律齐，未闻及心脏杂音。腹平坦，无压痛，肝脾未触及，移动性浊音阴性，双下肢浮肿。

实验室检查：心电图提示：窦性心律，V1-6导联QS型。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如果有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
1.急性左心衰竭		2
2.冠心病 陈旧广泛前壁心肌梗死		1
3.缺血性心肌病		1
二、主要诊断依据	6	
1.急性左心衰竭		
(1) 心肌梗死病史 10 年		0.5
(2) 呼吸困难症状：劳累后发作、平卧加重，伴尿少		1
(3) 心率快、端坐呼吸、双肺有湿罗音、双下肢浮肿		1
2.冠心病 陈旧广泛前壁心肌梗死		
(1) 中老年男性，有大量吸烟史		0.5
(2) 心肌梗死病史 10 年		0.5
(3) 心电图提示：窦性心律，V1-6 导联 QS 型		0.5
3.缺血性心肌病		
(1) 心肌梗死病史 10 年		0.5
(2) 查体心脏扩大		1
(3) 心电图提示：窦性心律，V1-6 导联 QS 型		0.5
三、鉴别诊断	4	

1.慢性肺疾病		1
2.急性心肌梗死		1
3.急性肺栓塞		1
4.支气管哮喘		1
四、进一步检查	3	
1.心彩超		1
2.胸片或肺 CT		1
3.血常规、血气、肝肾功、TNI、BNP		1
五、治疗原则	5	
1.坐位、双下肢下垂、吸氧、控制入液量、心电监护		1
2.利尿减轻心脏前负荷		1
3.扩血管降压减轻心脏后负荷		1
4.洋地黄类药物强心		1
5.冠心病抗血小板他汀等药物治疗，二级预防		0.5
6.改善心衰预后药物：RAS 抑制剂/ARNI，BB,MRA 等		0.5

2.心律失常

(1) 室上速

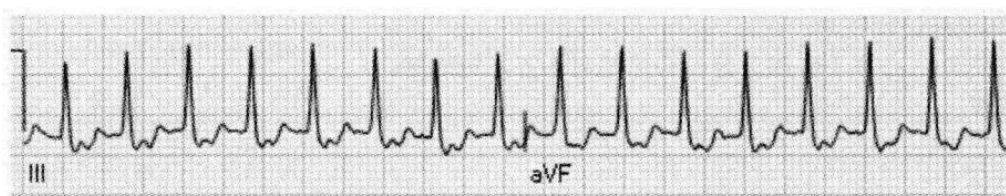
病例摘要

男性，30岁，阵发性心悸5年，再发2小时。

患者于5年来无明显诱因间断出现心悸，与活动无关，突然发作，发作时伴轻度胸闷，无胸痛，无头晕及黑矇晕厥，每次持续数十分钟至数小时不等，可自行好转。无症状时查心电图正常，未系统诊治。2小时前再次心悸发作，性质程度同前，来诊。饮食、睡眠正常，二便正常，体重无下降。

查体：T 36.5℃，P 160次/分，BP 124/78mmHg。一般状况可，心界不大，心音有力，心律整齐无杂音。肺、腹部检查未见异常。

实验室检查：ECG 如下图所示：



要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如果有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
心律失常 阵发性室上性心动过速		4
二、主要诊断依据	5	
1.青年男性，心悸症状突发突止。		2
2.查体：P 160 次/，BP 124/78mmHg。心界不大，心律整齐，无杂音。		1
3.心电图：室上性心动过速。		2
三、鉴别诊断	4	
1.持续性室速		1
2.窦速		1
3.非阵发性交界性心动过速		1
4.房扑		1
四、进一步检查	3	
1.发作时 ECG 基本可确诊；		1
2.如无 ECG 证据可行心内电生理检查，多数患者能诱发室上性心动过速，明确诊断，并可型。		2

五、治疗原则	6	
1.急性发作期： ①刺激迷走神经：颈动脉窦按摩（严禁双侧），Valsalva 动作； ②药物选用腺苷或维拉帕米静脉缓慢注射； ③西地兰静脉注射对伴有心功能不全患者可作首选； ④当患者出现严重的心绞痛、心肌缺血、低血压或心力衰竭或药物治疗无效，应立即进行电复律； ⑤已应用洋地黄者不应接受电复律。		3
2.预防：若发作频繁，症状显著且暂时不能行导管消融术者，洋地黄、长效钙通道阻滞剂或 β 受体阻滞剂可供选用。		1
3.手术：导管消融能根治心动过速，应优先考虑应用。		2

（2）房扑

病例摘要



男性，52岁，阵发性心悸3年，再发1天。

患者3年前无明显诱因间断出现心悸，每次发作持续数小时或数天，发作时无明显胸闷、胸痛，无头晕及黑矇晕厥，可自行缓解。未系统诊治。1天来症状再发，持续不缓解，性质程度同前，来诊。饮食、睡眠正常，二便正常，体重无下降。

查体：T 36.3℃，P 130次/分，BP 120/72mmHg。一般状况可，心界不大，心律整齐无杂音。肺、腹部检查未见异常。

实验室检查：ECG如下图所示：

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如果有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
心律失常 房扑（2:1 房室传导）		4
二、主要诊断依据	5	
1.中年男性，反复发作心悸。		1
2.心悸发作状态下，查体：P 130次/，BP 120/72mmHg。心界不大，		2

心律整齐，无杂音。		
3.心电图：房扑（2:1 房室传导）。		2
三、鉴别诊断	4	
1.窦速		1
2.房颤		1
3.阵发性室上速		1
4.房速		1
四、进一步检查	4	
1.动态心电图、心彩超		1
2.甲功、离子、血常规、生化指标		1
3.进一步心内电生理检查，可明确诊断。		2
五、治疗原则	5	
1.急性发作期终止方法：在皮下肝素抗凝同时，药物转律可选择普罗帕酮或伊布利特；必要时电转律。		2
2.预防：可口服索他洛尔或可达龙预防发作。		1
3.手术：导管消融能根治心动过速，应优先考虑应用。		2

3.冠状动脉性心脏病

病例1

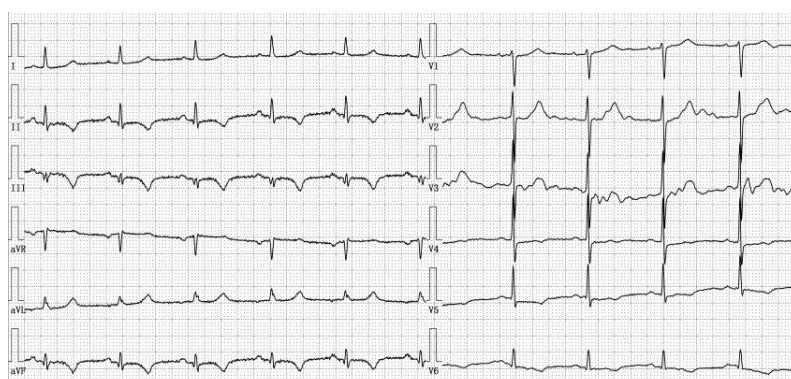
病历摘要

女性，67岁，间断胸痛6天，加重1天。

患者6天前夜间无明显诱因出现胸痛，位于胸骨后，烧灼感，向咽部、左肩部放射，伴大汗，无胸闷气短及恶心呕吐，疼痛持续30分钟左右，喝水后缓解。昨夜9点，患者突感胸痛再发，位于胸骨后，烧灼感，向咽喉、左肩部放射，较前加重。持续1小时无缓解，急诊就诊。既往史：高血压病病史10余年，最高达150/80mmHg，平素口服硝苯地平，血压平素控制在130/80mmHg；否认糖尿病及高脂血症等其他病史；否认药物及食物过敏史。无烟酒不良嗜好。否认家族相关性遗传病。

查体：T36.4℃，P68次/分，R18次/分，BP120/69mmHg。神清语明，步入病房，查体合作。全身皮肤黏膜无黄染，口唇无发绀。双肺听诊呼吸音清，未闻及干湿罗音。心律齐，心率68次/分，各瓣膜听诊区未闻及明显病理性杂音。腹部平软，无压痛、反跳痛及肌紧张，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

心电图：肌钙蛋白I 4.9390 ug/L



要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.冠状动脉粥样硬化性心脏病		1
（1）急性非ST段抬高型心肌梗死		1
（2）心功能I级（Killip级）		1
2.高血压1级，很高危。		1
二、主要诊断依据	5	
1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病，急性非 ST 段抬高型心肌梗死，心功能 I 级（Killip 级）		

(1) 老年女性，有高血压史。		1
(2) 静息时发作胸痛，向咽喉、左肩部放射，持续1小时无缓解。		1
(3) 查体：双肺呼吸音清，未见明显异常。		0.5
(4) 心电图：II,III,AVF,V4-V6导联 ST-T改变。		0.5
(5) hs-cTnI 增高。		1
2. 高血压1级，很高危。		
(1) 老年女性，有高血压10余年，最高达150/80mmHg。		0.5
(2) 合并心肌梗死。		0.5
三、鉴别诊断	4	
1.心绞痛		1
2.急性肺栓塞		1
3.主动脉夹层		1
4.急性胆道疾病等消化道疾病		0.5
5.继发性高血压		0.5
四、进一步检查	4	
1.监测心肌坏死标志物及心电图变化。		1
2.超声心动图。		0.5
3.胸部X线或CT等影像学检查。		0.5
4.血常规检查，肝、肾功能，血糖，血脂，血电解质，凝血功能，D二聚体，BNP（或NT-proBNP），动脉血气分析。		1.5
5.必要时行冠状动脉造影。		0.5
五、治疗原则	5	
1.卧床休息，吸氧，心电监护，建立静脉通道。		0.5
2.解除疼痛（如使用硝酸酯类药物）		0.5
3.抗凝及抗血小板聚集药物		1
4.心肌再灌注治疗（冠状动脉造影）		1
5.冠心病二级预防治疗。		1
6.长期降压治疗。		1

病例 2

病历摘要

男性，76岁，胸闷10余年，胸痛伴大汗1周。

患者10余年来偶有劳累时心前区隐痛，休息1-2分钟可自行缓解，未系统诊治。近1周出现每日晨起活动或受凉后胸痛，较前加重，伴大汗，含服速效救心丸20分钟可好转。既往史：糖尿病病史6年余，每日应用二甲双胍1.0g 日两次口服，长秀霖16单位睡前皮下注射，平素空腹血糖5-7mmol/l，餐后13mmol/l。否认高血压病史。吸烟30余年，戒烟6年，饮酒30余年，戒酒6年。否认食物及药物过敏史。否认家族遗传病史。

查体：T：36.5℃，P：94次/分，R：18次/分，BP：138/85mmHg，睑结膜无苍白，巩膜无黄染，口唇无发绀，颈静脉无充盈，双肺听诊呼吸音清，未闻及干湿啰音，心前区无异常隆起及异常搏动，心尖搏动位于第五肋间左锁中线内侧0.5cm，心律齐，心率94次/分，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹软，无压痛反跳痛及肌紧张，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

实验室检查：CK174U/L,CK-MB13U/L.cTnT 0.02mg/dl。空腹血糖7.3mmol/l。
心电图：窦性心律，V3-V6导联ST段下移0.2-0.3mv。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.冠状动脉粥样硬化性心脏病		1
（1）不稳定型心绞痛		1
（2）心功能I级（NYHA分级）		1
2.2型糖尿病。		1
二、主要诊断依据	4	
1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病，不稳定心绞痛，心功能I级（NYHA分级）		
（1）老年男性，有吸烟史及糖尿病史。		0.5
（2）活动或受凉时发作胸痛，含服速效救心丸20分钟可好转。		1
（3）查体：双肺呼吸音清，未见明显异常。		0.5
（4）心电图：II,III,AVF,V4-V6导联ST-T改变。		0.5
（5）CK174U/L,CK-MB13U/L.cTnT 0.02mg/dl。		0.5
2.2型糖尿病		

(1) 糖尿病病史6年余		0.5
(2) 空腹血糖7.3mmol/l		0.5
三、鉴别诊断	4	
1.急性心肌梗死		1
2.急性肺栓塞		1
3.主动脉夹层		1
4.胃食管反流等消化道疾病		0.5
5.I型糖尿病		0.5
四、进一步检查	5	
1.监测心肌坏死标志物及心电图变化。		1
2.超声心动图。		1
3.胸部X线或CT等影像学检查。		1
4.血常规检查，肝、肾功能，血糖，血脂，血电解质，凝血功能，D二聚体，BNP（或NT-proBNP），动脉血气分析。		1.5
5.必要时行冠状动脉造影。		0.5
五、治疗原则	5	
1.休息，心电监护，低盐低脂糖尿病饮食。		0.5
2.解除疼痛（如使用硝酸酯类药物）		1
3.抗血小板聚集药物，他汀调脂治疗。		1
4.择期冠状动脉造影。		1
5.冠心病二级预防治疗。		1
6.继续糖尿病药物治疗。		0.5

病例3

病历摘要

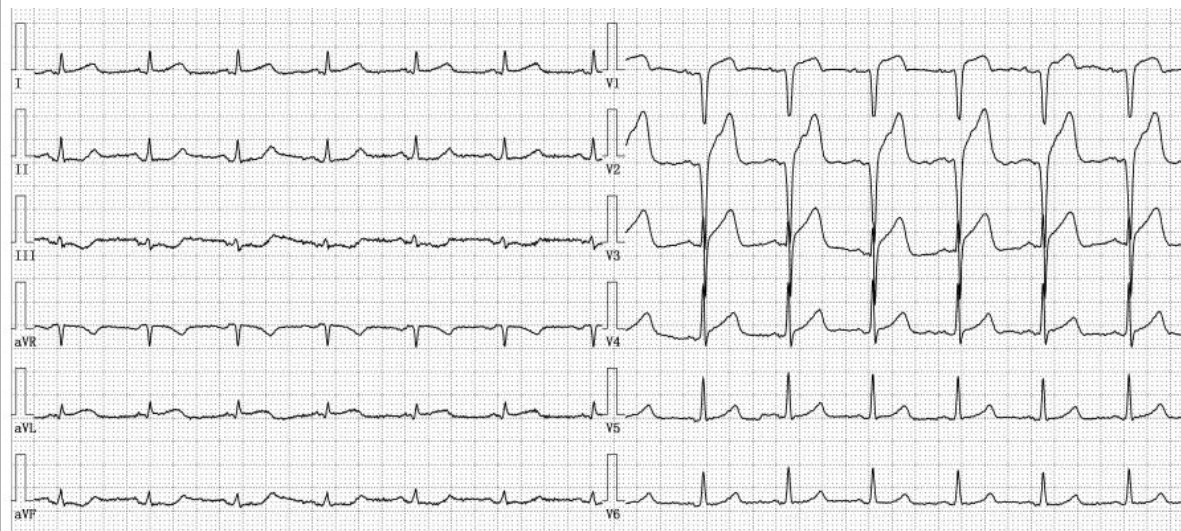
男性，67岁，胸闷伴呼吸困难1小时。

患者1小时前无明显诱因出现胸痛，伴胸闷气短，疼痛向左肩及后背放散，无大汗，无心悸，持续1小时含服救心丸不缓解。既往否认高血压糖尿病病史。否认药物及食物过敏史。吸烟30年；饮酒30年。否认相关家族遗传病史。

查体：T36.5℃，P96次/分，R18次/分，BP114/87mmHg。平车推入病房，查体合作。全身皮肤黏膜无黄染。口唇无发绀，双肺呼吸音清，心律齐，心率96次/分，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹部平软，无压痛、反跳痛及肌紧张，肝脾肋下未触及，双下肢无水肿。

实验室检查：hs-TropI 13.49ug/l。

心电图：



要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
1.冠状动脉粥样硬化性心脏病		1
（1）急性前壁心肌梗死		1
（2）心功能I级（Killip级）		1
二、主要诊断依据	5	
1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病，急性前壁心肌梗死，心功能I级（Killip分级）		
（1）老年男性，有吸烟史。		1

(2) 无明显诱因出现胸痛，伴胸闷气短，疼痛向左肩及后背放散，持续1小时含服救心丸不缓解。。		1
(3) 查体：双肺呼吸音清，未见明显异常。		1
(4) 心电图： V1-V4导联 ST抬高0.1-0.4mv。		1
(5) hs-TropI 13.49ug/l		1
三、鉴别诊断	4	
1.心绞痛		1
2.急性肺栓塞		1
3.主动脉夹层		1
4.急性胆道疾病等消化道疾病		1
四、进一步检查	5	
1.监测心肌坏死标志物及心电图变化。		1
2.超声心动图。		1
3.胸部X线或CT等影像学检查。		0.5
4.血常规检查，肝、肾功能，血糖，血脂，血电解质，凝血功能，D二聚体，BNP（或NT-proBNP），动脉血气分析。		1.5
5.必要时冠状动脉造影。		1
五、治疗原则	5	
1.卧床休息，心电监护，吸氧，低盐低脂饮食，戒烟。		1
2.解除疼痛（必要时可使用吗啡、硝酸酯等）		1
3.抗血小板聚集及抗凝药物，他汀调脂治疗。		1
4.心肌再灌注治疗（急诊行冠状动脉造影或溶栓）。		1
5.冠心病二级预防治疗。		1

4.高血压

病例摘要

男性，49岁。反复头晕3年，加重7天。患者3年前开始常在情绪波动时出现头晕，休息后能缓解，未诊治。后体检发现血压162/90mmHg，自行购买降压零号间断口服，血压未系统监测。最高血压185/102mmHg。近7天来休息不好，头晕加重，伴有恶心，无呕吐，无意识改变及肢体活动障碍。发病以来睡眠差，饮食及大小便正常。

既往有糖尿病病史3年，自服降糖药，血糖控制良好。否认吸烟饮酒史。

查体：T36.0℃，P72次/分，R16次/分，BP168/96mmHg。神志清楚，双肺呼吸音清，无啰音。心界无扩大，心率72次/分，心律整齐。腹平软，无压痛，肝脾未触及。双下肢无水肿。大血管听诊无杂音。

实验室检查：空腹血糖6.8mmol/L。

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断及诊断依据（如果有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
高血压病 3 级 很高危		3
2 型糖尿病		1
二、主要诊断依据	6	
1.高血压病 3 级 很高危		
（1）中年男性，反复头晕发作 3 年。		1
（2）有血压升高史，并口服降压药。		1
（3）查体 BP168/96mmHg。大血管听诊无杂音。		1
（4）有糖尿病病史。		1
2.2 型糖尿病		
（1）糖尿病病史已诊断。		1
（2）口服降糖药效果理想。		1
三、鉴别诊断	4	
1.脑血管病		2
2.继发性高血压		2
四、进一步检查	4	
1.心电图、心彩超		1
2.血常规、甲功、离子、肝肾功、尿常规或尿微量白蛋白/尿肌酐，或 24 小时尿蛋白定量		1

3.头 CT		1
4.肾动脉彩超、肾上腺彩超或增强 CT，必要时完善皮质醇节律及醛固酮卧立位等其他继发高血压检查。		1
五、治疗原则	4	
1.健康教育、改善生活习惯。		1
2.口服降压药治疗。		2
3.控制血糖。		1

5.心脏瓣膜病

病历摘要

女性，67岁，间断心悸、胸闷10余年，加重半个月。

患者10余年前开始出现劳累后心悸、胸闷。近1年来偶有夜间憋醒及下肢水肿。自行间断服用利尿剂缓解症状，未系统诊治。半个月前着凉后出现发热，38.2℃，伴咳嗽，咳白粘痰，无咯血，自服“感冒消炎药”后3天热退，咳痰好转。但心悸胸闷症状进行性加重，2天来夜内气短，不能平卧入睡，来诊。病来食欲差，睡眠欠佳，大便正常，尿量减少。既往曾有四肢关节游走性疼痛，否认高血压糖尿病病史。否认药物及食物过敏史。否认烟酒不良嗜好。否认相关家族遗传病史。

查体：T36.5℃，P86次/分，R20次/分，BP124/82mmHg。神志清楚，精神略差。全身皮肤黏膜无黄染，双颧绀红，浅表淋巴结未触及肿大，口唇无发绀。咽无充血，扁桃体不大，颈静脉充盈。双肺底可闻及中等量细湿啰音。心尖搏动位于第五肋间左锁中线外侧0.5cm，心率116次/分，心音强弱不等，心律绝对不齐，心尖部可闻及3/6级收缩期吹风样杂音和舒张中晚期隆隆样杂音。腹平软，无压痛、反跳痛及肌紧张，肝脾肋下未触及，双下肢指压痕（+）。

超声心动图：左房内径60cm，左室内径58cm，二尖瓣前叶呈“城墙样”改变，后叶与前叶同向运动，瓣叶回声增强，二尖瓣瓣口面积1.2cm²，闭合不良，彩超多普勒提示“二尖瓣中重度反流”。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.风湿性心脏瓣膜病。		1
2.二尖瓣狭窄并关闭不全。		1
3.心房颤动。		1
4.心功能IV级（NYHA分级）		1
二、主要诊断依据	5	
1. 老年女性，慢性病程。		0.5
2.既往曾有四肢关节游走性疼痛。		0.5
3. 劳累后心悸、胸闷。着凉后出现心悸胸闷症状进行性加重，夜内气短，不能平卧入睡，尿量减少。		1
4.查体：双颧绀红，颈静脉充盈。双肺底可闻及中等量细湿啰音。		1.5

心界扩大，心尖部可闻及3/6级收缩期吹风样杂音和舒张中晚期隆隆样杂音。双下肢指压痕（+）		
5.心音强弱不等，心律绝对不齐，脉搏短绌。		1
6.体力活动明显受限，夜间静息时不能平卧，提示心功能IV级。		0.5
三、鉴别诊断	3	
1.其他疾病所致心功能不全。		1
2.其他病因所致瓣膜损害。		0.5
3.其他病因所致房颤（如甲亢等）。		0.5
4.其他心脏疾病，如冠心病。		0.5
5.肺炎等呼吸系统疾病。		0.5
四、进一步检查	5	
1.心电图及动态心电图。		1
2.血常规检查，肝、肾功能，血糖，血电解质，凝血功能，BNP（或NT-proBNP），心肌损伤标志物。		1.5
3.胸部X线或CT等影像学检查。		0.5
4.血沉，ASO,CRP.		1.5
5.甲状腺功能。		0.5
五、治疗原则	5	
1.休息，心电监护，吸氧。		0.5
2.限制钠盐摄入及饮水量。		0.5
3.利尿、扩血管、强心等抗心衰治疗。		1.5
4.华法林抗凝治疗。		1
5.控制心室率治疗。		1
6.择期瓣膜置换手术。		0.5

6.结核性心包炎

病历摘要

男性，28岁，咳嗽伴发热2个月，加重伴气短1周。

患者2个月前受凉后出现发热，体温38.3℃，伴咳嗽咳少许白痰，无胸痛气短。自行口服“感冒咳嗽药”后咳嗽未见好转。体温波动在37.3℃-38℃之间。1周前咳嗽加重，干咳为主，偶有痰中带血丝，伴气短乏力，轻微胸痛，不能平卧，无腹胀腹痛。发病以来精神差，食欲差，大便正常，尿量减少。既往无肝病和肺结核病史，无高血压心脏病及风湿免疫疾病史。无烟酒不良嗜好，否认家族遗传疾病史。

查体：T37.5℃，P116次/分，R22次/分，BP94/72mmHg。半卧位，口唇无发绀。颈静脉怒张。双肺未闻及干湿啰音。心尖搏动未触及，心界向两侧扩大，心率116次/分，心律整齐，心音低钝遥远，未闻及心脏杂音。腹平软，无压痛、反跳痛及肌紧张，肝肋下2CM脾未触及，移动性浊音阴性，双下肢轻度凹陷性水肿。吸气时脉搏减弱。

胸部X线片：右上肺可见小片状及斑点状阴影，心影明显向两侧扩大。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.右上肺浸润性肺结核。（仅答“肺结核”得1分）		2
2.结核性心包炎。		1.5
3.心包积液（大量）。		0.5
二、主要诊断依据	5	
1.右上肺浸润性肺结核。		
（1）青年男性，有低热、干咳、痰中带血、乏力等肺结核表现。		1
（2）胸部X线片符合右上肺浸润性肺结核改变。		1
2.结核性心包炎，心包积液（大量）。		
（1）有肺结核感染证据。		0.5
（2）气短不能平卧症状。		0.5
（3）大量心包积液的体征（颈静脉怒张，心尖搏动未触及，心界向两侧扩大，心音低钝遥远，肝大，奇脉），双下肢轻度凹陷性水肿。		1.5
（4）胸部X线片：心影明显向两侧扩大。		0.5
三、鉴别诊断	3	

1.右上肺炎。		1
2.心力衰竭。		1
3.扩张型心肌病。		1
四、进一步检查	5	
1.痰液病原学检查（涂片抗酸染色，细菌培养+药敏）		1
2.血常规检查，肝、肾功能，血电解质，ESR检查。		1
3.PPD试验，结核抗体。		0.5
4.超声心动图检查。		1
5.心包穿刺液化验。		0.5
6.胸部CT检查。		1
五、治疗原则	5	
1.休息，加强营养，支持治疗。		1
2.心包穿刺引流。		2
3.抗结核治疗（早期、规律、全程、适量、联合）。（仅答抗结核治疗给1分。）		2

（三）消化系统

1.胃食管反流病

病历摘要

男性，67岁，间断反酸、烧心4年，症状频繁发作伴胸痛2个月。

患者4年前开始间断出现反酸、烧心，夜间或进食后明显，自服“雷尼替丁”治疗，症状可缓解，未系统诊治。近2个月来上述症状频繁发作伴胸骨后疼痛，疼痛于进食后明显，有时自觉咽部异物感，自服“雷尼替丁”后症状未完全缓解，发病以来食欲、睡眠尚可，排尿、排便正常，体重无明显变化。

既往史：否认肝胆疾病，无特殊用药史。无手术外伤史。无药物过敏史，吸烟20余年，20支/天。

查体：T 36.4℃，P 72次/分，R 16次/分，BP 130/80mmHg。身高170cm，体重88kg。浅表淋巴结未触及肿大。双肺呼吸音清，未闻及干湿性罗音。心界不大，心律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，全腹无压痛，肝脾肋下未及，未触及包块，Murphy征（-）双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：WBC $4.9 \times 10^9/L$ ，分类正常，RBC $4.3 \times 10^{12}/L$ ，Hb 125g/L，PLT $175 \times 10^9/L$ 。粪常规：镜检（-），隐血（-）。

心电图：窦性心律，心率78次/分，正常心电图。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
胃食管反流病（答“反流性食管炎”得3分）		4
二、主要诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分）	4	
1.老年男性，肥胖，慢性病程近期加重。		1
2.间断反酸、烧心，夜间或进食后明显，加重伴胸骨后疼痛。		2
3.以往服用雷尼替丁后症状可缓解。		0.5
4.心电图大致正常。		0.5
三、鉴别诊断	4	
1.消化性溃疡。		1
2.食管肿瘤（食管癌）。		1
3.贲门失弛缓症。		1
4.冠状动脉粥样硬化性心脏病。		1

四、进一步检查	5	
1.胃镜（必要时黏膜活检病理检查）。		2.5
2.上消化道X线钡剂造影检查。		1
3.必要时行食管pH监测及食管动力检查。		1
4.酌情查血糖，胸部X线片，超声心动图。		0.5
五、治疗原则	5	
1.调整生活方式，减轻体重，戒烟。		1.5
2.首选质子泵抑制剂。		2
3.抑酸剂按需治疗或维持治疗。		0.5
4.酌情应用促胃肠动力药和/或黏膜保护药。		0.5
5.酌情抗反流手术治疗。		0.5

2.食管癌

病历摘要

患者，男性，55岁。进行性吞咽困难6个月，加重伴呕吐1个月。

患者6个月前无明显诱因出现进行性吞咽困难、吞咽疼痛，开始进食固体食物时状明显，近1个月来进流质食物甚至喝水均有哽噎感，伴有进食后数分钟到数小时出现呕吐，呕吐物为进食物。无腹痛、反酸、胃灼热及腹泻症状。发病以来，食欲尚可，睡眠尚可，大小便正常，体重减轻10kg。

既往无手术史及服用化学腐蚀剂史，无药物过敏史。饮酒5年，每日3~4两，喜欢进食热烫食物。

查体：T36.7℃，P78次/分，R14次/分，BP120/80mmHg。一般情况稍差，皮肤及巩膜无黄染，左锁骨上可触及0.5cm×0.8cm大小的淋巴结，质地中等，无压痛，活动度欠佳。心肺无异常发现。腹部平软，无压痛反跳痛，肝脾未触及，移动性浊音阴性，肠鸣音正常。双下肢无水肿。直肠指检未见异常。

辅助检查：血常规：WBC $4.8 \times 10^9/L$ ，RBC $3.6 \times 10^{12}/L$ ，血Hb85g/L，PLT $240 \times 10^9/L$ 。粪便隐血阳性。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断（初步诊断错误，诊断依据不得分；未分别列出各自诊断依据，扣1分）	4	
1.食管癌（进展期）		2
2.失血性贫血		2
二、主要诊断依据	5	
1.食管癌（进展期）		
（1）中老年男性，慢性病程，嗜好热烫食物。		1
（2）进行性吞咽困难半年余，伴体重减轻，左锁骨上淋巴结肿大。		1
（3）粪便潜血阳性。		1
2.失血性贫血		
（1）Hb85g/L。		1
（2）粪便隐血阳性。		1
三、鉴别诊断	3	
1.贲门失弛缓症。		1

2.幽门梗阻。		1
3.反流性食管炎并食管狭窄。		1
四、进一步检查	5	
1.首选胃镜检查 and 活组织病理检查或X线钡餐检查。		2
2.淋巴结活检。		1
3.腹部超声、腹部CT和胸部CT检查，明确有无转移。		1
4.肝肾及心脏功能检查。		1
五、治疗原则	5	
1.一般治疗：加强支持治疗及对症治疗。		2
2.手术或放疗解除梗阻。		2
3.酌情进行化疗及生物治疗。		1

3.胃炎

病例1

病历摘要

女性，44岁，上腹部隐痛2周，黑便2天。

患者2周前开始自觉上腹部隐痛，进餐后加重，自服胃药（具体不详）后症状稍改善，近2天出现黑便，每日1次，成形便，量不多，无呕吐，无头晕，无心悸。发病以来食欲稍差，睡眠尚可，排尿正常，体重无明显变化。1个月前诊断为高血压，开始口服阿司匹林和拜新同。

否认胃肠道疾病和慢性肝病史，无烟酒嗜好。母亲有高血压病。

查体：T36.8℃，P76次/分，R16次/分，BP145/90mmHg。浅表淋巴结未触及肿大，皮肤及巩膜无黄染，结膜无苍白。心肺无异常发现。腹部平软，剑突下轻度压痛，无压痛反跳痛，肝脾未触及，移动性浊音阴性，肠鸣音正常。双下肢无水肿。

辅助检查：血常规：WBC $8.3 \times 10^9/L$ ，RBC $4.6 \times 10^{12}/L$ ，血Hb120g/L，PLT $210 \times 10^9/L$ 。粪便常规：黑色成形便，镜检（-）隐血阳性。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
1.急性糜烂出血性胃炎（或“非甾体抗炎药相关性胃病”或“急性胃黏膜病变”）（答“上消化道出血”得1分，答“急性胃炎”得1.5分）		2.5
2.高血压1级中危		0.5
二、主要诊断依据	6	
1.急性糜烂出血性胃炎		
（1）中年女性，急性病程，服用阿司匹林后发病		1.5
（2）以餐后上腹隐痛、黑便为主要临床表现。近期无体重下降		1.5
（3）剑突下轻度压痛		0.5
（4）黑色成形便，粪隐血阳性，镜检无异常		1.5
2.高血压1级中危		
（1）高血压病史及家族史		0.5
（2）查体：BP145/90mmHg。		0.5
三、鉴别诊断	3	
1.消化性溃疡（胃/十二指肠溃疡）		2
2.胃癌		1

四、进一步检查	5	
1.监测血常规，尿常规、肾功能、肝功能，心电图		2.5
2.胃镜，酌情活组织病理检查		2.5
五、治疗原则	5	
1.流食或半流食，避免刺激性饮食，酌情补液。		1
2.酌情减量或停用阿司匹林。		1
3.应用质子泵抑制剂或H ₂ 受体拮抗剂。		1
4.应用胃黏膜保护剂，如米索前列醇。		1
5.对症及降压治疗。		1

病例2

病历摘要

患者男，62岁。间断上腹胀痛5年。

患者于5年前进食过量后出现上腹隐痛，伴恶心，无呕吐，伴腹胀，自行口服“雷尼替丁和三九胃泰”后腹痛缓解。此后患者经常在进食不适后出现上腹隐痛，饱食后有腹胀，有时嗝气，偶尔反酸，胃部灼热，自行口服胃药可缓解。患者发病以来食欲正常，无剧烈腹痛，无黑便，体重无明显改变。

既往体健，否认慢性肝炎、高血压、糖尿病病史，无手术史，吸烟10年，15支/日。

查体：T36.5℃，P84次/分，R16次/分，BP115/70mmHg。浅表淋巴结未触及肿大，皮肤及巩膜无黄染，结膜无苍白。心肺无异常发现。腹平软，剑突下轻度压痛，无反跳痛，肝脾未触及，移动性浊音阴性，肠鸣音正常。双下肢无水肿。

辅助检查：血常规：WBC $7.3 \times 10^9/L$ ，RBC $4.4 \times 10^{12}/L$ ，血Hb120g/L，PLT $240 \times 10^9/L$ 。粪便常规：黄色成形便，镜检(-)，隐血阴性。超声：肝胆脾肾大致正常。心电图正常。胃镜：胃窦黏膜充血，色泽红白相间，以红为主，可见散在出血点和少量糜烂。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总22分	
一、初步诊断	4	
慢性非萎缩性胃炎（或慢性浅表性胃炎）（仅答慢性胃炎得1分）		4
二、主要诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分）	5	
1.老年男性，慢性发病。		1

2.间断上腹隐痛5年。		1
3.心肺未见异常，剑突下偏左轻压痛。（1分）		1
4.胃镜检查示胃窦黏膜充血，红白相间。		2
三、鉴别诊断	3	
1.慢性胆囊炎，胆石症。		1
2.胃溃疡。		1
3.慢性活动性肝炎。		1
四、进一步检查	5	
1.幽门螺杆菌（Hp）检测。		2
2.肝炎病毒标志物检测、肝功能。		1
3.血清学检测：促胃液素、抗壁细胞抗体、抗内因子抗体、维生素B12。		2
五、治疗原则	5	
1.一般治疗：戒除不良生活习惯。		1
2.消除病因，解除症状，防治复发。		1
3.明确反复发作原因，若Hp阳性，则应进行根除幽门螺杆菌治疗。		3

4.消化性溃疡

病例1

病历摘要

患者男，44岁。反复上腹痛10年，再发1周，黑便2天。

患者于10年前于冬季开始出现上腹痛，多为饥饿痛，有夜间痛，无放射，伴反酸，进食后症状可减轻。此后常于季节交替时出现上述症状，口服“雷尼替丁”后症状可缓解，1周前因进食不当，再次出现上述症状，因工作较忙未及时就诊。2天来出现黑色不成形便，共4次，总量约1000ml左右。自觉腹痛减轻，但感头晕、心悸、乏力。发病以来，食欲睡眠尚可，体重无减轻。

否认肝胆疾病史，近期末服用药物，无药物过敏史及手术、外伤史。偶尔饮酒，吸烟5年，10支/日。

查体：T36.2℃，P102次/分，R22次/分，BP95/60mmHg。神志清楚，查体合作，贫血貌，皮肤未见出血点及蜘蛛痣，未见肝掌，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜无黄染，双肺呼吸音清晰，心界不大，心率102次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，剑突下深压痛，无反跳痛，未触及包块，肝脾肋下未触及，Murphy征阴性，移动性浊音阴性，肠鸣音8次/分。双下肢无水肿。

辅助检查：血常规：WBC $9.3 \times 10^9/L$ ，N 70%，L 30%，RBC $3.2 \times 10^{12}/L$ ，Hb90g/L，PLt $240 \times 10^9/L$ 。粪便常规：黑色不成形便，镜检(-)，隐血(+)。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1 上消化道出血		1.5
2 十二指肠溃疡（答出“消化性溃疡”得1分）		1.5
3 失血性贫血（答出“贫血”得0.5分）		1
二、主要诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分；未分别列出各自诊断依据，扣1分）	5	
1 上消化道出血 十二指肠溃疡		
（1）明确的诱因：季节变化、进食不当。		0.5
（2）慢性病程：周期性发作，节律性疼痛（饥饿痛、夜间痛），进食或用抗酸药可缓解或减轻症状		1
（3）排黑便，伴血容量不足表现（头晕、心悸）		0.5
（4）心率增快，剑突下压痛，肠鸣音活跃。		0.5
（5）粪常规：黑色不成形便，镜检(-)，隐血(+)		1

2 失血性贫血		
(1) 上消化道出血病史		0.5
(2) 贫血貌		0.5
(3) 血红蛋白及红细胞数低于正常		0.5
三、鉴别诊断	4	
1. 胃溃疡		1
2. 急性糜烂出血性胃炎		1
3. 食管胃底静脉曲张破裂出血		1
4. 胃癌		1
四、进一步检查	4	
1.胃镜（或”于出血停止数天后行上消化道钡餐检查”）（仅答出“于出血停止数天后行上消化道钡餐检查”得1分）		1.5
2.择期行HP（幽门螺杆菌）检查		0.5
3.腹部B超.		0.5
4.查血型，动态观察血红蛋白、粪隐血、肝肾功能变化。		1
5.血CEA等肿瘤标志物检查		0.5
五、治疗原则	5	
1.限制饮食，注意休息。		0.5
2.建立静脉通路，纠正血容量不足。		1
3.促进溃疡愈合和止血治疗，首选静脉应用PPI类抑酸剂。		2
4.可酌情胃镜下止血或必要时外科手术治疗。		0.5
5.可加用胃粘膜保护剂；如有HP感染应进行根除HP治疗。		1

病例2

病历摘要

患者男性，36岁。间断上腹痛8年，呕吐7天。

患者于8年前开始反复出现上腹痛，多为饥饿痛，有夜间痛，无放射，伴反酸，进食后症状可减轻。此后常于秋末冬初时出现上述症状，口服“雷尼替丁”后症状可缓解。7天来自觉上腹胀满，进食后加重，伴呕吐，呕吐物为大量隔夜胃内容物，呕吐后腹胀缓解。近7天食欲差，大便量减少，排气存在，发病以来，睡眠尚可，体重略减轻。

否认肝胆疾病史，近期末服用药物，无药物过敏史及手术、外伤史。无烟酒嗜好。

查体：T36.5℃，P72次/分，R16次/分，BP120/80mmHg。神志清楚，查体合作，皮肤未见出血点及蜘蛛痣，未见肝掌，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜无黄染，结膜无苍白，双肺呼吸音清晰，心界不大，心率72次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，未见胃肠型及蠕动波，剑突下深压痛，无反跳痛，未触及包块，肝脾肋下未触及，Murphy征阴性，振水音阳性，移动性浊音阴性，肠鸣音3次/分。双下肢无水肿。

辅助检查：血常规：WBC $6.3 \times 10^9/L$ ，N 70%，L 30%，RBC $4.6 \times 10^{12}/L$ ，Hb123g/L，PLt $220 \times 10^9/L$ 。粪便常规：黄色软便，镜检(-)，隐血(-)。

上消化道造影检查：十二指肠有小龛影。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1. 幽门梗阻		2
2. 十二指肠溃疡（答出“消化性溃疡”得1.5分）		2
二、主要诊断依据（初步诊断错误，诊断依据不得分；未分别列出各自诊断依据，扣1分）	4	
1. 幽门梗阻		
（1）在十二指肠溃疡基础上，反复呕吐宿食，呕吐后腹胀缓解。		0.5
（2）振水音阳性		0.5
2. 十二指肠溃疡		
（1）青年男性，慢性病程，发病与季节有关。		1
（2）反复发作上腹痛，周期性发作，节律性疼痛（饥饿痛、夜间痛） 进食或用抗酸药可缓解或减轻症状		1

(3) 上腹压痛。		
(4) 上消化道造影检查提示十二指肠有小龛影符合十二指肠溃疡改变。		1
三、鉴别诊断	4	
1.胃溃疡		1
2.胆囊结石，胆囊炎		1
3.胃癌		1
4.急性胰腺炎		1
四、进一步检查	5	
1.胃镜及活组织检查。		2
2.择期行HP（幽门螺杆菌）检查		1
3.腹部B超。		1
4.肝肾功能、血电解质及动脉血气分析，CEA等肿瘤标志物。		1
五、治疗原则	5	
1.禁食水，胃肠减压,注意休息。		1
2.静脉补液,肠外营养。		1
3.促进溃疡愈合，静脉应用抑酸剂（PPI类或H2受体拮抗剂）。		1
4.必要时外科手术治疗。		1
5.如有HP感染应进行根除HP治疗。		1

5.消化道穿孔

病历摘要

患者男性，52岁，腹痛5小时，加重4小时。

患者于5小时前，饮酒后感上腹部隐痛不适，4小时前剑突下突发剧痛，伴恶心、呕吐数次，3小时前腹痛蔓延至右侧中、下腹部。患者因疼痛拒按腹部，烦躁不安，出冷汗。

既往间断上腹痛8年，饥饿时明显，未经系统诊治。

查体：T 37.8℃，P 110次/分，R 24次/分，BP 90/60mmHg。急性痛苦病容，烦躁，心肺检查未见明显异常，腹平坦，未见胃肠型及蠕动波，广泛腹肌紧张，剑突下区域及右侧中、下腹部压痛，反跳痛明显，剑突下最著，肝、脾肋下未触及，肝浊音界消失，移动性浊音（-）。肠鸣音偶可闻及，直肠指检未及异常。

辅助检查：WBC $11.9 \times 10^9/L$ ，N 87%，L 13%，RBC $4.7 \times 10^{12}/L$ ，Hb 140g/L，PLt $240 \times 10^9/L$ 。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1. 急性弥漫性腹膜炎		2
2. 消化性溃疡穿孔（十二指肠溃疡穿孔）		2
二、主要诊断依据	6	
1. 急性弥漫性腹膜炎		
（1）有消化性溃疡病史，突发上腹部剧痛，腹痛部位有转移，有消化道症状。		1
（2）体温升高，查体腹肌紧张，有压痛、反跳痛等腹膜炎体征，剑突下最明显。		1
（3）血白细胞总数及中性粒细胞比例升高		1
2. 消化性溃疡并穿孔（十二指肠溃疡穿孔）		
（1）既往间断上腹痛8年，饥饿时明显。		1
（2）饮酒后突发上腹部剧痛，腹痛部位有转移，有消化道症状。		1
（3）查体有腹膜炎体征，肝浊音界消失		1
三、鉴别诊断	5	
1. 胆囊炎，胆囊结石急性发作。		2
2. 急性胰腺炎。		1

3.急性心肌梗死。		1
4.急性阑尾炎		1
四、进一步检查	4	
1.立位腹部平片。		1
2.肝、胆、胰B超检查或腹部CT扫描。		1
3.血、尿淀粉酶测定。		1
4.诊断性腹腔穿刺。		1
五、治疗原则	3	
1.禁食，胃肠减压。		1
2.补液、维持水电解质平衡，应用抗生素治疗。		1
3.急诊外科手术。		1

6.消化道出血

病历摘要

男性，47岁。乏力、腹胀半年，呕血、黑便1天。

患者半年前开始出现乏力、腹胀，未就诊。1天前呕鲜血1次，量约200ml，排黑色不成形便3次，总量约800ml，感头晕、心悸。发病以来，食欲欠佳，尿量减少，睡眠尚可。10年前体检时发现HBsAg阳性，1年前查体时钡餐检查发现食管胃底静脉曲张。无药物过敏、手术及外伤史。

查体：T 36.5℃，P 102次/分，R 20次/分，BP 100/70mmHg。神志清楚，贫血貌，浅表淋巴结未触及肿大。可见肝掌及蜘蛛痣，巩膜无黄染。双肺呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音。心界不大，心率：102次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音。腹膨隆，无压痛及反跳痛，未触及包块，肝肋下未触及，脾肋下3cm，质地硬，移动性浊音阳性。肠鸣音活跃。双下肢凹陷性水肿。

实验室检查：血常规：RBC $2.8 \times 10^{12}/L$ ，Hb 69g/L，WBC $3.5 \times 10^9/L$ ，N 0.60，Plt $55 \times 10^9/L$ 。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.食管胃底静脉曲张破裂出血（仅答“上消化道出血”得0.5分）		1.5
2.失血性贫血		0.5
3.乙型病毒性肝炎肝硬化失代偿期（仅答“肝硬化”得0.5分）。		1
4.脾功能亢进		0.5
5.腹水		0.5
二、主要诊断依据	5	
1.食管胃底静脉曲张破裂出血，失血性贫血：		
（1）呕大量鲜血，排黑便。		0.5
（2）有门脉高压的特征性影像学改变，钡餐发现食管胃底静脉曲张。		1.5
（3）呕血、黑便后Hb 69g/L。		0.5
2.乙型病毒性肝炎肝硬化失代偿期，脾功能亢进、腹水：		
（1）长期HBsAg阳性，以乏力、腹胀、尿少为表现		1
（2）查体可见肝掌及蜘蛛痣、脾大、腹部膨隆，移动性浊音阳性、双下肢水肿		1
（3）实验室检查：全血细胞减少。		0.5

三、鉴别诊断	3	
1.消化性溃疡合并出血。		1
2.急性糜烂出血性胃炎。		1
3.胃癌合并出血。		1
四、进一步检查	5	
1.监测血常规、粪隐血，查血型。		1
2.胃镜检查。		1
3.腹部B超或CT检查。		1
4.肝功能、乙肝病毒相关性检查、凝血功能。		1
5.肾功能、电解质、肿瘤标志物。		1
五、治疗原则	5	
1.禁食水，卧床休息。		0.5
2.配血，补充血容量，维持水电平衡。		0.5
3.静脉应用生长抑素、抑酸剂。		1.5
4.可行内镜止血治疗。		1
5.酌情用三腔二囊管压迫止血。		0.5
6.必要时手术治疗或TIPs。		1

7.胃癌

病历摘要

男，65岁。上腹饱胀不适1年，加重伴呕吐20天，呕血1天。

患者1年前无明显诱因出现上腹饱胀不适，进餐后明显，伴乏力，偶有上腹隐痛、反酸，自服“奥美拉唑”后症状稍缓解。近20天上述症状明显加重，伴呕吐数次，呕吐物有酸臭味，呕吐后腹胀有所缓解，不敢正常进食，近1天出现呕血2次，为新鲜血，每次呕血约200ml左右。发病以来睡眠较差，近期尿量减少，有排便，量少，体重下降5kg。2年前体检查14C呼气试验阳性，无烟酒嗜好。

查体：T36.3℃，P100次/分，R18次/分，BP110/65mmHg。神志清楚，体型消瘦，睑结膜苍白，巩膜无黄染。左锁骨上可触及2枚黄豆大小的淋巴结，质硬，固定，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音。心率100次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹软，上腹正中可触及一个不规则的包块，质地硬，上腹轻度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），肠鸣音4次/分，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：Hb76g/L，RBC3.0×10¹²/L，WBC6.9×10⁹/L，N0.63，Plt189×10⁹/L，肝肾功能正常，粪常规：镜检（-），隐血（+）。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.上消化道出血		2
2.胃癌		1
3.不完全性幽门梗阻		0.5
4.失血性贫血		0.5
二、主要诊断依据	5	
1.上消化道出血，胃癌		
（1）老年男性，慢性进行性病程。		0.5
（2）有幽门螺杆菌感染病史。		0.5
（3）上腹饱胀伴乏力，体重明显下降。近期出现呕吐宿食，呕吐后腹胀缓解，呕血1天。		1
（4）消瘦体型，贫血貌，左锁骨上淋巴结肿大，上腹正中可触及一个不规则的包块，质地硬，上腹轻度压痛，肠鸣音正常。		1
2 幽门梗阻		
近期出现呕吐宿食，呕吐后腹胀缓解。		0.5
3.失血性贫血		

(1) 呕血1天。		0.5
(2) 查体可见睑结膜苍白。		0.5
(3) Hb72g/L，粪便隐血阳性。		0.5
三、鉴别诊断	3	
1. 消化性溃疡伴幽门梗阻和出血		1
2. 其他胃肿瘤（如胃淋巴瘤、胃间质瘤）		1
3. 肠梗阻。		0.5
4. 胰腺癌		0.5
四、进一步检查	5	
1.首选胃镜检查 and 活组织病理检查或X线钡餐检查。		2
2.肿大淋巴结穿刺活检行病理组织学检查。		1
3.腹部超声或CT检查，必要时腹部CT增强。		0.5
4.上消化道X线稀钡或泛影葡胺造影检查		0.5
5.化验血型、肝肾功能、电解质、肿瘤标志物。		0.5
6.胸部X线或CT检查		0.5
五、治疗原则	5	
1.禁食水、胃肠减压，营养支持、补液及对症治疗。		0.5
2.手术治疗解除梗阻和止血。		1.5
3.抑制胃酸，PPI静脉注射。		1
4. 内镜治疗。		0.5
5.酌情进行化疗、放疗及生物治疗。		1
6择期根除幽门螺旋杆菌治疗。		0.5

8.肝硬化

病历摘要

男性，52岁。间断乏力、腹胀3年，加重伴发热4天。

患者3年前开始间断出现乏力、腹胀，劳累后加重，未就诊。4天来腹胀加重，伴发热，体温最高38.5℃，伴尿少，尿量300ml/天，发病以来，食欲欠佳，大便尚可，睡眠尚可。既往无高血压，心脏病、肾病史，无肝炎病史，无药物过敏、手术及外伤史。饮酒20年，每日半斤白酒。

查体：T 38.3℃，P 102次/分，R 20次/分，BP 100/70mmHg。神志清楚，慢性病容，浅表淋巴结未触及肿大。可见肝掌及蜘蛛痣，巩膜黄染。双肺呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音。心界不大，心率：102次/分，律齐，各瓣膜区未闻及杂音。腹膨隆，腹肌稍紧张，全腹轻度压痛，轻度反跳痛，肝肋下未触及，脾肋下4cm，质地硬，移动性浊音阳性。双下肢凹陷性水肿。

实验室检查：血常规：Hb 83g/L，WBC $13.5 \times 10^9/L$ ，N 0.85，Plt $48 \times 10^9/L$ 。

肝功能：总蛋白65g/L，白蛋白28g/L，ALT 48U/L，总胆红素48.6umol/L，直接胆红素23.8umol/L，乙肝表面抗原阴性。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1. 酒精性肝硬化失代偿期（仅答“肝硬化”得0.5分）		1.5
2. 自发性腹膜炎		1
3. 脾功能亢进		1
4. 腹水		0.5
二、主要诊断依据	6	
1. 酒精性肝硬化失代偿期		
(1) 有长期大量饮酒史		0.5
(2) 慢性病程，腹胀乏力，伴少尿。		0.5
(3) 查体可见肝掌及蜘蛛痣、巩膜黄染，脾大、腹部移动性浊音阳性、双下肢水肿		0.5
(4) 实验室检查：血小板减少和血红蛋白降低。白蛋白降低。胆红素升高。		0.5
2. 自发性腹膜炎		
(1) 有肝硬化病史，腹胀加重伴发热		0.5
(2) 查体腹膨隆，腹肌稍紧张，全腹轻度压痛，轻度反跳痛，移动性		1

浊音阳性		
(3) 血白细胞总数和中性粒细胞比例升高		0.5
3. 脾功能亢进:		
(1) 肝硬化病史		0.5
(2) 查体: 脾大, 移动性浊音阳性		0.5
(3) 血常规提示血小板及血红蛋白均减少。		0.5
4.腹水:		
(1) 查体腹部膨隆, 移动性浊音阳性		0.5
三、鉴别诊断	3	
1.结核性腹膜炎。		1
2.原发性肝癌。		1
3.其他原因腹水(心源性腹水、肾性腹水、其他恶性肿瘤等)。		1
四、进一步检查	4	
1. 腹部B超或CT检查。		1
2. 腹腔穿刺, 腹水常规、生化、ADA, 培养+药敏试验, 细胞学检查		1
3.胃镜检查或上消化道造影		1
4.丙肝抗体、凝血功能、AFP等肿瘤标志物。		1
五、治疗原则	5	
1.低盐饮食, 休息, 戒酒。		1
2.广谱抗菌药物治疗。		1
3. 保肝、利尿及补充白蛋白。		2
4.必要时放腹水		1

9.非酒精性脂肪性肝病

病历摘要

男性，45岁。体检发现肝功能异常3年。

患者3年前与常规体检时发现ALT 78U/L，AST 57U/L，其余化验检查结果正常，无特殊不适，未诊治。此后数次检查肝功能均有异常，1周前复查肝功能：ALT 95U/L，AST 77U/L。无慢性肝炎病史，无药物及食物过敏史，无烟酒嗜好，无肿瘤家族史。

查体：BP130/80mmHg，P 78次/分，身高180cm，体重100kg，BMI 30.8。巩膜无黄染，未见肝掌和蜘蛛痣，皮肤未见出血点。腹软，无压痛，肝肋下2cm，质地韧，表面光滑，边缘整齐，无触痛。脾肋下未触及。Murphy征阴性。移动性浊音阴性，双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：WBC $8.5 \times 10^9/L$ ，N 0.65，RBC $4.7 \times 10^{12}/L$ ，Hb 128g/L，Plt $148 \times 10^9/L$ 。肝功能：总蛋白85g/L，白蛋白48g/L。ALT 108U/L，AST 95U/L，总胆红素16.6umol/L，直接胆红素6.8umol/L。总胆固醇6.1mmol/L，甘油三酯2.7 mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇4.2 mmol/L。粪常规：镜检（-），隐血（-）。

腹部超声：肝区近场回声弥漫性增强，远场回声逐渐衰减，肝脏轻度大，边缘较圆钝，脾脏厚度正常。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.非酒精性脂肪性肝炎。		3
2.血脂异常。		1
二、主要诊断依据	5	
1.非酒精性脂肪性肝炎		
中年男性，慢性病程；无饮酒及肝炎病史。		1
②无特殊不适，多次发现肝功能异常，除ALT及AST均升高，胆红素不高，总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇均升高。		1
③查体BMI30.8，未见肝掌、蜘蛛痣。肝脏肋下2cm，质地韧，表面光滑，边缘整齐，无触痛。脾未触及。		1
④腹部超声：肝区近场回声弥漫性增强，远场回声逐渐衰减。肝脏轻度大。		1
2.血脂异常：总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇均升高。		1
三、鉴别诊断	4	

1.病毒性肝炎。		1
2.自身免疫性肝病。		1
3.肝脏肿瘤。		1
4.非酒精性脂肪性肝炎相关肝硬化。		1
四、进一步检查	5	
1.血脂、血糖、肾功、电解质等。		1
2.肝炎病毒学指标。		1
3.自身免疫性肝病指标。		1
4.甲胎蛋白。		1
5.必要时肝活检行病理学检查。		1
五、治疗原则	4	
1.饮食控制，低糖、低脂、高纤维素饮食。		0.5
2.运动治疗：采取中等量有氧运动，逐步减轻体重。		0.5
3.调脂治疗。		1
4.若合并2型糖尿病，可给予降糖药物治疗。		1
5.若肝功能持续异常，可应用保肝药物。		1

10.肝癌

病历摘要

男性，52岁，全身乏力伴右上腹胀痛半年。

患者于半年前出现全身乏力伴右上腹胀痛，向背部放散。病程中伴有食欲不振，厌油腻，体重减轻2千克。有乙型肝炎病史30年，未规范治疗。

查体：T36.5°C, P72次/分，R18次/分，BP120/70mmHg。神清语明，面色晦暗，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌及蜘蛛痣，浅表淋巴结未触及肿大，心肺查体未见异常。腹部略膨隆，未见胃肠型及蠕动波，未见腹壁静脉显露。腹软，肝肋下可触及边缘，质硬，边缘不规则，触痛（+），脾肋下2cm，肝区无叩痛，移动性浊音（—），肠鸣音4次/分。

实验室检查：血常规：WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，Hg120g/L，PLT $90 \times 10^9/L$ ，AFP $>1000ng/L$ ，

腹部B超：肝右后叶可见1直径5.8cm中等偏低回声肿块，边界尚清，肝内外胆管无扩张。门静脉主干约1.1cm，脾大。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	5	
1.原发性肝癌（仅答肝癌得3分）		4
2.乙肝后肝硬化		1
二、主要诊断依据	5	
1原发性肝癌		
（1）乙肝病史多年，肝区疼痛		1
（2）肝大，质硬，边缘不规则		1
（3）B超提示有单个实性占位		1
（4）甲胎蛋白明显升高		1
2乙肝后肝硬化		
（1）肝炎病史，乏力、食欲不振		0.5
（2）肝质地硬，脾大，血小板减少		0.5
三、鉴别诊断	4	
1 肝良性肿瘤		1.5
2 肝转移癌		1.5
3 肝囊肿或肝脓肿		0.5

4 肝包虫病		0.5
四、进一步检查	3	
1 肝功能、病毒标志物，如HBVDNA,其他肿瘤标志物如CEA，动态监测AFP。		1
2 腹部增强CT或MR		1
3 血管造影或肝核素扫描，肝脏肿物穿刺或组织病理检查，胃镜或上消化道钡餐造影		1
五、治疗原则	5	
1 手术治疗或介入治疗（介入栓塞、介入化疗）		2
2 放射治疗		1
3 免疫治疗或中医中药治疗		1
4 酌情抗病毒治疗，保肝治疗。		1

11.胆石病、胆道感染

病历摘要 患者女性，56岁，反复右上腹疼痛5年，加重伴周身黄染2天 5年来反复出现右上腹疼痛，为持续性胀痛或阵发性绞痛，无明显放射痛，口服“消炎药”或“莨菪片”后症状可缓解。2天前腹痛加重，伴恶心呕吐，无明显寒战发热，出血周身皮肤及巩膜黄染，尿色加深，食欲下降，粪便颜色变浅。既往有胆囊结石病史，无高血压、心脏病，无肝炎结核病史。 查体：T37.5℃,P78次/分，R20次/分，BP120/70mmHg。神清语明，急性病容，皮肤巩膜黄染，未见肝掌及蜘蛛痣，浅表淋巴结未触及肿大，心肺查体未见异常。腹部略膨隆，未见胃肠型及蠕动波，未见腹壁静脉显露。腹软，右上腹压痛，无反跳痛及肌紧张，Murphy征阴性，肝脾肋下未触及，移动性浊音（—），肠鸣音4次/分。 实验室检查：血常规：WBC12.4×10⁹/L，Hg120g/L，PLT 120×10⁹/L，尿常规：尿胆红素（++）生化：总胆红素：181umol/L,直接胆红素113 umol/L，ALT151U/L,AST52U/L。 腹部B超：肝内外胆管扩张,胆总管直径1.4cm，其末端可见多发强回声团，伴声影；胆囊8.0×4.3cm，壁毛糙，内可见多个强回声团块，后伴声影，较大直径0.8cm。 要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。		
评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	

1.胆总管结石		3
2.胆囊结石		1
二、主要诊断依据	6	
1 胆总管结石		
（1）反复发作性右上腹绞痛，近期出现黄疸		1.5
（2）皮肤巩膜黄染，右上腹压痛		1
（3）外周血白细胞升高，黄疸指数以直接胆红素升高为主		1
2 胆囊结石		
（1）右上腹痛		1
（2）超声提示：胆囊内多个强回声团		1.5
三、鉴别诊断	4	
1 胆总管下段肿瘤，壶腹癌		2
2 胆管损伤致炎性狭窄、梗阻		1
3 胆道蛔虫症		1
四、进一步检查	4	
1 腹部CT或MRCP（磁共振胆道水成像）		1
2 血肿瘤标志物		1
3 必要时行ERCP（内镜下逆行胰胆管造影）检查		1
4 血肿瘤标记物（CEA、CA199等）检查		1
五、治疗原则	4	
1 抗感染治疗		
2.急诊ERCP+EST+ENBD（内镜下逆行胰胆管造影+乳头肌切开+取石术+鼻胆管引流）或急诊胆囊切除+胆总管探查		

12.急性胰腺炎

病历摘要

男性，37岁。持续性上腹痛10小时。

10小时前进食油腻食物后出现持续性上腹疼痛，向腰背部放射，伴恶心呕吐，弯腰抱膝位略缓解，自觉发热，口服胃药无明显缓解。半年前体检发现血脂异常，未重视。

查体：T38.5°C, P98次/分，R20次/分，BP140/70mmHg。神清语明，急性病容，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌及蜘蛛痣，浅表淋巴结未触及肿大，心肺查体未见异常。腹部平坦，未见胃肠型及蠕动波，未见腹壁静脉显露。腹软，剑突下及左上腹压痛，无反跳痛及肌紧张，Murphy征阴性，肝脾肋下未触及，移动性浊音（—），肠鸣音2-3次/分。

实验室检查：血常规：WBC $12.4 \times 10^9/L$ ，N 0.89，Hg120g/L，PLT $120 \times 10^9/L$ ，血淀粉酶504U/L

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
急性胰腺炎		3
二、主要诊断依据	5	
1 中年，暴饮暴食急性起病，既往血脂异常		1.5
2 持续性腹痛，向后腰放射		1
3 查体：剑突下及左上腹压痛，肠鸣音略减弱		1
4 血淀粉酶升高3倍以上		1.5
三、鉴别诊断	4	
1 消化性溃疡穿孔		1
2 胆石症 胆囊炎		1
3 急性肠梗阻		1
4 冠心病 心肌梗塞		1
四、进一步检查	5	
1 肝肾功、血电解质（注意血钙）、血糖、动脉血气分析		2
2 血尿淀粉酶、脂肪酶		1
3 腹部B超，CT检查		1
4 心电图、心肌酶		1

五、治疗原则	5	
1 禁食水、胃肠减压，卧床休息		1
2 营养支持、维持水电解质及酸碱平衡		1
3 抑制胰腺外分泌及胰酶活性		1
4 合理应用抗生素		1
5 胆源性胰腺炎性ERCP+EST+ENBD		1

13.溃疡性结肠炎

病历摘要		
女性，24岁，间断腹痛、腹泻，粘液脓血便2年，加重伴发热3天 患者2年前无明显诱因反复腹痛腹泻，每日稀便4-6次，时有下腹痛及排便不尽感，未系统治疗。近1周上述症状复发，大便混有粘液或鲜血便，每日6-8次，伴发热，体温最高达39℃，左下腹，口服“左氧氟沙星及黄连素”无效。发病以来，食欲减退，体重减轻5千克。既往有关节炎病史。 查体：T38.5℃,P106次/分，R20次/分，BP100/70mmHg。神清语明，贫血貌，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌及蜘蛛痣，浅表淋巴结未触及肿大，心肺查体未见异常。腹部平坦，未见胃肠型及蠕动波，未见腹壁静脉显露。腹软，左下腹压痛，无反跳痛及肌紧张，Murphy征阴性，肝脾肋下未触及，移动性浊音（—），肠鸣音4-6次/分。 实验室检查：血常规：WBC12.4×10⁹/L，Hg88g/L，PLT 120×10⁹/L，便常规+潜血：镜检WBC5-15/HP,RBC满视野/高倍视野，OB（+）		
要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。		
评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
溃疡性结肠炎（慢性持续型，重度，活动期）（仅答溃疡性结肠炎得2分）		3
二、主要诊断依据	5	
1 青年女性，慢性病程，既往有关节炎病史		1.5
2 间断腹痛腹泻，粘液脓血便，每日>6次，发热，抗炎无效		1
3 发热，脉率加快，左下腹压痛（+）		1
4 血常规：血象高，贫血，便红白细胞增多		1.5
三、鉴别诊断	3	
1.感染性肠炎，如细菌性痢疾		1

2.克罗恩病		0.5
3.结肠癌		0.5
4.阿米巴肠炎		0.5
5.肠结核或其他感染性腹泻。		0.5
四、进一步检查	5	
1 完善结肠镜及病理活检		2
2.粪便查病原学		1
3 肝肾功能、电解质、血气分析		1
4 血沉、C-反应蛋白、自身抗体检测		1
五、治疗原则	6	
1 氨基水杨酸制剂		1.5
2 糖皮质激素		1.5
3 必要时应用免疫抑制剂或生物制剂治疗		1
4 适当休息，限制饮食。对症治疗，营养支持，必要时肠外营养。		1
5 手术治疗，适当应用抗生素。		1

14. 克罗恩病

病历摘要

男性，36岁，间断脐周及右下腹痛2年，加重3个月

患者2年前无明显诱因出现腹痛，以脐周及右下腹痛为著，为隐痛，伴腹泻，每日2-3次，大便糊状，便后腹痛能缓解，无粘液便及脓血便，无明显里急后重。近3个月来右下腹痛较前加重，伴发热，体温最高38.2℃，静脉应用抗生素无明显缓解。体重减轻约4千克。

既往否认结核病史，无食物及药物过敏史。

查体：T38.2℃，P96次/分，R20次/分，BP100/70mmHg。神清语明，贫血貌，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌及蜘蛛痣，浅表淋巴结未触及肿大，心肺查体未见异常。腹部平坦，未见胃肠型及蠕动波，未见腹壁静脉显露。腹软，全腹未触及包块，脐周及右下腹压痛，无反跳痛及肌紧张，Murphy征阴性，肝脾肋下未触及，移动性浊音（—），肠鸣音4次/分。

实验室检查：血常规：WBC $8.3 \times 10^9/L$ ，Hg98g/L，PLT $120 \times 10^9/L$ ，便潜血：OB（+），ESR35mm/h。胸部X线检查：心肺未见明显异常。肠镜检查：回肠末段纵行溃疡性病变，大小约0.4×0.8cm，局部肠腔略狭窄，病灶呈节段性分布及卵石样外观

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
克罗恩病		3
二、主要诊断依据	5	
1. 病史：青年，男性，起病隐匿、缓慢		1
2. 表现：腹痛、腹泻、体重下降，抗生素无效		1
3. 体征：脐周及右下腹压痛		0.5
4 贫血、白细胞升高、血沉增快、便潜血（+）		0.5
5 肠镜：回肠末段，非连续性病变、纵行溃疡、卵石样外观		2
三、鉴别诊断	3	
1 肠结核		1
2 UC		1
3 急性阑尾炎		0.5
4 淋巴瘤		0.5

5 结肠癌		
6 阿米巴肠炎		
7 慢性细菌性痢疾		
四、进一步检查	5	
1 肝肾功、电解质、CRP，肿瘤标志物		2
2 PPD实验、病理证实非干酪性肉芽肿		2
3 进一步病原学和病因学检查，便培养，便查阿米巴。		0.5
4 血自身抗体如外周型抗中性粒细胞胞质抗体（p-ANCA）和抗酿酒酵母抗体（ASCA）。		0.5
五、治疗原则	6	
1 一般治疗：适当休息，注意饮食。对症、营养支持治疗，纠正贫血，全肠内营养，要素饮食		1
2 氨基水杨酸制剂		1
3 糖皮质激素		1
4 免疫抑制剂、或生物制剂治疗，必要时手术治疗		1
5 抗生素		1
6 全肠内营养 要素饮食		1

15.肠梗阻

病历摘要

男性，62岁，腹痛呕吐3天，加重伴发热6小时

患者3天前饱食后腹痛，为腹痛，伴腹胀，伴有呕吐，呕吐物为胃内容物，3天来未排便，无排气。6小时前腹痛腹胀加重，伴发热，体温最高38.7℃，轻度畏寒。发病以来仅进食少量流食，小便量减少。

10年前因化脓性阑尾炎行阑尾切除术。无高血压、冠心病病史，无烟酒嗜好，无遗传病家族史。

查体：T38.4℃，P102次/分，R20次/分，BP140/80mmHg。皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。结膜无苍白，巩膜无黄染，甲状腺未触及肿大。双肺呼吸音清，未闻及干湿性罗音。心界不大，心率102次/分，心律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹膨隆，右下腹可见手术瘢痕，腹部肌紧张(+)，压痛、反跳痛明显，肝脾肋下未及，肝浊音界存在，移动性浊音(+)。未闻及肠鸣音。双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：WBC24.9×10⁹/L，N 0.91，RBC5.3×10¹²/L，Hb135g/L，PLT 275×10⁹/L。血淀粉酶 100U/L，血钾3.0mmol/L，血钠142mmol/L。入院当天尿量360ml，尿比重1.023。粪常规：镜检(-)，隐血(-)。

心电图：窦性心动过速，心率102次/分。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	5	
1 急性肠梗阻（3分），绞窄性（1分）		4
2 低钾血症		1
二、主要诊断依据	5	
1.急性肠梗阻，绞窄性。		
（1）腹痛、腹胀、呕吐、停止排气排便3天。		1
（2）曾行阑尾切除术。（0.5分）		0.5
（3）腹痛、腹胀加重伴发热		0.5
（4）腹部膨隆，腹肌紧张（+），压痛反跳痛明显，肠鸣音消失		1
（5）血白细胞总数及中性粒细胞比例均增加		1
2 低钾血症		
（1）呕吐		0.5
（2）血钾浓度低于正常低值		0.5
三、鉴别诊断	3	

1.消化道穿孔。		1
2.急性胰腺炎		1
3.急性胆囊炎		1
四、进一步检查	4	
1.立位腹部X线平片		2
2.腹部超声或CT检查。		1
3.动脉血气分析检查。		0.5
4.肝肾功能检查		0.5
五、治疗原则	5	
1.禁食水、胃肠减压。		1
2.静脉补液，补钾，维持水、电解质、酸碱平衡		1
3.急诊手术。		2
4.静脉应用抗生素		1

16.结、直肠癌

17.肠结核

18.结核性腹膜炎

病历摘要

女性，37岁，腹胀、乏力6个月

患者6个月前工作劳累后因自觉乏力、腹胀，自服“胃药”无明显缓解。发病以来食欲减退，有午后低热，具体未测体温，大便为糊状，每日2-4次，无粘液便及脓血便，尿量每日约800毫升，尿色清。近6个月体重增加3千克。

否认高血压心脏病糖尿病史，无肿瘤家族史。

查体：晨起体温 T36.6℃，下午5时体温 T37.6℃ P86次/分，R20次/分，BP100/70mmHg。神清语明，贫血貌，皮肤巩膜无黄染，未见肝掌及蜘蛛痣，浅表淋巴结未触及肿大，心肺查体未见异常。腹部膨隆，未见胃肠型及蠕动波，未见腹壁静脉显露。触诊腹部柔韧感，全腹轻压痛，反跳痛（+），Murphy征阴性，肝脾肋下未触及，移动性浊音（+），肠鸣音4次/分。双下肢无水肿。

实验室检查：血常规：WBC $8.3 \times 10^9/L$ ，L 0.55，Hgb118g/L，PLT $120 \times 10^9/L$ ，ESR 60mm/h。B超：腹腔内中等量积液。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
结核性腹膜炎（仅答腹膜炎得2分）		3
二、主要诊断依据	5	
1 青年患者，起病缓慢隐匿，劳累后发病		1
2 乏力、腹胀、腹泻，伴有午后低热		1
3 查体：低热，腹部柔韧感或揉面感，压痛、反跳痛（+），移动性浊音（+）		1
4 实验室检查：淋巴细胞比率升高，血沉快		1
5 B超：提示腹腔积液		1
三、鉴别诊断	4	
1 腹腔恶性肿瘤		1.5
2 肝硬化腹水		1.5
3 其他疾病：结缔组织病、缩窄性心包炎、布加综合征		0.5
4 感染性疾病		0.5
四、进一步检查	6	
1 肝肾功、C反应蛋白、肿瘤标志物		1.5

2 PPD试验或TSPOT		1
3 诊断性穿刺：腹水常规、生化、腺苷脱氨酶、脱落细胞学		2,5
4 胸部及腹部CT，肠镜，钡剂灌肠等		0.5
5 必要时腹腔镜检查		0.5
五、治疗原则	4	
1 注意休息，加强营养，抗结核化学药物治疗（早期、全程、联合、适量）仅答抗结核治疗得1分		2
2 放腹水		1
3 手术治疗		1

19.急性阑尾炎

病历摘要

女性，32岁。转移性右下腹痛16小时。

患者16小时前出现上腹及脐周胀痛，伴恶心、呕吐2次，呕吐物为胃内容物。自服“止痛药”后症状无明显缓解。发病8小时后腹痛转移至右下腹，伴发热、腹胀。既往体健，月经正常，无痛经史。体重近期无明显变化。

查体：T39°C，P101次/分，R21次/分，BP130/70mmHg.心肺查体未见异常。下腹部有压痛、反跳痛及肌紧张，以右下腹为重，移动性浊音阴性，肠鸣音减弱。

实验室检查：血常规：Hb130g/L,WBC16.5x10⁹/L,NO.91%,PLT210x10⁹/L.

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.急性化脓性阑尾炎。（答“急性阑尾炎或其他类型阑尾炎”得1分）		3
2.局限性腹膜炎。		1
二、主要诊断依据	5	
1.急性化脓性阑尾炎。		
（1）青年女性，转移性右下腹痛，急性起病。		1
（2）体温39°C,下腹部有压痛。		1
（3）血白细胞总数及中性粒细胞比例增高。		1
2.局限性腹膜炎：下腹部有压痛、反跳痛及肌紧张，以右下腹为重。		2
三、鉴别诊断（4分）	4	
1.消化性溃疡穿孔。		1
2.右输尿管结石。		1
3.急性肠梗阻。		1
4.右输卵管异位妊娠破裂或卵巢囊肿蒂扭转。		1
四、进一步检查	4	
1.尿常规、粪常规。		1
2.立位腹部X线平片。		1.5
3.腹部B超及妇科B超。		1.5
五、治疗原则	5	
1.禁食，维持水、电解质及酸碱平衡。		1
2.急诊阑尾切除术。		2
3.抗感染治疗。		2

20.肛管、直肠良性病变

(1) 痔

病历摘要

男性，50岁。大便时肛门脱出肿物2年。

患者2年前开始每天大便干燥时引起肛门口脱出小肿物，伴鲜血滴出，无疼痛，便后脱出物可自行回纳。近3个月来肛门脱出肿物逐渐增大，便后不能完全自行回纳，常常需要用手回纳。发病以来，经常便秘，睡眠好，体重无明显减轻。

查体：T36.7℃,P78次/分，R18次/分，BP110/70mmHg.心脏、肺、腹部检查未见异常。肛门直肠检查：膝胸位。肛门1、5、9点处可见肿物脱出，肿物突出于黏膜，质软，呈暗红色，挤压可变形。肛门未见皮肤裂口。直肠指诊：肛门括约肌松弛，直肠黏膜光滑，指套表面可见新鲜血迹。

实验室检查：血常规Hb126g/L,WBC6.4x10⁹/L,NO.68,PLT225x10⁹/L.

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.内痔。		3
2.痔脱出。		1
二、主要诊断依据	5	
1.大便时肛门脱出肿物伴便血，无疼痛。		1
2.便后脱出肿物可回纳。		1
3.脱出肿物膝胸位在肛门1、5、9点处。		1
4.直肠指诊：肛门括约肌松弛，直肠黏膜光滑，指套表面可见新鲜血迹。		1
5.肿物突出于黏膜，质软，呈暗红色，挤压可变形。		1
三、鉴别诊断	4	
1.直肠癌。		1
2.直肠息肉。		1
3.直肠脱垂。		1
4.血栓性外痔。		1
四、进一步检查	4	
1.直肠镜。		2
2.粪常规、血CEA。		2

五、治疗原则		
1.保持大便通畅，防止便秘和腹泻。		1
2.肛管内应用药物。		1
3.硬化剂注射疗法、红外线凝固法等。		1
4.必要时手术治疗（胶圈套扎、痔单纯切除术等）。		2

(2) 肛裂

病历摘要

女性，20岁。肛门部疼痛、出血间歇发作2年。

患者2年前开始经常出现便秘，每当大便干燥期间，排便时肛门部疼痛，手纸上常带线状血迹，便后疼痛暂时减轻，数钟后反而加剧。排便通畅后即好转。既往体健，月经正常。

查体：T36.5℃,P80次/分，R15次/分，BP100/70mmHg.体形瘦弱，睑结膜无苍白。心脏、肺、腹部检查未见异常。肛门检查：膝胸位6点处可见肛管皮肤裂口，边缘增厚，肉芽暗红色；裂口近端肛乳头水肿、肥大；远端皮肤形成袋状皮垂突出于肛门外。因患者肛门部疼痛较剧，未做直肠指诊。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
肛裂。		4
二、主要诊断依据	5	
1.青年女性，体形瘦弱。		1
2.典型临床表现：肛门部疼痛、便秘、出血。		2
3.肛门检查：可见肛裂、前哨痔、肛乳头肥大，即肛裂“三联征”。		2
三、鉴别诊断	4	
1.痔。		1.5
2.炎症性肠病。		1.5
3.直肠肛管肿瘤。		1
四、进一步检查	4	
1.直肠指检。		1
2.直肠镜检查。		1
3.血、粪常规。		1
4.必要时活体组织病理检查。		1
五、治疗原则	5	
1.口服缓泻剂或液状石蜡纠正便秘，增加纤维性食物、多饮水，保持大便通畅。		1
2.便后高锰酸钾坐浴，保持局部清洁。		1.5
3.局部麻醉后扩肛。		1.5
4.必要时可行肛裂切除术等。		1

21.腹外疝

病历摘要

"男性，70岁。右下腹坠胀5个月，加重2天。

患者5个月来，常感右下腹坠胀感，发病来饮食及大小便均正常，未予诊治。2天前抬水时突感右下腹胀痛，无恶心、呕吐。发病后少量进食，未排大便，小便正常。目前精神尚可，体重未减轻。既往体健，近10年体检，血压在140~160/80~100mmHg，观察至今，未予治疗。

无外伤及腹部手术史，无肝病和心脏病病史。吸烟30余年，15支/日。无遗传病家族史。

查体：36.8℃，P85次/分，R17次/分，BP155/100mmHg，体态略胖，浅表淋巴结未触及肿大，双肺听诊正常。心界不大，心率86次/分，心律正常，各瓣膜听诊区未闻及杂音。腹平软，无压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），肠鸣音稍亢进。右腹股沟区可触及7cmx5cm包块，呈椭圆形，压痛明显，活动度差，平卧位无法消失。

实验室检查：血常规：Hb 135g/L，RBC $4.5 \times 10^{12}/L$ ，WBC $10 \times 10^9/L$ ，Plt $160 \times 10^9/L$ 。尿常规（-），粪常规（-）。

要求：根据以上病历摘要，将初步诊断、诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。"

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1、右侧腹股沟嵌顿疝（直疝）		3
2、高血压2级，中危		1
二、诊断依据	5	
1、右侧腹股沟嵌顿疝	4	
（1）老年男性，右下腹坠胀5个月，抬水时诱发。		2
（2）查体：右腹股沟包块，呈椭圆形，压痛明显，活动度差，平卧位无法消失，肠鸣音亢进。		2
2、高血压2级，中危	1	
（1）老年男性，有吸烟史，近十年血压偏高		0.5
（2）查体血压 155/100mmHg		0.5
三、鉴别诊断	4	
1、睾丸鞘膜积液		1.5
2、腹股沟斜疝		1.5

3、腹股沟淋巴结肿大		1
四、进一步检查	5	
1、包块透光实验		2
2、腹部B超		1
3、腹部X线平片检查		1
4、腹部CT		1
五、治疗原则	4	
1、急诊手术治疗		2
2、戒烟，控制体重		1
3、长期降压治疗		1

22.腹部闭合性损伤

(1) 肝破裂

病历摘要

"患者，男性，30岁，高处坠落伤伴右上腹痛3小时

患者于3小时前不慎从4米高架上跌落，右下胸部着地。伤后自觉右上腹部胀痛剧烈，难以用力呼吸。有口渴感，四肢稍凉，被家属送入医院救治。

查体：T37.3℃，P125次/分，BP75/50mmHg。神志尚清楚，贫血貌，表情痛苦，头部冷汗，四肢发凉。右下胸部压痛明显，有片状淤血，未触及骨擦音和骨擦感。腹部外形正常，全腹有压痛、反跳痛、肌紧张，以右上腹最为显著，移动性浊音(+)，肠鸣音弱。

辅助检查：外周血血红蛋白85g/L，白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，血小板 $300 \times 10^9/L$ 。B超提示肝右膈面存在液性暗区，肠间隙增宽。立位腹部X片未见膈下游离气体。

要求:根据以上病历摘要，将初步诊断、诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。"

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	4	
1、腹部闭合性损伤		1
2、肝破裂		2
3、失血性休克		1
二、诊断依据	5	
1、腹部闭合性损伤：肝破裂	4	
(1) 年轻男性，右下侧胸部及上腹部外伤3小时，伤后感右上腹疼痛。		1
(2) 查体：P125次/分，BP75/50mmHg，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，以右上腹明显，移动性浊音(+)，肠鸣音弱。		2
(3) Hb 85g/L，白细胞升高，B超提示肝右膈面有液性暗区，肠间隙增宽。		1
2、失血性休克	1	
(1) 上腹部外伤史，疑似肝破裂。		0.5
(2) 脉搏增快，BP75/50mmHg，面色苍白，头部冷汗，四肢发凉。		0.5
三、鉴别诊断	4	
1、脾破裂		1.5
2、肠破裂		1.5

3、胸部闭合性损伤，肋骨骨折		1
四、进一步检查	4	
1、诊断性腹腔穿刺		1
2、胸部X线		1
3、腹部CT		1
4、尿常规		1
五、治疗原则	5	
1、严密观察病情，监测生命体征		1
2、输液输血，补充血容量，抗休克		1
3、急诊手术--剖腹探查+止血		2
4、应用抗生素预防感染		1

(2) 脾破裂

病历摘要

"男性，15岁。左季肋部外伤12小时。"

患者12小时前在足球场踢球时，不慎被球友踹伤左季肋部，当时左上腹疼痛剧烈，立即至就近医院就诊，X光片证实存在左肋骨骨折，卧床休息和局部固定后病情未见好转，后转入我院急诊治疗。目前自述全腹疼痛，伴头晕、心慌，3小时来口渴、烦躁。

既往体健，无药物过敏史。

查体:T37.6°C，P115次/分，BP85/55mmHg。神志清楚，贫血貌，心肺(-)。腹略膨隆，全腹有压痛，以左上腹为著，存在明显反跳痛，双肾区无叩痛，移动性浊音(±)，肠鸣音减弱。

实验室检查:Hb82g/L，WBC9.0×10⁹/L。

要求:根据以上病历摘要，将初步诊断、诊断依据(如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。"

要求: 根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据(如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	5	
1、腹部闭合性损伤：脾破裂		2
2、失血性休克		2
2、肋骨骨折		1
二、诊断依据	4	

1、左季肋部外伤史。		1
2、腹略膨隆，全腹有压痛，以左上腹为著，存在明显反跳痛。		1
3、出现口渴，贫血貌，Hb82g/L，BP85/55mmHg。		1
4、胸部X线片证实有肋骨骨折。		1
三、鉴别诊断	5	
1、单纯肋骨骨折及软组织挫伤		2
2、其他腹腔脏器损伤（肝、小肠、肾脏）		2
3、血胸		1
四、进一步检查	4	
1、腹部B超		1
2、胸部X线		1
3、腹部X线		1
4、腹腔穿刺		1
五、治疗原则	4	
1、严密观察病情，监测生命体征		1
2、输液输血，补充血容量，抗休克		2
3、开腹探查，脾切除		1

（3）肠破裂

病历摘要		
"男性，26岁。石块击中腹部10小时，腹痛、腹胀逐渐加重5小时。 患者10小时前因车祸被石块击中腹中部，自觉剧痛，休息后逐渐缓解，5小时前出现腹胀，且逐渐加重，来院就诊。 查体：T37.8℃，P90次/分，BP120/80mmHg。神志清楚，查体合作，头、颈、心脏、肺未见异常，腹稍胀，腹式呼吸减弱，脐周可见挫伤痕迹，全腹均有压痛，而以腹中部最重，腹肌稍紧张，反跳痛较明显，肝浊音界存在，移动性浊音（±），肠鸣音弱。 辅助检查化验：Hb120g/L，WBC11×10⁹/L。腹部X线平片：膈下未见明显游离气体，B超示肠间隙增宽。腹腔穿刺有少量淡黄色液体。		
要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。		
评分标准		总分 22 分
一、初步诊断	5 分	
1、腹部闭合性损伤		3

2、肠管破裂（小肠破裂可能性大）		2
二、主要诊断依据	4	
1、腹中部直接受外力外伤史		1
2、腹痛、腹胀逐渐加重		1
3、存在腹膜刺激征		1
4、穿刺液不除外肠液		1
三、鉴别诊断	5	
1、其他空腔脏器破裂		2
2、单纯腹壁损伤		2
3、肝损伤		1
四、进一步检查	4	
1、重复腹腔穿刺		2
2、腹腔灌洗检查		2
五、治疗原则	4	
1、开腹探查		2
2、判断肠管血运情况，行破裂肠壁修补缝合或肠段切除吻合术		2

（4）肾损伤**病历摘要**

男性，42岁，右腰外伤后肉眼血尿2小时入院。

患者于2小时之前在工地不慎从3楼跌落，右腰部撞在地上一堆木材上。患者随即感到右腰部疼痛难忍，无恶心、呕吐等症状。伤后排尿两次，色鲜红并有少量血块，无尿痛。急诊收入我院治疗。

既往体健，否认肝炎、结核及肾脏病病史，无遗传病家族史。

查体：T37.5℃，P90次/分，R19次/分，BP95/65mmHg。神智清楚，查体合作，痛苦病容。腹部略膨隆，上腹部压痛明显，肝脾未肿大，未触及包块，移动性音阴性，肠鸣音明显减弱。右腰部大片皮下瘀斑，局部肿胀，触痛明显，膀胱区叩诊浊音，尿道口可见少量血迹。

实验室检查：血常规RBC $4.5 \times 10^{12}/L$ ，Hb115g/L，WBC $6.8 \times 10^9/L$ ；肾B超提示右肾显影不清，包膜欠完整，肾周存在环状低回声。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分 22 分
-------------	----------------

一、初步诊断	5	
右肾外伤		
二、诊断依据	4	
1、中年男性，右腰部外伤2小时，伤后出现肉眼血尿。		2
2、查体：痛苦病容。腹部略膨隆，上腹部压痛明显，右腰部大片皮下瘀斑，局部肿胀，触痛明显，膀胱区叩诊浊音，尿道口可见少量血迹。		1
3、肾B超提示右肾显影不清，包膜欠完整，肾周存在环状低回声		1
三、鉴别诊断	5	
1、肝破裂		3
2、肠破裂		2
四.进一步检查	4	
1、尿路造影		2
2、CT扫描		1
3、尿常规		1
五、治疗原则	4	
1、绝对卧床，观察生命体征		1
2、抗休克、抗感染治疗及对症处理		1
3、时刻监测腰部肿块范围有无变化，观察尿液的颜色变化，监测血常规		1
4、症状无改善或加重，手术探查		1

(四) 泌尿系统 (含男性生殖系统)

1. 急性肾小球肾炎

病历摘要

男性，20岁，发热伴咽痛3周，水肿伴血尿3天。

患者3周前着凉后出现发热，体温38℃，伴咽痛，口服头孢类抗生素后好转。3天前无明显诱因出现晨起颜面部水肿，晨重暮轻，逐渐加重至下肢水肿，尿色洗肉水样，无尿频、尿急、尿痛，尿量较前无明显改变。病来无咳嗽、咳痰，无恶心、呕吐，无腹痛、腹泻，无口腔溃疡、关节痛、皮疹、光过敏、脱发。否认肝炎、结核病史。

否认高血压、糖尿病、肾脏病病史及其家族史。

查体：T36.8℃，P78bpm，R14bpm，BP150/92mmHg。皮肤未见出血点及皮疹，浅表淋巴结无肿大。双眼睑水肿，双侧扁桃体I度大。双肺未闻及干湿性啰音。心律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平软、无压痛，肝脾肋下未触及。移动性浊音阴性。双下肢水肿，指压痕阳性。

实验室检查：血常规：WBC7.2*10⁹/L，Hb133g/L，PLT156*10⁹/L。肌酐67umol/L。白蛋白39.3g/L，总蛋白59.4g/L。补体C3 0.38g/L，ASO290IU/ml。尿常规：蛋白+，RBC90/Hp，WBC2/Hp。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
急性肾小球肾炎		4
二、主要诊断依据	5	
1. 少年男性，急性起病，发病前3周内前驱感染史（发热、咽痛）		1.5
2. 水肿：颜面部水肿，晨重暮轻，逐渐出现下肢水肿。		1
3. 查体：BP150/92mmHg，双下肢水肿，指压痕阳性。		1
4. 血尿：尿色洗肉水样，尿常规提示红细胞增多。		1
5. 蛋白尿：尿常规提示尿蛋白+		0.5
三、鉴别诊断	4	
1. 慢性肾小球肾炎		1.5
2. 急进性肾小球肾炎		1.5
3. 继发性肾小球疾病		1
四、进一步检查	5	
1. 尿相差显微镜检查、24小时尿蛋白定量检查、尿微量蛋白		1

2.监测肾功能		0.5
3.肾脏B超检查		1
4.必要时肾活检		1
5.补体、抗链球菌溶血素“O”		1
6.乙肝病毒免疫标志物，抗核抗体谱检查		0.5
五、治疗原则	4	
1.休息，限制水、盐摄入。		1
2.对症治疗：利尿消肿、降血压。		2
3.如果肾功能进行性恶化发生急性肾损伤，必要时可采用透析治疗		1

2.慢性肾小球肾炎

病历摘要

男性，25岁，反复双下肢水肿3年。

患者3年前着凉后出现双下肢水肿，无尿量及尿色改变，就诊于当地医院，查尿常规：蛋白2+、红细胞9/Hp，口服肾复康等药物治疗后好转。其后规律复查，尿蛋白波动在+~++之间，于劳累后可加重。今为进一步诊治收入院。病来无咳嗽、咳痰，无恶心、呕吐，无腹痛、腹泻，无尿频、尿急、尿痛，无口腔溃疡、关节痛、皮疹、光过敏、脱发。否认肝炎、结核病史。发现血压升高2年，最高血压160/70mmHg，平素口服降压药物，血压控制在130/85mmHg。

否认糖尿病、肾脏病病史，否认高血压家族史、否认肾脏病家族史。

查体：T36.8℃，P78bpm，R14bpm，BP145/92mmHg。皮肤未见出血点及皮疹，浅表淋巴结无肿大。双眼睑水肿。双肺未闻及干湿性啰音。心律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平软、无压痛，肝脾肋下未触及。移动性浊音阴性。双下肢水肿，指压痕阳性。

实验室检查：血常规：WBC $7.2 \times 10^9/L$ ，Hb133g/L，PLT $156 \times 10^9/L$ 。肌酐67umol/L。白蛋白39.3g/L，总蛋白59.4g/L。尿常规：蛋白+，RBC25/Hp，WBC2/Hp。尿相差显微镜检查：80%畸形红细胞。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
慢性肾小球肾炎		3
肾性高血压		1
二、主要诊断依据	5	
1.慢性肾小球肾炎		
①青年男性，慢性起病，病史3年。		1
②水肿：眼睑及双下肢水肿，反复发作。		1
③查体：BP145/92mmHg，双下肢水肿，指压痕阳性。		1
④尿常规提示蛋白尿、镜下血尿。相差显微镜提示畸形红细胞80%。		1
2.肾性高血压		
青年男性，肾病先于高血压出现，否认高血压家族史。		1
三、鉴别诊断	4	
继发性肾小球疾病		1.5

高血压肾损害		1.5
无症状性血尿、蛋白尿		1
四、进一步检查	5	
24小时尿蛋白定量检查、尿微量蛋白		1
监测肾功能、离子		0.5
肾脏B超检查、眼底、心彩超		1
必要时肾活检		1
补体、抗链球菌溶血素“O”		0.5
乙肝病毒免疫标志物，抗核抗体谱检查，抗肾小球基底膜抗体		1
五、治疗原则	4	
限制水、盐摄入。		1
降血压，首选ACEI或ARB类药物（使用同时监测肾功、离子）。		1
根据肾活检病例类型酌情给予免疫抑制治疗。		1
避免劳累、感染、肾毒性药物等慢性肾脏病加重因素。		1

3.尿路感染

病历摘要

女性，40岁。尿频、尿急、尿痛1周，肉眼血尿3天。

病人1周前着凉后出现尿频、尿急、尿痛，近3日尿色发红，无凝血块，无发热及腰痛。既往2型糖尿病病史，口服降糖药物治疗，血糖控制情况不详。尿频、尿急病史3年，每年均有发作，不发热，口服抗生素治疗症状缓解。无高血压、肾病病史。

查体：T36.2℃，P80次/分，R14次/分，BP116/62mmhg。皮肤未见皮疹及出血点，浅表淋巴结未触及肿大，睑结膜无苍白，巩膜无黄染，咽无充血，扁桃体无肿大，双肺未闻及干湿啰音。心界不大，心率80次/分，律齐，各瓣膜未闻及杂音。腹部平软，无压痛，肝脾肋下未触及，Murphy征阴性，麦氏点无压痛。双侧肾区无叩痛，双下肢无浮肿。

实验室检查：血常规Hb131g/L，WBC7.1×10⁹/L。血生化：Glu13.1mmol/L，BUN6.8mmol/L，Cr82μmol/L。尿常规：Glu(++)，RBC220~240/HP，WBC50~60/HP，亚硝酸盐(++)，白细胞管型(-)

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.急性膀胱炎。		3
2.2型糖尿病。		1
二、主要诊断依据	5	
1.急性膀胱炎。		
（1）中年女性，急性起病，2型糖尿病病史。		1
（2）症状：尿频、尿急、尿痛、无发热、无腰痛。		1
（3）体征：双侧肾区无叩痛。		0.5
（4）尿白细胞增多，亚硝酸盐(++)，白细胞管型(-)。		1.5
2.2型糖尿病		
既往糖尿病：既往糖尿病病史，血糖13.1mmol/L，尿糖(++)。		1
三、鉴别诊断	4	
1.急性肾盂肾炎。		1
2.慢性肾盂肾炎。		1
3.泌尿系统结核。		1

4.泌尿系统肿瘤。		1
四、进一步检查	5	
1.尿细菌培养+药敏。		1.5
2.尿β ₂ 微球蛋白、尿渗透压、尿NAG。		1.5
3.尿沉渣抗酸染色、PPD试验。		1
4.泌尿系统彩超检查。		1
五、治疗原则	4	
1.多饮水，不憋尿。		1
2.控制血糖。		1
3.抗感染治疗：经验性选择针对G-抗生素，尿培养及药敏结果回报后根据结果调整用药。		2

4.尿路结石

病历摘要

男性，36岁，左侧腰痛2周，突然加重1小时。

病人于2周前无明显诱因出现左侧腰部持续性疼痛，与活动体位无关，尚可耐受，未诊治。1小时前剧烈活动后突然出现左侧腰部剧烈疼痛，不能忍受，向下腹部及会阴部放散，伴尿频、尿色红、恶心，未呕吐。病来无发热，无尿急尿痛，无排尿困难，大便正常。2个月前曾于饮酒后发作左足第一跖趾关节疼痛，未治疗。否认肝炎、结核等病史。吸烟20年，10支/日，饮酒20年。

查体：T36.8℃，P91次/分，R18次/分，BP139/76mmhg。痛苦病容，皮肤未见皮疹及出血点，浅表淋巴结未触及肿大，睑结膜无苍白，巩膜无黄染，甲状腺无肿大，咽无充血，扁桃体无肿大，双肺未闻及干湿啰音。心界不大，心率91次/分，律齐，各瓣膜未闻及杂音。腹部平软，左侧输尿管走行区深压痛，肝脾肋下未触及，Murphy征阴性，麦氏点无压痛。左肾区叩痛明显，四肢关节无肿胀畸形，无皮下结节，双下肢无浮肿。

实验室检查：血常规Hb135g/L，WBC7.8×10⁹/L，PLT230×10⁹/L。尿常规：RBC满视野/HP，WBC3~5/HP。血生化：BUN6.2mmol/L，Cr82μmol/L，尿酸556μmol/L

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
1.左侧上尿路结石。		2
2.痛风。		1
二、主要诊断依据	6	
1.左侧上尿路结石。		
（1）中年男性，左侧腰痛胀痛，急性加重。		1
（2）活动后出现左侧腰部剧烈绞痛，向下腹部及会阴部放散。		1
（3）既往有疑似痛风性关节炎发作。		1
（4）查体：左侧肾区叩痛明显，左侧输尿管走行区深压痛。		1
（5）镜下血尿。		1
2.痛风		
（1）饮酒后出现跖趾关节炎症状。		0.5
（2）血尿酸增高。		0.5
三、鉴别诊断	4	

1.急性阑尾炎。		1
2.胆石病。		1
3.急性肾盂肾炎。		1
4.输尿管肿瘤。		1
四、进一步检查	4	
1.泌尿系统彩超。		1.5
2.KUB平片或泌尿系统CT平扫。		1.5
3.尿红细胞畸形率。		1
五、治疗原则	5	
1.对症治疗：解痉、镇痛、排石。		1
2.一般治疗：多饮水、勤活动，促进排石；低嘌呤饮食、降尿酸。		1
3.体外冲击波碎石治疗。		1
4.输尿管镜或者经皮肾镜碎石取石术。		1
5.开放手术。		1

5. 良性前列腺增生症

病历摘要

男性，75岁。排尿困难8年，加重1天。

病人8年前无明显诱因出现排尿困难，伴尿频、尿急、尿线细、尿分叉、尿不尽。夜尿增多明显，6-8次/夜。昨日饮酒后排尿困难加重，排尿次数增多，约10分钟1次，每次排尿量少。并逐渐无法自行排尿，出现尿失禁。病来无发热及肉眼血尿，大便正常，体重无明显改变。既往无高血压、糖尿病病史，无肝炎、结核病史。

查体：T36.1℃，P73次/分，R15次/分，BP132/81mmHg。皮肤未见皮疹及出血点，浅表淋巴结未触及肿大，睑结膜无苍白，巩膜无黄染，甲状腺无肿大，咽无充血，扁桃体无肿大，双肺未闻及干湿啰音。心界不大，心率73次/分，律齐，各瓣膜未闻及杂音。下腹部膨隆，耻骨上可触及球形包块，按之有尿感。肝脾肋下未触及，Murphy征阴性，麦氏点无压痛。双侧肾区无叩痛，双下肢无浮肿。直肠指检：前列腺Ⅲ度大，表面光滑，质韧，无明显触痛，中央沟浅，肛门括约肌张力正常。

实验室检查：血常规Hb122g/L，WBC5.8×10⁹/L，PLT231×10⁹/L。血生化：BUN7.2mmol/L，Cr99μmol/L。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
1. 良性前列腺增生。		2
2. 急性尿潴留。		1
二、主要诊断依据	5	
1. 良性前列腺增生。		
（1）老年患者，慢性病程，急性加重。		1
（2）排尿困难，尿频、尿急、夜尿增多，饮酒后加重。		1
（3）直肠指检：前列腺Ⅲ度大，表面光滑，质韧，无明显触痛，中央沟浅，肛门括约肌张力正常。		1
2. 急性尿潴留。		
（1）饮酒后无法排尿，下腹胀痛，尿失禁。		1
（2）下腹部膨隆，耻骨上触及球形包块，触之有尿感。		1
三、鉴别诊断	4	
1. 前列腺癌。		1
2. 尿道狭窄。		1

3.神经源性膀胱功能障碍。		1
4.膀胱颈挛缩。		1
四、进一步检查	5	
1.泌尿系统及前列腺彩超。		2
2.前列腺特异性抗原（PSA）测定。		2
3.尿流动力学检查。		1
五、治疗原则	5	
1.留置尿管或耻骨上膀胱穿刺造瘘术。		2
2.α1受体阻滞剂，5α-还原酶抑制剂治疗。		2
3.手术治疗。		1

6.慢性肾脏病（慢性肾衰竭）

病历摘要

男性，55岁，反复双下肢水肿5年，乏力1个月。

患者5年前着凉后出现双下肢水肿，无尿量及尿色改变，就诊于当地医院，查尿常规：蛋白3+、红细胞19/Hp，口服肾复康等药物治疗后好转。其后规律复查，尿蛋白波动在+~++之间，于劳累后加重，休息后可好转。2年前复查时发现肌酐300umol/L，尿量较前无明显改变，口服羟苯磺酸钙、药用炭等药物治疗。其后间断复查肌酐波动于至500umol/L左右。近1个月劳累后乏力明显。今为进一步诊治收入院。病来无咳嗽、咳痰，偶有恶心、未吐，无腹痛、腹泻，无尿频、尿急、尿痛，尿色正常，24小时尿量1000ml，无口腔溃疡、关节痛、皮疹、光过敏、脱发。否认肝炎、结核病史。发现血压升高3年，最高血压160/70mmHg，平素口服降压药物，血压控制在130/85mmHg。否认糖尿病、肾脏病病史，否认高血压家族史、否认肾脏病家族史。

查体：T36.8℃，P78bpm，R14bpm，BP155/92mmHg。贫血貌，结膜略苍白，皮肤未见出血点及皮疹，浅表淋巴结无肿大。双眼睑水肿。双肺未闻及干湿性啰音。心律齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。腹平软、无压痛，肝脾肋下未触及。移动性浊音阴性。双下肢水肿，指压痕阳性。

实验室检查：血常规：WBC7.2*10⁹/L，Hb72g/L，PLT156*10⁹/L。肌酐767umol/L，估算肾小球滤过率6.2ml/min/1.73m²。白蛋白39g/L，总蛋白59.4g/L。离子：钙1.89mmol/L、磷2.3mmol/L、碳酸氢根15.4mmol/L，便潜血阴性。尿常规：蛋白+，RBC10/Hp，WBC2/Hp。尿相差显微镜检查：80%畸形红细胞。泌尿系超声：双肾体积缩小，血流显示率3级。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
慢性肾脏病（5期）或 慢性肾衰竭，尿毒症期		1
慢性肾小球肾炎		1
肾性贫血		1
肾性高血压		1
二、主要诊断依据	5	
1. 慢性肾脏病（5期）或 慢性肾衰竭，尿毒症期		
①病史：慢性起病，反复水肿5年，肌酐升高2年。		0.5
②症状：高血压、夜尿增多、恶心、乏力。		0.5
③查体：眼睑及双下肢水肿，贫血貌、结膜苍白，		0.5

④化验：肌酐767 μ mol/L，估算肾小球滤过率6.2ml/min/1.73m ² 。伴低钙高磷：钙1.89mmol/L、磷2.3mmol/L，伴酸中毒：碳酸氢根15.4mmol/L，伴贫血：Hb72g/L。泌尿系超声：双肾体积缩小，血流显示率3级。		0.5
2. 慢性肾小球肾炎		
①男性，慢性起病，病史5年。		0.5
②水肿：双下肢水肿，反复发作。		0.5
③查体：BP155/92mmHg，眼睑及双下肢水肿，指压痕阳性。		0.5
④尿常规提示蛋白尿、镜下血尿。相差显微镜提示畸形红细胞80%。		0.5
3.肾性贫血		
慢性肾衰竭病史，血常规提示贫血，便潜血阴性		0.5
4.肾性高血压		
男性，肾病先于高血压出现，否认高血压家族史。		0.5
三、鉴别诊断	4	
继发性肾小球疾病		1
高血压肾损害		1
急性肾损伤或急性肾衰竭		1
消化系统肿瘤		1
四、进一步检查	5	
24小时尿蛋白定量检查、尿微量蛋白		1
监测肾功能、离子		0.5
眼底、心彩超		1
甲状旁腺激素、肿瘤系列、贫血系列、血清铁、转铁蛋白		1
肺部影像学、心功能		0.5
乙肝病毒免疫标志物，抗核抗体谱检查，抗肾小球基底膜抗体		1
五、治疗原则	4	
低盐低脂，优质低蛋白饮食。监测血压、血生化		0.5
降血压，监测血压。		1
纠正贫血：补充造血原料、促红细胞生成素。		1
纠正水、电解质、酸碱平衡紊乱。		1
必要时肾脏替代治疗。		0.5

（五）女性生殖系统

- 1.异位妊娠
- 2.盆腔炎性疾病
- 3.子宫颈癌
- 4.子宫肌瘤
- 5.卵巢癌
- 6.卵巢囊肿蒂扭转或破裂
- 7.前置胎盘
- 8.胎盘早剥
- 9.妊娠期高血压疾病
- 10.自然流产
- 11.子宫内膜癌
- 12.产后出血
- 13.子宫内膜异位症

(六) 血液系统

1. 缺铁性贫血

病历摘要

女性，28岁。头晕、乏力半年，加重伴活动后气短半个月。

患者半年前无明显诱因出现头晕、乏力，家人发现面色不如以前红润，一直未予诊治。近半个月来加重，伴活动后气短，曾到医院检查示血红蛋白减低（具体不详）。无鼻出血和牙龈出血，发病以来睡眠正常，但食肉少，大小便正常，无鲜血便和黑便，尿色正常，体重无明显变化。既往无胃肠道疾病、肝病和痔疮病史。结婚4年半，连续妊娠2次，分别足月分娩两次，后一次分娩时出血较多，均行母乳喂养，现正在哺乳中。平时爱喝咖啡，无遗传病家族史。

查体：T36.3℃，P105次/分，R18次/分，BP110/70mmHg。贫血貌，睑结膜和口唇苍白，皮肤未见出血点和皮疹，浅表淋巴结未触及肿大，巩膜未见黄染。双肺未闻及干湿啰音。心界不大，心率105次/分，心律整齐，心尖部可闻及2/6级收缩期吹风样杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未触及。双下肢无水肿。

实验室检查：血常规 Hb 66g/L，MCV 71fl，MCH 24pg，MHC 29%，WBC $5.5 \times 10^9/L$ ，N 0.70，L 0.27，M 0.03，PLT $380 \times 10^9/L$ ，Ret 0.015。尿蛋白（-），尿镜检（-），粪隐血（-）。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
缺铁性贫血。（答出“贫血待查”得2分）		
二、主要诊断依据	5	
有头晕、乏力、面色苍白、活动后气短等贫血症状。		1
2. 连续两次妊娠，最近一次分娩时出血较多，均行母乳喂养。平时爱喝咖啡。		1.5
3. 查体：贫血貌，睑结膜和口唇苍白，心率快，心尖部可闻及2/6级收缩期吹风样杂音。		1
4. 血常规呈小细胞低色素性贫血，白细胞总数、分类及网织红细胞均正常。		1.5
三、鉴别诊断	4	
慢性病性贫血		1
2. 铁幼粒细胞性贫血		1

3.地中海贫血		1
4.巨幼细胞性贫血		1
四、进一步检查	5	
血涂片观察红细胞形态。		0.5
2.血清铁、铁蛋白和总铁结合力测定。		2
3.骨髓细胞学检查和铁染色。		1.5
4. 血清叶酸和维生素B12测定。		0.5
5. 腹部B超。		0.5
五、治疗原则	4	
调整饮食，禁饮咖啡。		1
2. 补充铁剂。		2.5
3.必要时输注浓缩红细胞。		0.5

2.再生障碍性贫血

病历摘要

女性,28岁。发现牙龈出血、皮肤瘀斑半个月,发热5天。

半个月前患者无明显诱因发现牙龈出血,周身皮肤散在出血点和瘀斑,无乏力、发热、关节肿痛、口腔溃疡等,未就诊,1周前来月经,经量较前明显增多,淋漓不尽。患者感头晕、乏力、耳鸣,活动后明显。5天前出现发热、咳嗽,咳黄白色黏痰,咽部疼痛不适,体温38~39℃,于当地医院就诊,查血常规示“血细胞减少”,给予输血治疗后头晕、乏力有所好转,但仍发热,急诊收入院。患病以来精神、食欲差,睡眠可,体重无明显变化,大便正常。既往体健,否认肝炎、结核病史,家族史无特殊。

查体: T39.3℃, P112次/分, R20次/分, BP105/60mmHg, 重度贫血貌, 四肢散在出血点和多处瘀斑, 口腔血泡。浅表淋巴结未触及肿大, 巩膜无黄染, 胸骨无压痛, 右肺底可闻及少量湿啰音。心界不大, 心率112次/分, 心律整齐, 心尖部可闻及2/6级收缩期吹风样杂音。腹软, 肝脾肋下未触及。

实验室检查: 血常规 Hb 51g/L, RBC $1.65 \times 10^{12}/L$, WBC $1.4 \times 10^9/L$, N 0.36, L 0.62, PLT $18 \times 10^9/L$, 网织红细胞绝对计数 $14.6 \times 10^9/L$, 肝肾功能正常。

要求: 根据以上病历摘要, 请将初步诊断及诊断依据(如有两个或以上诊断, 应分别列出各自诊断依据)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.再生障碍性贫血。(答“全血细胞减少”得1分)		3
2.肺部感染。		1
二、主要诊断依据	5	
1.再生障碍性贫血		
(1) 以出血、乏力、发热为主要症状, 进行性加重		1
(2) 查体: T39.3℃、重度贫血貌, 皮肤有出血点和瘀斑, 口腔血泡, 心率快, 肝脾不大。		1
(3) 血常规提示全血细胞减少, 白细胞分类中淋巴细胞比例增高, 网织红细胞计数减低。		1.5
2.肺炎		
(1) 急性起病, 发热、咳嗽、咳黄白黏痰		1
(2) 右肺底可闻及少量湿啰音		0.5

三、鉴别诊断	4	
阵发性睡眠性血红蛋白尿		1
2.骨髓增生异常综合征		1
3. 急性白血病		1
4. 巨幼细胞性贫血		1
四、进一步检查	5	
1.骨髓细胞学检查。		1
2.骨髓活检病理学检查。		1
3.胸部X线片。		1
4.血Ham实验、Coombs实验。		1
5.血清转铁蛋白和叶酸、维生素B12测定。		1
五、治疗原则	4	
1.对症支持治疗，如成分输血。		0.5
2.控制感染。		1
3.免疫抑制剂治疗。		0.5
4.雄性激素治疗。		0.5
5.中医中药治疗。		0.5
6.确诊后有条件者行异基因造血干细胞移植。		1

3.急性白血病

病历摘要

男性，45岁。发热、咳嗽2周，加重伴出血倾向1周。

2周前无明显诱因出现发热，最高39.5℃，伴咽痛，咳嗽，咳少量黄痰，自服“抗生素”后稍好转。1周前咳嗽加重，咳痰中带血丝，伴鼻出血（量不多）和皮肤出血点，多处瘀斑，乏力。在外院化验血常规：Hb 86g/L，WBC $1.8 \times 10^9/L$ ，PLT $25 \times 10^9/L$ ，诊断未明转来我院。病后无尿血和便血，进食少，睡眠差。

既往：体健，无肝肾疾病和结核病史。

查体：T 38.5℃，P 99次/分，R 20次/分，Bp 118/76mmHg。皮肤散在出血点和瘀斑，浅表淋巴结不大，巩膜无黄染，咽充血（+），扁桃体I度大，无分泌物，甲状腺不大，胸骨有轻压痛。心界不大，心率99次/分，心律齐，无杂音。右下肺可闻及少量湿啰音。腹平软，肝脾肋下未触及，双下肢无浮肿。

化验：Hb 90g/L，WBC $2.8 \times 10^9/L$ ，分类：原始粒0.12，早幼粒0.28，中幼0.08，分叶0.08，淋巴0.4，单核0.04，PLT $30 \times 10^9/L$ ；骨髓增生极度活跃，早幼粒0.91，红系0.015，全片见一个巨核细胞。过氧化酶染色强阳性；凝血检查：PT 19.9s，对照 15.3s，纤维蛋白原 1.5g/L，FDP 180mg/L（对照5mg/L）。3P试验阳性，大便隐血（-），尿蛋白微量，胸片（-）。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	5	
1.急性早幼粒细胞白血病。		2
2.弥散性血管内凝血（DIC）。		2
3.右肺感染。		1
二、主要诊断依据	4	
1.急性早幼粒细胞白血病：		
（1）发病急，有贫血、发热、出血；		0.5
（2）查体：皮肤散在出血点和瘀斑，胸骨有压痛；		0.5
（3）血常规呈全血细胞减少，白细胞分类见幼稚粒细胞，以早幼粒细胞为主；		0.5
（4）骨髓检查支持急性早幼粒细胞白血病。		0.5
2.DIC		
（1）早幼粒细胞白血病易并发DIC；		0.5

(2) 全身多部位出血;		0.5
(3) 化验PT延长, 纤维蛋白原降低, FDP增高,3P试验阳性。		0.5
3. 肺炎: 发热、咳嗽, 右下肺有湿啰音。		0.5
三、鉴别诊断	5	
1.急性淋巴细胞白血病		2
2.急性单核细胞白血病		1
3.再生障碍性贫血		1
4.流行性出血热		1
四、进一步检查	4	
1.骨髓细胞免疫学检查。		1.5
2.细胞遗传学检查: 染色体和融合基因检查。		1.5
3.X线胸片/肺CT+痰细菌学检查。		1
五、治疗原则	4	
1.维A酸和亚砷酸治疗。		1.5
2.DIC治疗: 小剂量肝素、补充凝血因子及血小板。		1.5
3.支持对症治疗: 包括抗生素控制感染。		1

4.淋巴瘤

病历摘要

女性,28岁。低热伴双侧颈部淋巴结肿大1个月。

患者1月前无明显诱因出现发热,最高38.0℃,伴双侧颈部淋巴结肿大,无疼痛,无盗汗、咳嗽,自服抗“头孢类抗生素”8天未见好转。1周前到本院门诊就诊,行右侧颈部淋巴结活检,今日收入院治疗。发病以来进食、睡眠好,大小便正常,体重减轻约5公斤。

既往:体健,否认传染病及接触史。无烟酒嗜好,无遗传性家族史。

查体: T37.8℃, P87次/分, R18次/分, BP128/82mmHg, 皮肤未见出血点和皮疹, 右侧颈部有手术瘢痕, 左侧颈部和右侧腹股沟区可触及2个肿大淋巴, 最大者约28mm×18mm大小, 均活动, 无压痛, 其余浅表淋巴结未触及肿大, 巩膜无黄染, 咽充血, 扁桃体不大, 颈软, 甲状腺不大。心肺检查未见异常。腹平软, 肝脾肋下未触及, 移动性浊音阴性。双下肢无水肿。

实验室检查: 血常规: Hb 125g/L, WBC $5.6 \times 10^9/L$, N 0.53, L 0.42, M 0.05, PLT $166 \times 10^9/L$ 。尿常规(-), 粪隐血(-)。

右侧颈部淋巴结活检结果: 淋巴结结构破坏, 在多种细胞成分(淋巴细胞、浆细胞、嗜酸粒细胞和原纤维细胞等)中, 见多个R-S细胞伴杯死, 细胞免疫表为CD30(+)、CD15(+)

要求: 根据以上病历摘要, 请将初步诊断及诊断依据(如有两个或以上诊断, 应分别列出各自诊断依据)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.霍奇金淋巴瘤。		2
2.混合细胞型。		1
3.III期B组。		1
二、主要诊断依据	5	
1.霍奇金淋巴瘤。		
(1) 病史: 双侧颈部进行性、无痛性淋巴结肿大伴发热		1
(2) 查体: 左侧颈部和右侧腹股沟区可触及肿大淋巴, 均活动, 无压痛。		1
(3) 左侧颈部淋巴结病理: 多个R-S细胞。		1
2. 混合细胞型: 淋巴结结构破坏, 在多种细胞成分(淋巴细胞、浆细胞、嗜酸粒细胞和原纤维细胞等)中, 细胞免疫表为CD30(+)、CD15		1

(+)。		
3.III期B组：根据目前资料病变局限于模膈两侧为III期，低热症状为B组。		1
三、鉴别诊断	4	
1.颈部淋巴结结核。		1.5
2.系统性红斑狼疮。		1.5
3.坏死性淋巴结炎。		1
四、进一步检查	5	
1.骨髓细胞学检查。		1
2.胸部X线片或CT。		1
3.腹部B超或CT。		1
4.血清学检查：乳酸脱氢酶、 $\beta 2$ 微球蛋白、免疫球蛋白及C反应蛋白。		1
5.ANA、抗EMA抗体、抗双链DNA抗体检查。		0.5
6.肝肾功能检查。		0.5
五、治疗原则	4	
1.行ABVD方案化疗。		3
2.完全缓解后可行造血干细胞移植治疗。		1

5.特发性血小板减少性紫癜

病历摘要

男性,27岁。皮肤出血点和瘀斑1周,鼻出血1小时。

患者1周前无意中发现前胸部和四肢皮肤有散在出血点,下肢有多处瘀斑,无任何不适,未系统诊治。1天前无明显诱因出现双侧鼻孔出血不止来急诊,耳鼻喉科检查见双鼻黏膜弥漫性出血,纱布棉球压迫止血。后化验血常规提示血小板减少来血液科诊治。发病以来无尿血、便血及其他部位出血,无发热、关节痛和口腔溃疡。

既往体健,否认近期服用任何药物。

查体: T 36.3℃, BP 125/75mmHg。胸部和四肢皮肤有散在出血点,下肢有多处瘀斑,均不高出皮面,未见皮疹,双鼻孔棉球填塞,口腔颊黏膜未见溃疡和血疱,牙龈无出血。浅表淋巴结未触及肿大,巩膜未见黄染,心肺未见异常,腹软,肝脾肋下未触及,关节未见异常。

实验室检查: 血常规 Hb 133g/L, WBC $7.2 \times 10^9/L$, N 0.64, L 0.33, M 0.03, PLT $5 \times 10^9/L$ 。

要求: 根据以上病历摘要, 请将初步诊断及诊断依据(如有两个或以上诊断, 应分别列出各自诊断依据)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
原发免疫性血小板减少性症。(答出“血小板减少性紫癜”得2分)		4
二、主要诊断依据	5	
1. 病史: 有皮肤和鼻出血。		1
2. 表现: 无发热、关节痛和口腔溃疡等结缔组织病的表现, 否认近期服用任何药物。		1.5
3. 查体: 皮肤见出血点和瘀斑, 双鼻孔棉球填塞, 口腔颊黏膜未见溃疡, 肝脾不大, 关节(-)		1.5
4. 辅助检查: 血小板明显减少, 血红蛋白、白细胞总数及分类正常。		1
三、鉴别诊断	4	
1. 继发性免疫性血小板减少性紫癜(如自身免疫病)		2
2. 药物性免疫性血小板减少性紫癜		2
四、进一步检查	5	
1. 骨髓细胞学检查		1.5
2. 血小板相关抗体		1
3. 血清学ANA、抗EMA抗体、抗双链DNA抗体、免疫球蛋白(IgG、		1.5

IgA、IgM)、补体(C3和C4)测定		
4. 腹部B超或CT		1
五、治疗原则	4	
1.应用糖皮质激素。		1.5
2.静脉滴注大剂量免疫球蛋白。		0.5
3.血小板成分输注。		1
4.TPO或TPO受体激动剂。		0.5
5.必要时脾切除治疗。		0.5

(七) 代谢、内分泌系统

1. 甲状腺功能亢进症

病历摘要

被检者22岁女性，心悸、多汗、手抖3个月。

被检者3个月前无明显诱因出现多汗心悸及手抖，伴多食善易饥，大便次数3-5次/天，否认稀便，未曾就诊。否认口渴多饮多尿，否认呼吸困难。发病以来，睡眠略差，小便正常，近3个月体重下降5kg。既往体健，月经规律，否认妊娠及妊娠计划。

查体：T36.5℃，P98次/分，R18次/分，BP122/78mmHg。神清语明，浅表淋巴结未触及肿大，眼球无突出，甲状腺Ⅱ度肿大，弥漫性对称，未触及结节，甲状腺双上极可闻及血管鸣。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心律不齐，116次/分，心音强弱不等，各瓣膜区未闻及杂音。腹部未见明显异常。双下肢无水肿。双手平举有震颤。

实验室检查：血常规WBC $3.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $1.9 \times 10^9/L$ ，HB121g/L，PLT $150 \times 10^9/L$ ，甲功FT3增高，FT4增高，TSH降低；肝功正常，心电图提示房颤

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1、弥漫性毒性甲状腺肿（或Graves病）		3
2、心律失常（心房颤动）		1
二、主要诊断依据	5	
1、弥漫性毒性甲状腺肿（或Graves病）		
（1）青年女性，心悸、多汗、手抖、体重下降、多食易饥，大便次数增多		1
（2）查体：甲状腺Ⅱ度肿大，弥漫性对称，甲状腺双上极可闻及血管鸣。心率快，双手震颤阳性。		1 1
（3）辅助检查：甲功FT3增高，FT4增高，TSH降低		
2、心律失常（心房颤动）		
（1）查体：心律绝对不齐，116次/分，心音强弱不等		1
（2）辅助检查：心电图提示心房颤动		1
三、鉴别诊断	4	
1、亚急性甲状腺炎		1
2、桥本甲状腺毒症		1
3、甲状腺自主高功能腺瘤		1

4、引起心房颤动的其它器质性心脏病		1
四、进一步检查	4	
1、甲状腺抗体：TPOAb TGAb TRAb		1
2、甲状腺彩超		1
3、甲状腺摄 ¹³¹ I率		2
五、治疗原则	5	
1、低碘饮食，注意休息，加强营养		2
2、抗甲状腺药物口服（甲巯咪唑或丙硫氧嘧啶）		2
3、 β 受体阻滞剂口服控制心率		1

2.甲状腺功能减退症

病历摘要

被检者65岁女性，乏力、畏寒、周身浮肿7个月。

被检者7个月前无明显诱因出现乏力、畏寒、周身浮肿，未曾就诊。发病以来精神差，食欲减退，每1-3天排大便一次，小便正常。既往体健，否认高血压、糖尿病、冠心病病史。

查体：T36.5℃，P58次/分，R18次/分，BP125/75mmHg。皮肤干燥，未见出血点及皮疹，浅表淋巴结未触及肿大，眼睑无浮肿，眼球无突出。甲状腺无肿大，未触及结节。双肺未闻及干湿性啰音。心界不大，心律齐，58次/分，各瓣膜区未闻及杂音。腹部未见明显异常。双下肢非凹陷性水肿。双手平举无震颤。

实验室检查：甲功FT3降低，FT4降低，TSH增高；

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1、甲状腺功能减退症（或原发性甲状腺功能减退症）		4
二、主要诊断依据	5	
1、老年女性，乏力、畏寒、周身浮肿7个月		2
2、查体：皮肤干燥，心率减慢，非凹陷性水肿		2
3、辅助检查：甲功FT3降低，FT4降低，TSH增高		1
三、鉴别诊断	4	
1、中枢性甲状腺功能减退症		1
2、特发性水肿		1
3、肾病综合征		1
4、单纯性肥胖		1
四、进一步检查	4	
1、甲状腺抗体：TPOAb TGAAb		2
2、甲状腺彩超		2
五、治疗原则	5	
1、低碘饮食		2
2、甲状腺激素替代治疗（左旋甲状腺素）		3

3.糖尿病

病历摘要

被检者19岁男性，口渴多饮多尿4周，恶心呕吐2天。

被检者4周前无明显诱因出现口渴多饮多尿，日饮水量约3-3.5升。小便次数增多，每天8-12次，每次尿量约400ml，无尿急尿痛等尿路刺激症状，未予重视。2天前出现乏力、恶心呕吐及腹部不适，呕吐物为胃内容物，无腹痛。为求系统诊治来我院急诊。被检者病来无发热，无呕血黑便，无反酸烧心嗝气，无咳嗽咳痰，无怕热多汗及心悸，睡眠可，大便正常，近4周体重下降4kg。

查体：T36.5℃，P108次/分，R18次/分，BP90/60mmHg。身高170cm，体重55kg。神清语明，急性病面容，自主体位，眼眶凹陷，口腔黏膜干燥，皮肤弹性差。皮肤无苍白、无黄染，无皮疹，无出血点。巩膜无黄染，睑结膜无苍白。未及浅表肿大淋巴结。呼吸略急促，呼气有烂苹果气味，双肺呼吸音粗，未闻及干湿啰音。心律齐，各瓣膜区未闻及病理性杂音。腹软，无明显压痛反跳痛及肌紧张，输尿管压痛点无压痛，肝脾肋下未及，Murphy征阴性。双肾区无叩痛。肠鸣音正常。四肢活动自如，双下肢无水肿，足背动脉搏动可。

实验室检查：血糖29mmol/L，血常规：WBC 11.5* 10⁹/L，HB125g/L，PLT160* 10⁹/L，尿糖3+，尿酮体3+，尿蛋白-，血气：pH7.15，HCO₃⁻ 12mmol/L，K⁺4.0mmol/l，Na⁺137mmol/l，Cl⁻98mmol/l。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1、1型糖尿病		2
2、糖尿病酮症酸中毒		2
二、主要诊断依据	5	
1、1型糖尿病		
（1）青年男性，有口渴多饮多尿及体重下降症状		1
（2）辅助检查：血糖增高，尿糖3+		1
2、糖尿病酮症酸中毒		
（1）急性起病，口渴多饮多尿4周，恶心呕吐2天		1
（2）查体：眼眶凹陷，口腔黏膜干燥，皮肤弹性差。呼吸略急促，呼气有烂苹果气味。		1
（3）辅助检查：血糖增高，尿糖3+，尿酮体3+，血气：pH7.15，HCO ₃ ⁻ 12mmol/L		1

三、鉴别诊断	4	
1、2型糖尿病		1
2、特殊类型糖尿病		1
3、高渗高血糖综合征		2
四、进一步检查	4	
1、糖化血红蛋白		2
2、空腹及餐后2小时血糖及胰岛素		1
3、胰岛素自身抗体		1
五、治疗原则	5	
1、大量补液		1
2、小剂量胰岛素降糖治疗		1
3、纠正电解质及酸碱失衡		1
4、防治并发症		1
5、护理		1

（八）神经系统

1.脑出血

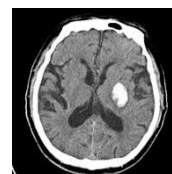
病历摘要

男性，72岁。“突发右侧肢体活动不灵1.5小时”。

患者1.5小时前情绪激动后突然出现右侧肢体活动不灵，右手持物不稳，右下肢行走拖曳，家人发现患者口角轻度左侧歪斜，急诊来院。既往有高血压史15年，不规范服用降压药物。无药物过敏及手术、外伤史。

查体：T36.4℃，P82次/分，R18次/分，BP182/115mmHg。双肺呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音。心界不大，心率82次/分，心律整齐，未闻及杂音。腹部平软，肝脾肋下未触及。神经系统：意识清晰，查体合作。双侧眼球运动正常，未见眼球震颤，两侧瞳孔直径均为3mm，对光反射灵敏。双额纹对称，右侧鼻唇沟变浅，口角轻度左偏，伸舌偏右。颈软，右上肢肌力3级，右下肢4级。左侧肢体肌力5级，右侧肱二头肌反射和膝反射亢进，左侧正常，右侧 Babinski 征阳性。右侧偏身痛觉减退。

急诊头颅CT检查：脑内左侧基底节有高密度区。



要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.左侧脑（基底节）出血（仅答出“脑出血”得2分，答“左侧基底节出血”或“左侧豆状核出血”得3分）		3
2.高血压3级很高危。（仅答出“高血压”得0.5分）		1
二、主要诊断依据	4	
1.左侧脑（基底节）出血。		
（1）症状：突发右侧肢体活动不灵，口角轻度左侧歪斜。		1
（2）查体：右侧鼻唇沟变浅，口角轻度左偏，伸舌偏右。右上肢肌力3级，右下肢4级。左侧肢体肌力5级，右侧肱二头肌反射和膝反射亢进，左侧正常，右侧 Babinski 征阳性。右侧偏身痛觉减退。		1
（3）头颅CT检查：脑内左侧基底节有高密度区		1
2.高血压3级很高危：既往高血压史15年，本次发病时BP182/115mmHg，本次诊断脑出血。		1

三、鉴别诊断	4	
1.脑梗死。		2
2.脑栓塞。		1
3.蛛网膜下腔出血。		1
四、进一步检查	4	
1.血常规、凝血功能、肝肾功能、血电解质、血糖、血脂检查。		1
2.头颅MRI检查。		1
3.脑血管检查：MRA、CTA、DSA检查。		2
五、治疗原则	6	
1. 保持安静，卧床休息2-4周，尽量避免不必要的搬动。		0.5
2.密切观察生命体征，保持呼吸道通畅。		0.5
3. 控制血压。		1
4. 降低颅内压、控制脑水肿。		1
5.止血治疗：止血药物（6-氨基己酸等）或者针对凝血功能障碍的止血药物。		1
6. 维持水、电解质平衡和补充营养，防治并发症。		0.5
7. 必要时行手术治疗。		1
8. 康复治疗。		0.5

2.脑梗死

病历摘要

男性，70岁，突然言语不清和右侧肢体活动不灵2小时

2天前，患者于日常活动时突发言语不清，右侧肢体活动不灵，不能自行行走。无意识障碍、无抽搐、无恶心呕吐。为进一步诊治就诊。既往史：高血压病史20余年，血压最高达190/110mmHg，未规律服药，血压控制不佳。无糖尿病、冠心病和房颤病史。无输血、手术、外伤史及药物食物过敏史。吸烟40余年，平均每日吸烟10支。偶有饮酒。

查体：T 36.7°C, P 82次/分，R 18次/分，BP 135/85mmHg。神志清楚，言语不清。双侧瞳孔等大正圆，D=3.0mm，光反应灵敏。双侧额纹对称，右侧鼻唇沟浅，伸舌右偏。右侧肢体肌力III级，左侧肢体肌力V级。肌张力正常。四肢腱反射存在。Babinski (L,R: -, +)。右侧面部和肢体痛觉减退。右侧深感觉障碍。

辅助检查：颅脑CT：未见明显异常。心电图未见异常。血糖正常。血甘油三酯1.58mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇4.21mmol/L，高密度脂蛋白胆固醇1.59mmol/L。血常规和凝血功能正常。



要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.急性脑梗死。		3
2.高血压3级（很高危）。		0.5
3.血脂异常。		0.5
二、主要诊断依据	6	
1.急性脑梗死		
（1）老年男性，有多个脑血管病危险因素，如高血压病史、吸烟史、血脂异常。		1
（2）急性起病，右侧中枢性面舌瘫、右侧肢体瘫痪。		2
（3）颅脑CT未见明显异常，可排除出血。		1

2.高血压3级（很高危）		
（1）血压最高190/110mmHg		0.5
（2）有多个危险因素，如高龄、吸烟、血脂异常等。		0.5
3.血脂异常：血甘油三酯1.58mmol/L，低密度脂蛋白胆固醇4.21mmol/L，高密度脂蛋白胆固醇1.59mmol/L。		1
三、鉴别诊断	2	
1.脑出血。		1
2.蛛网膜下腔出血。		1
四、进一步检查	4	
1.颅脑MRI。		1
2.头颈血管检查：颈动脉超声、经颅多普勒超声、MRA或CTA或DSA等。		1.5
3.超声心动图，动态心电图，下肢动脉超声。		1
4.同型半胱氨酸、CRP。		0.5
五、治疗原则	6	
1.血管再通治疗：rt-PA溶栓、血管内取栓治疗		1
2.抗血小板聚集治疗：溶栓24小时后复查颅脑CT排除出血后给予阿司匹林等		1
3.降脂稳定斑块：他汀类药物		1
4.营养神经和对症治疗		1
5.康复评估和治疗		1
6.二级预防：抗血小板聚集药物、他汀类药物、控制危险因素（如控制血压、血脂、戒烟限酒）、纠正不良生活方式		1

3.蛛网膜下腔出血

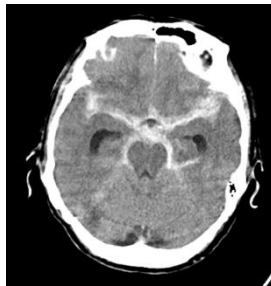
病历摘要

女性，35岁。突发剧烈头痛、呕吐1.5小时。

患者1.5小时前跑步时突感枕顶部剧烈牵拉样疼痛，伴恶心、呕吐、面色苍白，全身冷汗，呕吐呈喷射性。家属就近送急诊室。既往体健，无头痛史，无烟酒嗜好，无遗传病家族史。

查体：T36.4℃，P88次/分，R18次/分，BP130/88mmHg。双肺呼吸音清晰，未闻及干湿性啰音。心界不大，心率88次/分，心律整齐，未闻及杂音。腹部平软，肝脾肋下未触及。神经系统：嗜睡，言语无力，查体欠配合。双侧瞳孔正大等圆，对光反射存在，四肢肌力5级，肌张力正常，双侧跟腱反射、膝反射正常引出，双侧Babinski征阴性。颈项强直，双侧Kernig征阳性。

急诊头颅CT检查：环池高密度影。



要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
蛛网膜下腔出血		4
二、主要诊断依据	4	
1.症状：突发剧烈头痛、呕吐1.5小时。		1.5
2.查体：嗜睡，言语无力，查体欠配合。颈项强直，双侧Kernig征阳性。		1.5
3. 急诊头颅CT检查：环池高密度影。		1
三、鉴别诊断	4	
1.脑出血。		1
2.颅内感染：急性脑膜炎。		1
3.脑肿瘤合并出血。		1
4.颅脑外伤。		1
四、进一步检查	4	
1. 血常规、凝血功能、肝、肾功能，血电解质，血糖，血脂。		1

2.腰椎穿刺、脑脊液检查。		1
3. 脑血管检查：MRA、CTA、DSA检查。		1
4.数字减影血管造影DSA。		1
五、治疗原则	6	
1. 保持安静，卧床休息至少4周，尽量避免不必要的搬动。避免情绪激动，保持大便通畅。		1
2.密切观察生命体征，保持呼吸道通畅。		1
3.调控血压。		0.5
4.防治再出血：抗纤溶治疗。		1
5. 降低颅内压、控制脑水肿：应用甘露醇注射液或者人血白蛋白注射液。		0.5
6.防治血管痉挛：钙拮抗剂如尼莫地平注射液。		1
7.外科治疗：动脉夹闭或者血管内治疗。DSA发现动脉瘤适合手术治疗者，应争取在发病24-72小时内进行手术治疗。		1

4.急性硬膜外血肿

5.颅骨骨折

（九）运动系统

1.四肢长管状骨骨折

病例 1

病历摘要

女性，61岁。滑倒摔伤后右腕部疼痛、肿胀、畸形，活动障碍3小时。

患者3小时前走路时由于路滑不慎滑倒，右手撑地，伤后随即感觉右腕关节疼痛，不敢活动，自行发现右腕关节畸形，逐渐肿胀，紧急来我院急诊。自述未伤及他处，伤后无头晕头迷、胸痛腹痛、心慌气短、恶心呕吐，脊柱及四肢其余他处无疼痛及活动障碍。既往体健，无基础疾病。

查体：T36.8℃，P84次/分，R17次/分，BP135/87mmHg。神志清楚，痛苦面容，皮肤无破损出血点及皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。头颈无异常，双肺呼吸音清，无啰音。心界不大、心率84次/分，律齐，无杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未及，移动浊音（-）。

专科查体：右腕关节肿胀，皮肤无破损，正侧向观分别呈“枪刺”样及“银叉”样畸形，右桡骨远端压痛（+），右尺骨茎突压痛（+），右腕关节活动受限，右手感觉及自主活动、末梢血运正常。

影像检查：右腕关节正侧位X线图像如图



要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	

1.右桡骨远端骨折，Colles骨折，骨质疏松症待查。		2
2.右侧耻骨茎突骨折。		1
二、主要诊断依据	8	
1. 右桡骨远端骨折，Colles骨折，骨质疏松症待查		
①.老年女性，低能量外伤史（脆性骨折病史）明确。		1
②. 伤后右腕部疼痛、肿胀、畸形，活动障碍病史明确。		1
③.查体右腕关节肿胀，呈“枪刺”样及“银叉”样畸形。		1
④. 查体右桡骨远端压痛（+），右腕关节活动受限。		1
⑤. 右腕关节正侧位X线图像显示右桡骨远端骨质连续性中断，短缩、桡侧及背侧移位。		1
2. 右侧耻骨茎突骨折，骨质疏松症待查		
①.老年女性，低能量外伤史（脆性骨折病史）明确。		1
②. 伤后右腕部疼痛、肿胀、畸形，活动障碍病史明确；查体右尺骨茎突压痛（+）。		1
③.右腕关节正侧位X线图像显示：右尺骨茎突骨质连续性中断、移位。		1
三、鉴别诊断	3	
1.右腕关节软组织损伤		1
2.右腕骨骨折或脱位		1
3.是否为骨质疏松性骨折的鉴别		1
四、进一步检查	4	
1.右腕关节三维CT、心电图等常规检查		2
2. 骨密度测定		2
五、治疗原则	4	
1.局麻下或臂丛麻醉下手法复位后以小夹板或者石膏外固定术		2
2.复位不佳或难以维持，则行骨折切开复位内固定术		1
3.术后系统康复治疗及功能锻炼，抗骨质疏松治疗		1

病例 2

病历摘要

男性，28岁，车祸外伤后右上臂疼痛、肿胀、畸形，活动障碍4小时。

患者4小时前遭遇车祸外伤，伤及右上肢，伤后即刻感觉右上臂疼痛、肿胀、畸形，无法活动，同时伴有右手麻木活动障碍。伤后无头晕头迷、胸痛腹痛、心慌气短、恶心呕吐。既往体健，无基础疾病。

查体：T37.2℃，P86次/分，R18次/分，BP115/78mmHg。神志清楚，痛苦面容，皮肤无破损出血点及皮疹，浅表淋巴结未触及肿大。头颈无异常，双肺呼吸音清，无啰音。心界不大、心率86次/分，律齐，无杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未及，移动浊音（-）。

专科查体：右上臂中下段肿胀、成角畸形，可及反常活动及骨擦感，右腕关节、右拇指、掌指关节不能背伸，右侧虎口区皮肤感觉减退。

实验室检查：血尿常规未见异常。

影像检查：X线图像如图



要求： 根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。		
评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
右侧肱骨中下段粉碎性骨折伴右侧桡神经损伤		4
二、主要诊断依据	8	
1.青年男性，车祸外伤史明确。		1
2. 伤后右上臂疼痛、肿胀、畸形，活动障碍病史明确。		2
3.查体右上臂中下段肿胀、成角畸形，可及反常活动及骨擦感。		2
4.伤后右手麻木及活动障碍，查体右腕关节、右拇指、掌指关节不能背伸，右侧虎口区皮肤感觉减退。		2
5.右肱骨正侧位X线显示右肱骨中下段骨质连续性中断，骨折块大于3块。		1
三、鉴别诊断	3	
1.右肘关节脱位		1
2.右肱骨病理性骨折		1
3.右臂丛神经损伤		1
四、进一步检查	3	
1.右上肢肌电图		1.5
2.血型、凝血、生化及电解质等术前化验，心电图，胸片		1.5
五、治疗原则	4	
1.右肱骨骨折切开复位内固定术。		1.5
2.右桡神经探查松解术（必要时缝合术）。		1.5
3.术后系统康复治疗及功能锻炼。		1

病例 3

病历摘要

男性，33岁。车祸伤后右大腿疼痛，活动障碍3小时。

患者4小时前骑摩托车与其他车辆相撞，伤后出现右大腿疼痛肿胀、畸形，不敢活动，在患肢体发现有一伤口并大量出血，被120紧急送至我院急诊。自述未伤及他处，伤后无头晕头迷、胸痛腹痛、心慌气短、恶心呕吐，脊柱及四肢其余他处无疼痛及活动障碍。既往体健，无基础疾病。

查体：T36.4℃，P130次/分，R20次/分，BP80/60mmHg。神志清楚，表情淡漠，口唇苍白，痛苦面容。头颈无异常，双肺呼吸音清，无啰音。心界不大、心率130次/分，律齐，无杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未及，移动浊音（-）。

专科查体：右大腿肿胀，右大腿中段有一长约5cm的创口，有活动性出血，创口内可见骨折断端，局部压痛（+），可及反常活动，右足背动脉搏动减弱，右足感觉运动无明确异常。

影像检查：右股骨正侧位X线片提示右股骨中下段骨皮质不连续伴移位，有多个骨片。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.右股骨开放性、粉碎性骨折。（仅答右股骨骨折得1分）		2
2.失血性休克。		2
二、主要诊断依据	6	
1.右股骨开放性粉碎性骨折		
（1）右大腿车祸外伤史。		1
（2）右大腿肿胀，右大腿中段有一长约5cm的创口，有活动性出血，创口内可见骨折断端，局部压痛（+），可及反常活动。		1
（3）右股骨正侧位X线片提示右股骨中下段骨皮质不连续伴移位，有多个骨片。		1
2.失血性休克		
（1）右大腿外伤后出现伤口伴流血，查体有活动出血。。		1
（2）血压低，心率快。		1
（3）表情淡漠，口唇苍白。		1
三、鉴别诊断	3	

1.右下肢血管损伤		1
2.右膝关节损伤		1
3.其他部位内出血		1
四、进一步检查	4	
1.血尿常规，血型，凝血，生化离子等		2
2. 右下肢血管超声		2
五、治疗原则	5	
1.抗休克，密切观察病情变化及其他新发症状体征。		2
2.抗感染、破伤风，尽早清创，局部制动。		1
3.病情允许后行骨折切开复位内固定。		1
4.功能锻炼及康复治疗。		1

2.大关节脱位

(1) 肩关节脱位

病历摘要

男性，34岁。打篮球受伤后右肩关节疼痛活动受限2小时。

患者2小时前大篮球争抢篮板被掰伤上肢后出现右肩关节疼痛，不敢活动，以左手托持前臂紧急来急诊就诊。伤后意识清楚，无头痛胸痛腹痛、无心慌气短、无恶心呕吐，脊柱及四肢其余他处无疼痛及活动障碍。既往体健，无药物过敏史，否认基础疾病及遗传病。

查体：T36.3℃，P90次/分，R18次/分，BP125/80mmHg。神志清楚，头颈无异常，双肺呼吸音清，无啰音。心界不大、心率90次/分，律齐，无杂音。腹软，无压痛，肝脾肋下未及，移动浊音（-）。

专科查体：右侧方肩畸形，肩关节空虚，右肩关节前下、内侧可触及异常隆起，局部压痛，右肩关节弹性固定，Dugas征（+），右上肢右手感觉运动及末梢血运正常。

影像检查：右肩关节正位X线片提示右肱骨头偏离肩胛盂窝，位于喙突下方，肱骨大结节处骨皮质不连续伴移位。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
1.右肩关节前脱位（喙突下脱位）		3
2.右肱骨大结节撕脱性骨折		1
二、主要诊断依据	6	
1. 右肩关节前脱位（喙突下脱位）		
（1）典型而明确的肩关节外伤病史，伤后肩关节疼痛活动受限。		1.5
（2）查体：右侧方肩畸形，肩关节空虚，右肩关节前下、内侧可触及异常隆起，局部压痛，右肩关节弹性固定，Dugas征（+）。		1.5
（3）右肩关节正位X线片提示右肱骨头偏离肩胛盂窝，位于喙突下方。		1
2. 右肱骨大结节撕脱性骨折：外伤史明确，肩关节脱位已诊断，右肩关节正位X线片提示肱骨大结节处骨皮质不连续伴移位。		2
三、鉴别诊断	3	
1.右肱骨外科颈骨折		1
2.右键软组织损伤，肩袖损伤		1

3.伴发血管神经损伤		1
四、进一步检查	4	
1.右肩关节CT、MRI		2
2.心电图及心肺功能检查		2
五、治疗原则	5	
1.局麻下手法复位。		1.5
2.复查X线片后，三角肌固定4-5周。		1.5
3.如CT及MR或复查X线有其他异常情况，择期手术治疗。		1
4.功能锻炼及康复治疗。		1

(2) 髋关节脱位

病历摘要		
男性，34岁。车祸伤后右髋疼痛、不能活动4小时。 4小时前患者乘坐私家轿车时发生车祸伤，受伤当时患者下肢处于“跷二郎腿”状态，车辆撞击时右膝撞于前排座椅背上，随即感觉右髋部剧烈疼痛，不能活动，被120紧急送至我院急诊。病来无其他部位疼痛不适，既往体健，无药物过敏史，否认基础疾病及遗传病。 查体：生命体征平稳，全身情况良好，头颈、心肺腹部未见异常。 专科查体：右髋强迫体位，呈屈曲内收内旋畸形，右臀部隆起，右下肢短缩，右髋各方向活动均受限，右股骨大粗隆上移。右膝踝及足部各关节主动及被动活动均可，右下肢感觉正常。		
要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。		
评分标准	总分22分	
一、初步诊断	3	
右髋关节后脱位		3
二、主要诊断依据	6	
1.外伤史明确，典型受伤机制		2
2.典型的畸形体位		2
3.右下肢短缩，大粗隆上移，右臀部隆起，髋关节各向活动受限		2
三、鉴别诊断	4	
1.髋关节前脱位		1
2.髋关节中心型脱位		1
3.股骨颈骨折		1
4.股骨转子间骨折		1
四、进一步检查	4	
1.右髋正侧位X线，CT		2
2.心电图、胸片及常规化验检查		2
五、治疗原则	5	
1.无骨折或只有微小骨折片的单纯后脱位，麻醉下手法复位，皮牵引固定		2
2.如髋臼后缘有大块骨折、粉碎骨折或伴股骨头骨折，病情允许后尽早行切开复位内固定术		2

3.术后预防并发症，功能锻炼及康复治疗

1

3.颈椎病

(1) 脊髓型颈椎病

病历摘要

男性，70岁。颈肩痛10年，伴四肢麻木无力不灵活1年。

10年前患者开始出现久坐或劳累后颈肩痛，保守治疗可好转。1年前患者开始无明显诱因逐渐出现四肢麻木无力不灵活，双手精细活动能力差，动作笨拙，双下肢走路不稳，伴有“踩棉花感”，胸腹部有束带样感觉。病来无发热，饮食睡眠可，大小便正常。否认高血压、心脏病、糖尿病、脑血管病等病史，无颈部外伤史，否认家族遗传病。

查体：生命体征平稳，全身情况良好，心肺腹部未见确切异常。

专科查体：颈椎生理弯曲浅，无压叩痛，活动轻度受限，双上肢及剑突以下浅感觉迟钝，双上肢肌力3级，双下肢肌力4级，膝反射、踝反射亢进，Hoffman征（L+，R+），Babinski征（L+，R+）。

颈椎正、侧、斜位X线片：颈椎生理前凸消失，C4-6椎间隙变窄，骨质增生

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
脊髓型颈椎病。（仅答颈椎病得2分）		4
二、主要诊断依据	7	
1.老年男性，慢性病史。		2
2.四肢麻木无力伴精细活动能力下降，走路笨拙，胸腹束带感。		2
3.查体：躯体、四肢感觉减退，四肢肌力下降，腱反射亢进，病理反射阳性。		2
4.X线片检查：颈椎生理前凸消失，C5-6椎间隙变窄，骨质增生。		1
三、鉴别诊断	3	
1.神经根型颈椎病		1
2.脊髓空洞症		1
3.运动神经元病		1
四、进一步检查	4	

1.颈椎过伸过屈位		1
2.颈椎三维CT		1
3.颈椎MRI		1
4.神经电生理检查		1
五、治疗原则	4	
1.尽早手术治疗，解除脊髓压迫。		2
2.术后营养神经及康复治疗。		2

(2) 神经根型颈椎病

病历摘要

男性，54岁。颈肩部疼痛3年，加重伴左上肢放射痛2周来诊。

3年前患者开始久坐低头或劳累及姿势不适后开始出现颈部及左肩背部酸痛不适，通过休息理疗等症状可自行缓解，3年来间断发作。近2周颈肩部疼痛加重，伴左上肢放射痛及麻木至左手，头部及左上肢活动不适后有剧烈的放电样锐痛，严重影响工作及日常生活。既往体健，无基础疾病。

查体：生命体征平稳，全身情况良好，心肺腹部未见确切异常。

专科查体：被动体位，颈部生理弯曲浅，颈项部肌肉紧张，活动明显受限，左上臂前侧，前臂桡侧及桡侧两指浅感觉减退，左侧桡侧腕伸肌力量减弱，左肱二头肌反射减弱，左侧Eaton征（+），左侧Spurling征（+），双侧霍夫曼征及巴氏征阴性。

颈椎正、侧、斜位X线片：颈椎生理前凸消失，C5-6椎间隙变窄，骨质增生，相应椎间孔狭窄。

要求：根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。

评分标准	总分22分	
一、初步诊断	4	
神经根型颈椎病。（仅答颈椎病的得2分）		
二、主要诊断依据	6	
1.中年男性，慢性病史。		2
2.颈肩部伴左上肢神经根反射痛。		2
3.查体左上肢相应神经支配区感觉运动及反射异常，左侧Eaton征（+），左侧Spurling征（+）。		1

4.X线片检查：颈椎生理前凸消失，C5-6椎间隙变窄，骨质增生，相应椎间孔狭窄。		1
三、鉴别诊断	4	
1.脊髓型颈椎病		2
2.其他周围神经卡压性疾病：胸廓出口综合征，桡神经卡压征，肘管综合征，腕管综合征		2
四、进一步检查	4	
1.颈椎过伸过屈位		1
2.颈椎三维CT		1
3.颈椎MRI		1
4.神经电生理检查		1
五、治疗原则	4	
1.一般治疗：颈椎牵引，理疗，改善不良姿势及避免固定姿势过久等；		1.5
2.药物治疗：非甾体抗炎药，肌肉松弛剂及神经营养药物		1
3.手术治疗：系统保守治疗无效，严重神经损伤		1.5

4.腰椎间盘突出症

病历摘要 男性，32岁。腰痛伴左下肢放射痛5天。 患者为物流工人，5天前搬运过重货物过程中扭伤腰部，随即感觉突然腰痛不敢活动，后逐渐出现左下肢放射性疼痛，伴有麻木，行走受限，打喷嚏或咳嗽是左下肢放电样疼痛加剧，经卧床休息不见好转，今来门诊就诊。 查体：生命体征平稳，全身情况良好，心肺腹部未见确切异常。 专科查体：腰椎向左侧凸，被动体位，腰5-骶1水平左侧椎旁压痛+，叩击痛+，并向左下肢放射，腰椎活动明显受限，以前屈和左侧弯受限明显，双下肢自主活动可。左侧抬腿因疼痛受限，左侧外踝后方及左足外侧足跟痛感觉减退，左足趾屈肌力4级，左踝反射减弱，左侧直腿抬高试验20°阳性。 X线片：腰5-骶1椎间隙狭窄，椎体前缘骨质增生。	
要求： 根据以上病历摘要，请将初步诊断及诊断依据（如有两个或以上诊断，应分别列出各自诊断依据）、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸上。	
评分标准	总分22分

一、初步诊断	4	
腰椎间盘突出症（L5-S1）。（仅答“腰椎间盘突出症”得3分）		4
二、主要诊断依据	7	
1.职业特点：搬运工人；典型病史：腰部负重扭伤		2
2.扭伤后腰痛伴放射性下肢神经痛，咳嗽、打喷嚏等加腹压动作使病情加重		2
3.查体：腰部特殊体位，叩击痛伴放射痛，S1神经支配区感觉障碍、肌力轻度下降、反射减弱，左侧直腿抬高试验+		2
4.X线片检查：腰5-骶1椎间隙狭窄，椎体前缘骨质增生		1
三、鉴别诊断	4	
1.腰部肌肉拉伤、劳损		1
2.腰椎管狭窄症		1
3.梨状肌综合征		1
4.腰背筋膜炎		1
四、进一步检查	3	
1.腰椎CT		1
2.腰椎MR		1
3.神经电生理检查		1
五、治疗原则	4	
1.一般治疗：休息理疗		1
2.药物治疗：非甾体抗炎药、神经营养药、肌肉松弛剂		1
3.手术治疗：保守治疗无效或出现神经损伤或马尾神经综合症		2

（十）风湿免疫性疾病

- 1.系统性红斑狼疮
- 2.类风湿关节炎

（十一）儿科疾病

- 1.肺炎
- 2.腹泻
- 3.维生素 D 缺乏性佝偻病
- 4.小儿常见发疹性疾病

麻疹、风疹、幼儿急疹、水痘、手足口病、猩红热。

5.小儿惊厥

6.新生儿黄疸

(十二) 传染病

1.病毒性肝炎

2.细菌性痢疾

3.流行性脑脊髓膜炎

4.肾综合征出血热

5.艾滋病

(十三) 其他

1.软组织急性化脓性感染

2.急性乳腺炎

3.乳腺癌

4.一氧化碳中毒

5.急性有机磷农药中毒

6.镇静催眠药中毒